



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Stella Maris Bakara • Gustien Siahaan • Sherly Jeniawaty
Ainun Ganisia • Yuni Surya Putri • Merry Margaritha Verawaty Seu
Yuliyani

Editor: Agusri



BUNGA RAMPAI: PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis:

Stella Maris Bakara, S.Tr.Keb., M.K.M.

Gustien Siahaan, S.Keb., Bdn., M.Kes.

Sherly Jeniawaty, SST., M.Kes.

Ainun Ganisia, S.Keb., Bd., M.Keb.

Bdn. Yuni Surya Putri, S.Tr.Keb., M.Keb.

Merry Margaritha Verawaty Seu, SST., M.Keb.

Yuliyani, AMd.Keb., S.KM., M.Biomed.

Editor:

Agusri, SKM., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Penulis: Stella Maris Bakara, S.Tr.Keb., M.K.M.

Gustien Siahaan, S.Keb., Bdn., M.Kes.

Sherly Jeniawaty, SST., M.Kes.

Ainun Ganisia, S.Keb., Bd., M.Keb.

Bdn. Yuni Surya Putri, S.Tr.Keb., M.Keb.

Merry Margaritha Verawaty Seu, SST., M.Keb.

Yuliyani, AMd.Keb., S.KM., M.Biomed.

Editor: Agusri, SKM., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-20-6

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ***Bunga Rampai: Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat***. Buku ini merupakan himpunan tulisan yang mengangkat peran strategis bidan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam dinamika pembangunan kesehatan, bidan memiliki peran yang semakin kompleks dan luas, tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga sebagai pendidik, komunikator, dan agen perubahan sosial. Buku ini memuat berbagai kontribusi nyata bidan di masyarakat, antara lain dalam hal edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, kampanye pemberantasan malnutrisi, penyuluhan keluarga berencana, penanganan kesehatan mental ibu dan anak, serta peran aktif dalam program imunisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.

Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi mahasiswa, praktisi kebidanan, serta para pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Semoga kehadirannya dapat memperkuat peran bidan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor dan pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 BIDAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM KESEHATAN

MASYARAKAT	1
Stella Mrs Bakara, S.Tr.Keb., M.K.M.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Peran Bidan dalam Kesehatan Masyarakat.....	7
C. Bidan sebagai Agen Perubahan	9
D. Tantangan dan Strategi Peran Bidan dalam Kesehatan Masyarakat.....	10
E. Kesimpulan.....	12
F. Referensi	13
G. Glosarium	14

CHAPTER 2 EDUKASI KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI UNTUK

MASYARAKAT	15
Bdn. Gustien Siahaan, SST., S.Keb., M.Kes.	15
A. Pendahuluan/Prolog	15
B. Edukasi Kesehatan Seksual.....	17
C. Pentingnya Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi.....	20
D. Dampak Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Kesehatan Masyarakat	21
E. Manfaat Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi.....	22
F. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi.....	22
G. Hambatan Dalam Penerapan Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi...	23
H. Strategi Dalam Pemberian Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi	24
I. Langkah-Langkah Untuk Mewujudkan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Masyarakat.....	25
J. Simpulan	25
K. Referensi	26

CHAPTER 3 KAMPANYE PEMBERANTASAN MALNUTRISI MELALUI

PERAN BIDAN.....	29
Sherly Jeniawaty, SST., M.Kes.	29
A. Pendahuluan/Prolog	29

B. Peran Bidan Menggugah Kesadaran Gizi melalui Kampanye	30
C. Langkah-langkah Menggelar Kampanye Gizi yang Efektif.....	31
D. FAQs (Frequently Asked Questions yang berarti Pertanyaan yang Sering Diajukan) dalam Kampanye Pemberantasan Malnutrisi melalui Peran Bidan	32
E. Kampanye Peran Bidan dalam berbagai Program.....	33
F. Simpulan	36
G. Referensi	36
H. Glosarium	38

CHAPTER 4 PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG KELUARGA

BERENCANA..... 39

Ainun Ganisia, S.Keb., Bd., M.Keb.	39
A. Pendahuluan/Prolog	39
B. Macam-Macam KB.....	40
C. Keluarga Berencana dan Masalah Kesehatan Reproduksi.....	44
D. Simpulan	52
E. Referensi	53
F. Glosarium	54

CHAPTER 5 BIDAN DALAM PENANGANAN KESEHATAN MENTAL IBU

DAN ANAK DI MASYARAKAT..... 57

Bdn. Yuni Surya Putri, S.Tr.Keb., M.Keb.	57
A. Pendahuluan/Prolog	57
B. Kesehatan Mental Ibu dan Anak.....	59
C. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Ibu dan Anak.....	63
D. Peran Bidan dalam Penanganan Kesehatan Mental Ibu dan Anak.....	68
E. Simpulan	70
F. Referensi	70
G. Glosarium	74

CHAPTER 6 BIDAN DALAM PROGRAM IMUNISASI: PENINGKATAN

KETERCAPAIAN DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT 75

Merry Margaritha Verawaty Seu, SST., M.Keb.	75
A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Kebijakan Program Imunisasi	76
C. Tantangan dan Masalah dalam Pelayanan Imunisasi.....	79
D. Peran Bidan dalam Peningkatan Ketercapaian dan Edukasi Kepada Masyarakat.....	80
E. Simpulan	84

F. Referensi	84
--------------------	----

CHAPTER 7 PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA OLEH

BIDAN	87
--------------------	-----------

Yulianik, AMd.Keb., S.KM., M.Biomed.	87
---	----

A. Pendahuluan	87
----------------------	----

B. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	88
---	----

C. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	95
---	----

D. Tantangan dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	95
---	----

E. Pendidikan kesehatan reproduksi	95
--	----

F. Kesimpulan.....	98
--------------------	----

G. Referensi	98
--------------------	----

PROFIL PENULIS	101
-----------------------------	------------

CHAPTER 1

BIDAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

Stella Mrs Bakara, S.Tr.Keb., M.K.M.

A. Pendahuluan

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan perawatan kepada ibu hamil, melahirkan, perawatan ibu dan bayi baru lahir. Peran bidan sangat penting disetiap siklus kehidupan. Prinsip umum dalam filosofi kebidanan adalah pendekatan holistik, individualisasi, pemberdayaan, menghargai proses fisiologi, kolaborasi, komunikasi, mengutamakan kesejahteraan ibu dan bayi, serta perawatan yang berkelanjutan. Filosofi kebidanan berlandaskan prinsip-prinsip yang holistik dan individualistik. Bidan memandang ibu hamil, janin, dan bayi baru lahir sebagai entitas yang saling terhubung, dengan memperhatikan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual dalam perawatan. Setiap kehamilan dan persalinan dipandang sebagai pengalaman unik, sehingga bidan berupaya memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Selain itu, filosofi ini menekankan pentingnya pemberdayaan ibu hamil melalui pemberian informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan. Proses kelahiran yang alami juga dihormati dengan menghindari intervensi medis yang tidak diperlukan, kecuali ada indikasi yang jelas. Prinsip lainnya melibatkan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan untuk memastikan hasil perawatan yang positif. Kesejahteraan fisik dan emosional ibu serta bayi menjadi prioritas utama dalam praktik kebidanan. Filosofi ini juga menekankan pentingnya kontinuitas perawatan, di mana bidan terus mendampingi ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga periode pasca melahirkan, guna membangun hubungan yang konsisten dan memberikan rasa aman sepanjang proses tersebut (Lailiyah et al., 2023)

Seorang bidan dapat menjalankan praktik kebidanan dengan berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh, konselor, pendidik, pembimbing, fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Saat menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu, seorang berwenang untuk memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal, asuhan

kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal, asuhan kebidanan pada masa nifas, pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan, serta melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan. Adapun pelayanan kesehatan anak yang dapat dilakukan oleh bidan yaitu diantaranya memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi sesuai program pemerintah pusat, memantau tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak pra sekolah sekaligus deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan. Sementara itu, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang boleh dilakukan bidan yaitu melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai ketentuan (UU No.4, 2019)

Kompetensi esensial untuk Praktik Kebidanan yang diterbitkan oleh *International Confederation of Midwives* (ICM) pada 2024 adalah pedoman utama bagi bidan di seluruh dunia. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dimiliki oleh bidan untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif. Dengan pembaruan yang terus menerus, kompetensi ini tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik dalam bidang kebidanan, memastikan bahwa bidan siap menghadapi tantangan baru di bidang kesehatan seksual, reproduksi, maternal, *newborn*, dan kesehatan remaja. Tidak kalah penting ICM menyebut kategori baru yang berfokus pada *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR). Kategori ini menekankan peran bidan dalam memberikan layanan kontrasepsi, perawatan pra-konsepsi, dan aborsi yang aman sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menambah kedalaman pada peran bidan dalam mendukung kesehatan reproduksi, namun tetap dalam ruang lingkup praktik kebidanan yang sudah ada. Penambahan ini menunjukkan pentingnya peran bidan dalam memberikan layanan yang komprehensif bagi perempuan dan individu dengan kebutuhan kesehatan reproduksi. Kompetensi ini dibagi menjadi lima kategori, dimulai dengan kompetensi lintas-fungsional yang mencakup pembelajaran berkelanjutan, etika profesional, dan kolaborasi antar profesional kesehatan. Kategori ini menjadi dasar yang mendukung seluruh praktik kebidanan. Kategori lainnya meliputi perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, perawatan antenatal, perawatan saat persalinan, dan perawatan postnatal. Setiap kategori ini mencakup aspek penting dari siklus kehidupan reproduksi perempuan, memastikan bahwa bidan dapat memberikan perawatan yang holistik dan berkualitas (ICM, 2024a)

Peran bidan dalam perawatan antenatal, persalinan, dan postnatal sangat krusial. Dalam perawatan antenatal, bidan bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin melalui pemantauan kesehatan dan deteksi komplikasi. Selama persalinan, bidan memfasilitasi proses kelahiran yang aman dan mendukung proses fisiologis kelahiran. Setelah kelahiran, bidan memberikan dukungan kepada ibu dan bayi, mulai dari menyusui hingga perencanaan keluarga. Semua ini dilakukan dengan pendekatan yang menghormati hak dan pilihan perempuan serta keluarga. Kompetensi esensial ini juga sangat berguna bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pendidik, regulator, hingga bidan itu sendiri. Bagi bidan, kompetensi ini membantu dalam penilaian diri dan pengembangan profesional sepanjang karier. Ini juga menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan pendidikan kebidanan yang lebih baik di seluruh dunia, memastikan bahwa layanan kebidanan selalu memenuhi standar global yang tinggi. Dengan demikian, kompetensi ini sangat penting untuk memastikan kualitas perawatan kebidanan yang berkualitas dan aman bagi setiap individu (ICM, 2024a)

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dijelaskan mengenai pendidikan kebidanan yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana, magister, dan doktor. Bagi bidan lulusan pendidikan akademik bisa melanjutkan program profesi sedangkan untuk bidan dengan pendidikan vokasi atau diploma tiga kebidanan harus melanjutkan program pendidikan setara sarjana ditambah pendidikan profesi (UU No.4, 2019)

Guna mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh bidan yang kompeten maka diatur mengenai Standar Kompetensi Bidan dalam Kepmenkes No.320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan. Kompetensi bidan mencakup berbagai area yang dirancang untuk memastikan pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan bermutu. Dalam area etik, legal, dan keselamatan klien, bidan dituntut untuk memiliki perilaku profesional, menghormati hak dan privasi klien, serta mematuhi prinsip etik dan hukum yang berlaku. Selain itu, bidan harus selalu menjaga keselamatan klien selama praktik kebidanan. Hal ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan antara bidan, perempuan, dan keluarganya, serta menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan nyaman bagi klien. Kemampuan komunikasi efektif juga menjadi salah satu aspek penting dalam kompetensi bidan. Bidan harus mampu berkomunikasi dengan perempuan, keluarga, masyarakat, rekan sejawat, tim kesehatan lain, dan para pemangku kepentingan. Kemampuan ini mendukung bidan untuk memberikan informasi yang jelas, membangun hubungan yang harmonis, dan memastikan setiap individu yang terlibat memahami proses asuhan yang diberikan. Komunikasi yang baik membantu

bidan dalam menciptakan pelayanan yang responsif dan berbasis kebutuhan klien (Kepmenkes No 320, 2020)

Pengembangan diri dan profesionalisme adalah komponen lain yang tidak kalah penting. Bidan harus bersikap mawas diri dan terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan berkelanjutan. Penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam praktik kebidanan menjadi sarana penting untuk mencapai kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Kompetensi ini memastikan bidan selalu mengikuti perkembangan terkini di bidang kesehatan dan mampu memberikan pelayanan yang relevan dan berbasis bukti. Landasan ilmiah praktik kebidanan dan keterampilan klinis menjadi elemen kunci dalam memastikan asuhan yang berkualitas. Bidan harus memiliki pengetahuan yang mencakup seluruh siklus kehidupan perempuan, mulai dari masa bayi baru lahir hingga masa klimakterium, serta keterampilan dalam menangani situasi gawat darurat dan sistem rujukan. Dengan kompetensi ini, bidan mampu melaksanakan asuhan komprehensif yang tanggap budaya dan responsif terhadap kebutuhan klien di berbagai tahap kehidupan. Selain itu, bidan juga harus memiliki kemampuan dalam promosi kesehatan, konseling, manajemen, dan kepemimpinan. Bidan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Mereka juga diharapkan mampu merancang, mengorganisir, dan melaksanakan program promosi kesehatan yang inovatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kompetensi bidan tidak hanya mencakup aspek teknis klinis, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan menginspirasi perubahan positif dalam sistem kesehatan dan masyarakat (Kepmenkes No 320, 2020).

Bidan memiliki peran penting sebagai agen perubahan melalui pengembangan kepemimpinan mereka. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung status profesional bidan, pendidikan yang terstruktur, serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi. Karakteristik pribadi seperti motivasi, adaptabilitas, dan keterampilan proaktif menjadi pendukung utama bidan dalam memimpin perubahan. Selain itu, pengakuan profesional, otonomi, dan kolaborasi dengan dokter juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan peluang mereka untuk memimpin (Sattar et al., 2023)

Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) saat ini jumlah tenaga bidan di fasilitas kesehatan milik pemerintah yaitu sebanyak

257.391 bidan yang tersebar di fasilitas kesehatan tingkat satu dan rumah sakit. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Bidan menjadi salah satu kelompok tenaga kesehatan yang perlu segera didistribusikan ke seluruh wilayah. Sebagai garda terdepan dalam menangani persalinan ibu dan bayi, bidan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia (Kemenkes, 2024).

Secara keseluruhan, Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup selama periode 1991-2020. Angka ini mendekati target RPJMN 2024, yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun terdapat tren penurunan angka kematian ibu, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mempercepat penurunan AKI guna mencapai target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan, 2023). Pada tahun 2023, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 4.482 jiwa. Penyebab utama kematian ibu di tahun tersebut meliputi hipertensi dalam kehamilan dengan 412 kasus, perdarahan obstetrik sebanyak 360 kasus, dan komplikasi obstetrik lainnya sebanyak 204 kasus. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan memastikan bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Layanan ini mencakup pemeriksaan kehamilan, persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan, perawatan pasca persalinan untuk ibu dan bayi, penanganan khusus serta rujukan untuk kasus komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB), termasuk KB pasca persalinan. Seluruh layanan tersebut berada dalam lingkup kewenangan bidan (Kementerian Kesehatan, 2023).

Berdasarkan profil kesehatan jumlah kematian Balita (0-59 bulan) tahun 2023 yaitu sebanyak 34.226 kematian. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode neonatal (0-28 hari), dengan total 27.530 kasus atau sekitar 80,4% dari keseluruhan kematian bayi. Sementara itu, kematian pada periode pasca-neonatal (29 hari-11 bulan) tercatat sebanyak 4.915 kasus (14,4%), dan pada kelompok usia 12-59 bulan terdapat 1.781 kematian (5,2%). Pada periode post-neonatal di Indonesia, pneumonia menjadi penyebab utama kematian, menyumbang sekitar 2%, diikuti diare dan penyakit usus sebesar 1%. Penyakit jantung bawaan dan kelainan kongenital menyumbang 0,5%, sementara penyakit saraf dan sistem saraf pusat 0,3%, serta malnutrisi 0,2%. Sebanyak 16,1% kematian belum diketahui penyebabnya, dan 79,9% kasus tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Penyebab kematian pada balita usia 12-59 bulan meliputi pneumonia (1,6%), diare (1,1%), serta penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat (0,7%). Sementara itu,

sebagian besar penyebab kematian (78,9%) termasuk dalam kategori yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Beberapa penyebab yang lebih teridentifikasi antara lain adalah TBC, kelainan kongenital, keganasan (kode COO-D49), serta keracunan dan tenggelam (1,2%). Meskipun demikian, masih banyak kasus kematian pada periode post-neonatal yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas (Kementerian Kesehatan, 2023).

Selain hal tersebut masih banyak lagi kasus lain dalam kesehatan ibu dan anak, diantaranya yaitu gizi buruk yang bisa mengakibatkan stunting, cakupan ASI eksklusif juga yang masih rendah, MPASI yang tidak adekuat, dan lain sebagainya. Sehingga perlu peran bidan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak. Laporan *State of the World's Midwifery* (SoWMy) 2021 menyoroti peran penting bidan dalam mengurangi angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan kasus lahir mati, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Analisis terhadap 88 negara yang menyumbang sebagian besar angka kematian ini di dunia mengungkapkan bahwa peningkatan signifikan dalam cakupan layanan yang diberikan bidan, sebanyak 25 persen setiap lima tahun hingga 2035, berpotensi mencegah hingga 40 persen kematian ibu dan bayi baru lahir serta 26 persen kasus lahir mati. Bahkan, dengan peningkatan yang lebih sederhana, yaitu 10 persen setiap lima tahun, intervensi oleh bidan tetap mampu menyelamatkan 23 persen nyawa ibu dan bayi baru lahir serta menurunkan 14 persen angka lahir mati. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya mendukung profesi kebidanan untuk masa depan kesehatan global (UNFPA et al., 2021)

Kebidanan (*midwifery*) adalah sebuah bidang keilmuan yang memandang proses kelahiran sebagai sebuah peristiwa fisiologis dan alami. Bidang ini tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain dalam kehidupan perempuan, seperti aspek sosial, budaya, psikologis, emosional, dan spiritual, yang menggambarkan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Ilmu kebidanan disusun sebagai disiplin yang memadukan pengetahuan dari berbagai bidang, termasuk ekologi manusia, biologi reproduksi, biologi perkembangan, dan ilmu sosial. Integrasi ini membentuk dasar keilmuan kebidanan yang komprehensif dan terintegrasi dalam *Body of Knowledge* (Yulizawati, 2021). Salah satu *body of midwifery knowledge* adalah kesehatan masyarakat. Mengoptimalkan kontribusi bidan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat memerlukan pendidikan kesehatan masyarakat di bidang kebidanan yang lebih jelas dan terstruktur. Pelatihan tambahan yang mendalam mengenai peran kesehatan masyarakat serta penerapannya dalam praktik sehari-hari diperlukan. Penguatan peran bidan juga penting agar mereka dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta mengurangi ketimpangan dalam layanan kesehatan.

Bidan memiliki potensi besar dalam mengurangi kematian ibu, neonatal, dan kelahiran mati di negara berpendapatan rendah dan menengah dengan meningkatkan cakupan intervensi hingga 95%. Hal ini diperkirakan akan mencegah sebagian besar kematian ibu dan bayi pada 2035. Pelatihan, kompetensi sesuai standar internasional, serta lingkungan kerja yang mendukung sangat penting bagi bidan, sambil mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan sosial-ekonomi (McNeill et al., 2012; Nove et al., 2021).

B. Peran Bidan dalam Kesehatan Masyarakat

Resistensi antimikroba/ Antimicrobial Resistance (AMR) merupakan masalah global yang serius, menyebabkan hampir lima juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) telah menandai AMR sebagai salah satu dari 10 ancaman terbesar terhadap kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan dan penggunaan antimikroba yang berlebihan, ditambah dengan keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang tidak memadai, memperburuk penyebaran patogen yang resisten. Infeksi yang resisten terhadap obat kini mempengaruhi miliaran orang di seluruh dunia. Setiap tiga menit, seorang anak meninggal akibat sepsis yang resisten terhadap banyak obat (multidrug resistance). Selain itu, satu dari lima kematian yang disebabkan oleh AMR terjadi pada anak di bawah usia lima tahun, menggambarkan betapa seriusnya dampak AMR terhadap kesehatan anak-anak di seluruh dunia (Kementerian Kesehatan, 2024).

Bidan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba (AMR) dengan berada di garis depan layanan kesehatan primer. Bidan mendukung penggunaan antibiotik secara bijaksana melalui praktik perawatan berbasis bukti dan memastikan pasien serta komunitas memahami risiko penyalahgunaan antibiotik. Peran ini sangat penting mengingat dampak besar resistensi antimikroba terhadap kesehatan global. Dalam pelaksanaannya, bidan dapat memastikan antibiotik hanya diberikan sesuai kebutuhan medis yang jelas, mengikuti protokol yang berlaku. Edukasi kepada pasien mengenai pentingnya mematuhi resep antibiotik juga menjadi langkah strategis untuk mencegah resistensi. Selain itu, bidan memiliki kemampuan untuk menerapkan metode non-farmakologis dalam menangani infeksi ringan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada antibiotik. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi bidan sangat penting untuk mendukung pemahaman mereka tentang AMR. Pelatihan ini harus mencakup praktik pengendalian infeksi dan kebersihan yang lebih baik, sehingga mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penularan infeksi. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, bidan dapat mengedukasi

masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan infeksi, seperti menjaga kebersihan, imunisasi, dan pola hidup sehat (Kementerian Kesehatan, 2024; World Health Organization, 2018).

Perlunya kolaborasi antarprofesi dalam menangani resistansi antimikroba. Bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa infeksi ditangani secara terpadu dan terkoordinasi. Kolaborasi ini membantu menciptakan pendekatan multidisiplin yang lebih efektif dalam memerangi resistansi. Namun, bidan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran ini, seperti keterbatasan pelatihan khusus, kurangnya sumber daya, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung mereka. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat untuk memberdayakan bidan, termasuk pengintegrasian peran mereka dalam strategi nasional dan global untuk pengendalian resistansi antimikroba. Infeksi perinatal dan maternal yang masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di banyak negara menjadikan peran bidan semakin strategis dalam mencegah AMR. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh bidan dapat membantu mengurangi beban kesehatan masyarakat secara signifikan (Kementerian Kesehatan, 2024; World Health Organization, 2018).

Dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai menjadi kunci utama untuk memastikan bidan dapat menjalankan perannya secara optimal. Kebijakan ini mencakup peningkatan pelatihan, penelitian, dan investasi dalam pengembangan kapasitas bidan. Selain itu, integrasi bidan ke dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan juga penting untuk memperkuat peran mereka. Bidan memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan mengingat meningkatnya ancaman AMR secara global. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa peran bidan dalam pencegahan AMR dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Bidan adalah agen perubahan yang strategis dalam memerangi resistansi antimikroba. Strategi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (AMR) 2025–2029 di Indonesia menempatkan bidan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi melalui peran penting mereka di komunitas dan fasilitas kesehatan. Dengan fokus pada pilar utama seperti peningkatan sanitasi, implementasi pencegahan infeksi, penggunaan antibiotik yang rasional, dan edukasi masyarakat, bidan memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pengurangan infeksi dan resistansi antimikroba. Namun, keberhasilan ini memerlukan pelatihan yang lebih terarah, sumber daya yang memadai, serta dukungan kebijakan untuk mengatasi tantangan di lapangan. Semua pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, harus bersama-sama mengambil langkah nyata untuk memberdayakan bidan dalam melaksanakan peran strategis ini demi melindungi kesehatan ibu, bayi,

dan generasi mendatang (Kementerian Kesehatan, 2024; World Health Organization, 2018)

Bidan memiliki kontribusi yang signifikan dalam program pengelolaan antimikroba (Antimicrobial Stewardship/AMS) untuk menanggulangi resistensi antimikroba (AMR). Melalui praktik klinis, bidan melakukan berbagai tindakan seperti menilai risiko infeksi, merancang rencana perawatan, memberikan obat sesuai pedoman, dan memberikan edukasi kepada pasien. Langkah-langkah ini memastikan penggunaan antimikroba yang aman dan tepat sasaran. Selain itu, bidan berperan dalam pencegahan infeksi dengan menerapkan protokol keamanan seperti menjaga kebersihan tangan, mendukung peralihan obat dari intravena ke oral, serta menghentikan terapi antimikroba tepat waktu berdasarkan kebutuhan klinis. Peran ini menjadikan bidan sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi dampak resistensi antimikroba di tingkat global (ICM, 2024b)

C. Bidan sebagai Agen Perubahan

Bidan memiliki peran krusial dalam menyelamatkan nyawa perempuan dan anak-anak, dengan efektivitas yang melampaui banyak intervensi kesehatan lainnya. Menurut penelitian yang dipublikasikan di *The Lancet Global Health*, meningkatkan cakupan layanan kebidanan yang diberikan oleh bidan profesional sesuai standar internasional berpotensi mencegah hingga 67% kematian ibu, 64% kematian bayi baru lahir, dan 65% kasus kelahiran mati di 88 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pendekatan layanan berbasis bidan ini menyoroti pentingnya peran mereka dalam sistem kesehatan yang terintegrasi dengan tim multidisiplin untuk mencapai hasil yang optimal (Renfrew & Malata, 2021)

Bidan adalah pahlawan bagi jutaan perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Mereka tidak hanya menyediakan layanan kesehatan yang menghargai budaya, tetapi juga berperan sebagai pemimpin komunitas yang dihormati dan tanggap terhadap keadaan darurat seperti bencana akibat perubahan iklim. Dengan menjunjung tinggi hak kesehatan serta pilihan perempuan dan anak perempuan, bidan menjadi penghubung utama dalam menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan. Dalam situasi bencana atau konflik, bidan menjadi garda terdepan yang berperan mencegah kematian ibu yang dapat dicegah, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengurangi risiko kekerasan berbasis gender (UNFPA, 2024)

Bidan memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi krisis iklim, baik dalam memberikan perawatan kepada ibu dan bayi maupun dalam membangun ketahanan iklim di komunitas mereka. Sebagai penyedia layanan

kesehatan lokal, bidan membantu mengurangi jejak karbon sistem kesehatan dengan menerapkan model perawatan yang lebih alami dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan meminimalkan transportasi. Dengan pendekatan ini, mereka berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bidan memiliki peran kunci dalam memberdayakan perempuan untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan menyediakan akses ke kontrasepsi, perawatan aborsi yang aman, dan mendukung pemberian ASI, bidan memungkinkan perempuan untuk membuat pilihan reproduksi yang bijaksana dan berkelanjutan. Pemberian ASI tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi bayi, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi keluarga, terutama di masa-masa krisis atau bencana (ICM, 2024a)

Namun, meskipun kontribusi bidan sangat penting, banyak dari mereka yang merasa kurang siap menghadapi tantangan krisis iklim karena keterbatasan pelatihan dan sumber daya. Diperlukan peningkatan pelatihan terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta peran bidan dalam perencanaan tanggap darurat. Tanpa pelatihan yang memadai, bidan akan kesulitan dalam memberikan perawatan yang optimal di tengah situasi krisis. Penting untuk melibatkan bidan dalam strategi kebijakan iklim dan kesehatan nasional, memastikan mereka memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Pemerintah dan organisasi internasional harus memberikan pelatihan yang memadai, sumber daya, dan memastikan partisipasi bidan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan dan iklim. Dukungan ini akan memperkuat kapasitas bidan untuk merespons tantangan krisis iklim dengan lebih baik. Sebagai masyarakat, kita juga harus menyadari pentingnya akses yang lebih luas dan lebih baik ke layanan kebidanan yang ramah iklim. Bidan tidak hanya memberikan perawatan vital, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun ketahanan iklim di tingkat keluarga dan komunitas. Kini saatnya untuk bertindak, mendukung bidan, dan bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan ramah iklim bagi generasi mendatang (ICM, 2024a)

D. Tantangan dan Strategi Peran Bidan dalam Kesehatan Masyarakat

Bidan memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, baik melalui penyediaan perawatan kebidanan berkualitas maupun kontribusinya dalam memajukan kesehatan secara lebih luas. Dengan pendidikan yang sesuai standar internasional, bidan dapat mencegah lebih dari 80% kematian ibu, bayi lahir mati, dan kematian neonatal. Selain itu, mereka juga berperan dalam

memperbaiki lebih dari 50 hasil kesehatan lainnya, termasuk kesehatan reproduksi, imunisasi, dan pengurangan risiko penyakit terkait kehamilan seperti malaria dan TBC. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bidan yang berkualitas adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peran bidan juga sangat krusial di lingkungan kemanusiaan, rapuh, dan yang terkena dampak konflik. Mereka mampu memberikan layanan penting bagi wanita dan bayi baru lahir bahkan di kondisi yang paling sulit. Dalam konteks ini, bidan berkontribusi langsung pada pencapaian komitmen global, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Astana tentang Pelayanan Kesehatan Primer dan Rencana Aksi Global untuk Hidup Sehat dan Kesejahteraan. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi dalam situasi darurat, memperkuat sistem kesehatan yang tahan bencana. Namun, meskipun bukti tentang dampak positif peran bidan sangat jelas, masih ada kekurangan investasi dalam pendidikan kebidanan berkualitas. Waktu yang tepat untuk bertindak adalah sekarang, dengan memperkuat dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan bidan di seluruh dunia. Dengan memberikan mereka pelatihan yang lebih baik dan sumber daya yang memadai, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi perempuan, bayi, dan komunitas global (WHO, 2023).

Menurut *Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery 2021-2025* menyoroti peran penting bidan dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bidan memiliki kapasitas untuk memberikan sebagian besar layanan kesehatan primer yang esensial, termasuk intervensi yang dapat mencegah hingga 67% kematian ibu, 64% kematian neonatal, dan 65% kelahiran mati. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan berbasis kompetensi dan peningkatan jumlah lulusan bidan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan sistem kesehatan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Selain pendidikan, dokumen ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar bidan dapat memberikan layanan secara maksimal. Hal ini mencakup akses terhadap perlindungan kerja, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan mental. Kebijakan penempatan dan retensi juga diperlukan untuk memastikan bidan tersedia di daerah terpencil dan populasi rentan. Regulasi profesional yang harmonis antarnegara menjadi langkah penting untuk mendukung mobilitas dan pengakuan kompetensi bidan secara internasional. Bidan juga didorong untuk mengambil peran kepemimpinan dalam sistem kesehatan untuk memastikan kontribusi mereka diakui dan digunakan dalam pengambilan kebijakan. Program pengembangan kepemimpinan, termasuk pelatihan teknis dan administratif, perlu ditingkatkan untuk memberdayakan bidan dalam posisi strategis. Dengan investasi di bidang pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan

pengaturan layanan, bidan dapat secara optimal berkontribusi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkualitas dan inklusif di seluruh dunia (WHO, 2021)

E. Kesimpulan

Bidan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya dengan memberikan perawatan di masa kehamilan, persalinan, dan nifas, tetapi juga dengan berfokus pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan di tingkat komunitas. Mereka berinteraksi langsung dengan perempuan dan keluarga, memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan reproduksi, pemilihan metode kontrasepsi, dan gaya hidup sehat. Selain itu, bidan juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu penting seperti pemberian ASI eksklusif, deteksi dini penyakit pada bayi dan ibu, serta praktik kebersihan yang mendukung kesehatan keluarga secara keseluruhan. Pendekatan ini bukan hanya memastikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar kesehatan.

Namun, tantangan global yang dihadapi bidan, seperti resistansi antimikroba (AMR) dan krisis iklim, memerlukan keterampilan tambahan untuk mengatasi dampak kesehatan yang lebih luas. AMR dapat memperburuk infeksi yang tidak terkendali pada ibu dan bayi baru lahir, yang pada akhirnya meningkatkan angka kematian dan kesakitan. Dalam hal ini, bidan memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pasien dan masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan pentingnya menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi. Selain itu, perubahan iklim menambah beban pada sistem kesehatan, dengan meningkatkan frekuensi bencana alam yang mempengaruhi ibu hamil dan bayi. Bidan dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi yang berfokus pada layanan kesehatan yang ramah lingkungan dan pemberdayaan perempuan untuk merencanakan reproduksi dengan bijak di tengah kondisi yang berubah.

Peningkatan kapasitas bidan dalam menghadapi tantangan ini sangat penting. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih baik terkait dengan AMR, pengendalian infeksi, serta respons terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari pendidikan kebidanan. Pemerintah dan organisasi internasional harus berinvestasi dalam pendidikan berkelanjutan dan sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas perawatan yang diberikan oleh bidan. Sebagai garda terdepan dalam perawatan kesehatan ibu dan bayi, bidan perlu memiliki akses yang lebih luas terhadap teknologi, sumber daya medis, dan pelatihan yang memadai agar dapat

terus memberikan pelayanan berkualitas meskipun di tengah tantangan global yang ada.

Selain itu, penting untuk memperkuat kebijakan yang mendukung keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan kesehatan masyarakat dan kebijakan iklim. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara bidan, tenaga medis lainnya, serta pihak-pihak terkait, kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih resilien terhadap krisis global. Dalam hal ini, pendidikan kebidanan tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan memimpin dalam merancang respons kesehatan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Kolaborasi dan dukungan kebijakan ini akan mengoptimalkan peran bidan dalam membangun masyarakat yang sehat dan tangguh, mengurangi beban penyakit, serta mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

F. Referensi

ICM. (2024a). Policy Brief: Investing in Midwives' Associations.

ICM. (2024b). The Role of Midwives in Humanitarian Crises.

Kemenkes. (2024, June 26). Masih Banyak Bidan yang Dibutuhkan. <https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Blog/20240626/2345852/Masih-Banyak-Bidan-Yang-Dibutuhkan/>.

Kementerian Kesehatan. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2023.

Kementerian Kesehatan. (2024). Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan.

Kepmenkes No 320 (2020).

Lailiyah, S. R., Daniati, D., Diana, A. N., Elvina, A., Isro'aini, A., Vidayati, L. A., Putri, P. S., & Mardiyanti, I. (2023). Buku Ajar Konsep Kebidanan (A. Wahdu, Ed.; 1st ed.). CV. Dewa Publishing. www.dewapublishing.com

McNeill, J., Doran, J., Lynn, F., Anderson, G., & Alderdice, F. (2012). Public health education for midwives and midwifery students: A mixed methods study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 12. <https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-142>

Nove, A., Friberg, I. K., de Bernis, L., McConville, F., Moran, A. C., Najjemba, M., ten Hoope-Bender, P., Tracy, S., & Homer, C. S. E. (2021). Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study. *The Lancet Global Health*, 9(1), e24–e32. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30397-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30397-1)

- Renfrew, M. J., & Malata, A. M. (2021). Scaling up care by midwives must now be a global priority. In *The Lancet Global Health* (Vol. 9, Issue 1, pp. e2–e3). Elsevier Ltd. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30478-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30478-2)
- Sattar, S. M. R. U., Akeredolu, O., Bogren, M., Erlandsson, K., & Borneskog, C. (2023). Facilitators influencing midwives to leadership positions in policy, education and practice: A systematic integrative literature review. In *Sexual and Reproductive Healthcare* (Vol. 38). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100917>
- UNFPA, ICM, & WHO. (2021). *The State of The World's Midwifery*. United Nations Population Fund.
- UNFPA. (2024, May 5). Midwives: a vital climate solution. <https://Asiapacific.Unfpa.Org/En/News/Midwives-Vital-Climate-Solution>.
- UU No.4 (2019).
- WHO. (2021). *Global strategic directions for NURSING AND MIDWIFERY 2021-2025*.
- WHO. (2023). *Strengthening quality midwifery for all mothers and newborns*. (<https://www.who.int/activities/strengthening-quality-midwifery-for-all-mothers-and-newborns>).
- World Health Organization. (2018). *Tackling Antimicrobial Resistance (AMR) Together; Working Paper 5.0; Enhancing the focus on gender and equity*.
- Yulizawati. (2021). *Konsep Kebidanan*. Indomedia Pustaka.

G. Glosarium

ASI	: Air Susu Ibu
AKI	: Angka Kematian Ibu
AMS	: <i>Antimicrobial Stewardship</i>
AMR	: <i>Antimicrobial Resistance</i>
ICM	: <i>International Confederation of Midwives</i>
KB	: Keluarga berencana
SRHR	: <i>Sexual and Reproductive Health and Rights</i>
SISDMK	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SoWMy	: <i>State of the World's Midwifery</i>
UHC	: Universal Health Coverege
WHO	: <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 2

EDUKASI KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI UNTUK MASYARAKAT

Bdn. Gustien Siahaan, SST., S.Keb., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Pendidikan kesehatan seksual yang masih dianggap tabu menjadikan minimnya pengetahuan dan rendahnya persepsi pengendalian perilaku pada masyarakat yang banyak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Perilaku seksual pranikah mempunyai dampak terhadap kesehatan yaitu penularan penyakit/infeksi menular seksual dan kehamilan remaja yang dapat mengakibatkan putus sekolah, sanksi sosial lainnya, atau komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas (Nuryah,2020). Menjaga kesehatan reproduksi sangatlah penting terutama bagi remaja. Sebab masa remaja merupakan masa yang paling tepat untuk membangun kebiasaan yang baik, khususnya pada masa remaja menjaga kebersihan alat reproduksinya yang merupakan aset penting khususnya dalam jangka panjang bagi wanita muda (Martina, 2022).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mendefinisikan kesehatan seksual sebagai keadaan sejahtera fisik, emosional, mental dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas, ini bukan sekedar bebas dari penyakit, disfungsi atau kelemahan. Kesehatan seksual memerlukan pendekatan yang positif dan penuh hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual, serta kemungkinan mendapatkan pengalaman seksual yang menyenangkan dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Agar kesehatan seksual dapat dicapai dan dipelihara, hak-hak seksual setiap individu harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi (WHO,2002)

WHO memperkirakan sebanyak 333 juta kasus baru terkait penyakit IMS setiap tahunnya,dengan tingkat prevalensi tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun, kemudian disusul kelompok berusia 15-19 tahun (Primadevi I, dkk, 2021). Pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 374 juta infeksi baru pada orang berusia 15–49 tahun dengan 1 dari 4 IMS yang dapat disembuhkan seperti klamidia, gonore, sifilis, dan trikomoniasis. Infeksi human papillomavirus (HPV) dikaitkan dengan lebih dari 311.000 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya dan 1,1 juta wanita hamil diperkirakan tertular sifilis pada tahun 2022, yang mengakibatkan lebih dari 390.000 kelahiran yang merugikan (WHO,2022)

Tiga puluh tahun yang lalu, Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), yang diadakan di Kairo, Mesir, menggaris bawahi hak setiap individu untuk mencapai standar tertinggi atas hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR). Pada tahun 2004, WHO menerbitkan strategi kesehatan reproduksi yang diratifikasi oleh 191 Negara Anggota pada Majelis Kesehatan Dunia ke-57 yang memperkuat sentralitas SRHR bagi masyarakat dan perekonomian. Kerangka kerja ini didasarkan pada kesetaraan gender dan mengakui pentingnya kesehatan seksual dalam mencapai kesehatan untuk semua (WHO,2004)

Berdasarkan hasil survei perilaku seksual berisiko pada remaja Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013 di 33 provinsi, disebutkan bahwa 22,6% remaja pernah melakukan hubungan seks dan 62,7% remaja sekolah menengah atas (SMA). tidak perawan. KPAI bekerja sama dengan Badan Perlindungan Anak pada tahun 2016 menemukan 97% remaja pernah menonton pornografi, 93,7% mengaku sudah tidak perawan lagi, dan 21,26% pernah melakukan aborsi (Rizkianti A, 2020)

Dampak dari perilaku seksual remaja erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi, yaitu akibat psikologis seperti merasa dalam posisi terpojok, mengalami dilema, depresi, dan pesimisme terhadap masa depan yang tidak dapat dijalani dengan baik dari kondisi sehat jasmani, sosial, dan mental yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi (Martina et al., 2021). Menurut Koalisi Nasional untuk Kesehatan Seksual, remaja lebih cenderung melakukan seks aman, menunda hubungan seksual, dan meminimalkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan setelah menerima pendidikan kesehatan seksual (NHF,2020).

Pada tahun 2011, Strategi Pencegahan Nasional dan Masyarakat Sehat 2020 mengakui “kesehatan reproduksi dan seksual” sebagai bidang utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Negara Amerika (Departement Of Health US. 2020). Pernikahan dini dan kehamilan dini serta kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kekhawatiran global terhadap kesehatan dan pendidikan anak Perempuan, Di Negara Afrika Timur dan Selatan, angka kehamilan berkisar antara 15-25%, salah satu yang tertinggi di dunia (UNESCO, 2018).

Edukasi kesehatan seksual harus sesuai dengan usia dimensi fisik, mental, emosional, dan sosial seksualitas manusia sebagai bagian dari kesehatan yang terencana dan berurutan sesuai dengan pendidikan. Masalah spesifik yang ingin ditangani dalam kesehatan pendidikan, termasuk pendidikan kesehatan seksual, diselenggarakan melalui kurikulum pendidikan kesehatan dan sering dirangkum dalam kerangka kurikulum (English F, 2000).

Penerapan konsep kesehatan seksual secara luas di rangkaian layanan kesehatan berpotensi mengurangi redundansi layanan dibandingkan dengan

pendekatan yang lebih kategoris saat ini, dan meminimalkan stigma yang terkait dengan beberapa aspek seksualitas dan dampak buruk terkait. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi klinis dan proporsi populasi yang menerima layanan Edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi untuk masyarakat (Departement Of Health and Human Service, 2020).

Banyak generasi muda yang rentan terhadap perilaku seksual berisiko seperti melakukan hubungan seksual di bawah umur, poliamori, melakukan hubungan seks tanpa kondom, dan mengekspos diri mereka pada lingkungan yang berpotensi menjadi kekerasan seksual. Penggunaan narkoba, yang berkontribusi terhadap perilaku seksual tidak sehat, merupakan hal yang umum dan meningkat di kalangan remaja (Zimmerman G.M, 2017).

Meskipun terdapat berbagai inisiatif pendidikan kesehatan seksual, penyampaian dan penerapan pendidikan kesehatan seksual masih kontroversial di rangkaian terbatas sumber daya. Perilaku kesehatan seksual remaja yang tidak bertanggung jawab dan dampak buruknya terhadap kesehatan semakin meningkat di negara-negara berkembang (Vanwesenbeeck I, 2016).

Mewujudkan akses universal terhadap hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dengan upaya yang gigih di semua lini, kita dapat menumbuhkan masyarakat di mana semua orang dapat mengekspresikan seksualitas mereka dengan aman, positif dan bermartabat, termasuk hak yang tidak dapat dicabut bagi setiap orang untuk memutuskan apakah, bagaimana dan kapan untuk memiliki anak. Pentingnya kesehatan dan hak asasi manusia sudah jelas, inilah saatnya bagi komunitas kesehatan global untuk bersatu dalam agenda yang berani untuk menegaskan dan menjamin kesehatan seksual sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi semua orang (WHO,2020)

Oleh karena itu maka edukasi kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting karena merupakan komponen penting dari kesehatan dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Otonomi dalam pengambilan keputusan seksual dan reproduksi juga merupakan hak asasi manusia yang didasarkan pada hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari kekerasan seksual, dan hak untuk menentukan apakah akan hamil (www.msichoice.org,2022).

B. Edukasi Kesehatan Seksual

Kesehatan seksual adalah suatu keadaan sejahtera dalam kaitannya dengan seksualitas sepanjang rentang kehidupan yang melibatkan dimensi fisik,emosional, mental, sosial, dan spiritual. Edukasi Kesehatan seksual adalah elemen intrinsik kesehatan manusia dan didasarkan pada pendekatan positif, adil, dan penuh hormat

terhadap seksualitas, hubungan, dan reproduksi, yang bebas dari paksaan, ketakutan, diskriminasi, stigma, rasa malu, dan kekerasan. Hal ini mencakup: kemampuan memahami manfaat, risiko, dan tanggung jawab perilaku seksual; pencegahan dan perawatan penyakit dan dampak buruk lainnya dan kemungkinan memenuhi hubungan seksual. Kesehatan seksual dipengaruhi oleh konteks sosio-ekonomi dan budaya termasuk kebijakan, praktik, dan layanan yang mendukung hasil yang sehat bagi individu, keluarga, dan komunitas di Masyarakat (Centers for Disease Control and Prevention, 2012).

Kebutuhan kesehatan seksual sering diabaikan, termasuk infertilitas, ejakulasi dini, impotensi, dan masalah psikoseksual. Selain itu, jutaan orang terkena infeksi menular seksual, termasuk human immunodeficiency virus (HIV), infeksi saluran reproduksi dan kanker sistem reproduksi pada wanita (kanker serviks, payudara, rahim dan ovarium) dan pada pria (kanker prostat dan testis). Mendefinisikan potensi tantangan dan risiko kesehatan pada setiap tahap kehidupan memungkinkan dilakukannya intervensi layanan kesehatan proaktif, pendidikan dan sistem dukungan yang mendorong hasil kesehatan seksual yang positif sepanjang hidup seseorang.

Pendidikan seksual dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pedagogis yang menggunakan informasi obyektif dan lengkap pada tingkat biologis, psikologis, dan sosial untuk melatih seksualitas, mengembangkan keterampilan serta mendorong perolehan pengetahuan, sehingga mengarah pada pengembangan pemikiran kritis yang menghasilkan sikap positif terhadap seksualitas (Garcia, 2012).

Meski begitu, definisi pendidikan seksual (Edukasi kesehatan seksual) telah berubah selama bertahun-tahun dan kini didefinisikan sebagai aktivitas pedagogi, disesuaikan dengan setiap usia dan budaya, yang menggunakan informasi ilmiah yang ketat, realistis, dan tidak memihak pada tingkat biologis, psikologis, dan sosial untuk mendidik. tentang seksualitas, dipahami sebagai komunikasi manusia, sumber kesehatan, kesenangan, dan kasih sayang (Garcia, 2021).

Stigma terkait dampak buruk dari aktivitas seksual, khususnya IMS dan HIV, dapat menghambat pencarian dan penyediaan layanan kesehatan seksual. Stigmatisasi terhadap orang-orang yang, berisiko, atau sedang menjalani pemeriksaan untuk berbagai masalah kesehatan terkait perilaku seksual berasal dari pesan-pesan negatif mengenai hasil kesehatan seksual yang telah digunakan di AS selama lebih dari 100 tahun. Namun, strategi untuk mengoperasionalkan kesehatan seksual di layanan kesehatan masih kurang berkembang. Kerangka kerja kesehatan seksual secara konseptual mewakili pendekatan yang luas dan komprehensif terhadap pencegahan dan pengobatan dampak buruk terkait aktivitas seksual

termasuk HIV, IMS lainnya, virus hepatitis, kehamilan yang tidak diinginkan, kanker saluran reproduksi, dan kekerasan seksual. Hal ini juga menyediakan platform untuk mengatasi potensi masalah fungsional di kemudian hari seperti kesehatan hubungan dan tanggung jawab seksual; perubahan menarche, peripartum, dan menopause; dan prostatisme dan disfungsi ereksi (Aggleton P, 2000).

Menurut WHO, mendefinisikan kesehatan seksual sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial sehubungan dengan seksualitas, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan seksual haruslah peningkatan kehidupan pribadi dan hubungan, penghormatan dan perlindungan hak-hak seksual, dan bukan hanya perawatan dan konseling mengenai kehamilan atau pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) (UNESCO, 2018).

Agar Pendidikan Kesehatan seksual (Edukasi Kesehatan seksual) ini komprehensif, maka harus mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi. (Hurtado F., Pérez M, 2011). Penting untuk digarisbawahi bahwa kurangnya pelatihan dalam pendidikan kesehatan seksual memaparkan generasi muda pada situasi kerentanan karena mereka tidak memiliki alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk bertindak dengan benar, menghadapi perilaku seksual yang tidak sehat (Rivas E, 2021).

Pada saat ini, meluasnya penggunaan teknologi oleh generasi muda menawarkan kemungkinan menarik untuk program pendidikan kesehatan seksual, mengingat kemudahan akses, ketersediaan, biaya rendah, dan kemungkinan berpartisipasi dari jarak jauh (Gray B.J, 2019). Berkat keberadaan dan popularitas teknologi, intervensi media digital untuk pendidikan seksual menawarkan jalan ke depan yang menjanjikan, baik melalui internet (eHealth) dan melalui telepon seluler (mHealth, cara khusus untuk mempromosikan eHealth), mengingat privasi dan anonimitas yang mereka miliki khususnya bagi generasi muda. Intervensi digital di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang menarik, karena fleksibilitasnya yang lebih besar sehubungan dengan berbagai kebutuhan dan manfaat pembelajaran dibandingkan dengan intervensi tradisional, tatap muka, dan karena intervensi tersebut menawarkan peluang yang luas untuk penyesuaian, interaktivitas serta lingkungan yang aman, terkendali, dan akrab untuk menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan seksual (Widman L, 2020).

Siapa saja yang perlu dilakukan edukasi Kesehatan seksual dan reproduksi:

1. Kelompok marginal dan rentan :
 - a. Tunawisma, hidup di jalanan
 - b. Penghuni daerah kumuh

- c. Dipenjara
 - d. Hidup dengan HIV
 - e. Disabilitas
 - f. Pengguna narkoba suntik
 - g. Pekerja sex
 - h. Lesbian, gay, biseksual, transgender
 - i. anak yatim
2. Pedesaan/perkotaan
 3. Belum menikah/menikah
 4. Di sekolah/di luar sekolah, di tempat kerja
 5. Laki-laki/perempuan

Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi dapat diberikan : fasilitas Kesehatan seperti Klinik, rumah sakit, mandiri (khusus SRHS remaja) dibandingkan terintegrasi dengan fasilitas yang sudah ada (dengan layanan perawatan primer dan/atau untuk semua kelompok umur) bahkan dalam Lembaga Pemerintah dikelola LSM dan Swasta. Di luar Fasilitas kesehatan meliputi Sekolah Pemberian layanan berbasis sekolah (misalnya, klinik atau perawat di sekolah), Rujukan layanan terkait sekolah, Penjangkauan/komunitas yaitu, tempat remaja tinggal atau berkumpul, Rumah, jalan, taman, pusat perbelanjaan, Sektor kesehatan informal ; misalnya apotek, penjual obat, dukun.

Yang dapat memberikan edukasi Kesehatan seksual dan Kesehatan reproduksi ataupun sebagai penyuluh yaitu Dokter, penyedia layanan tingkat menengah, bidan, perawat, konselor (termasuk konselor sebaya), petugas kesehatan masyarakat, distributor berbasis masyarakat (misalnya kondom, alat kontrasepsi), konselor sebaya.

Edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi terkait tentang konseling dan tes HIV; perawatan, dukungan, dan pengobatan, Konseling IMS, tes, pengobatan, pengobatan pasangan, kondom, alat kontrasepsi, distribusi kontrasepsi darurat, dan konseling Tes kehamilan dan konseling serta dukungan pretest dan posttest, Perawatan ibu hamil, Layanan aborsi yang aman, Perawatan pasca-aborsi, Peduli terhadap korban kekerasan seksual, Sunat pada laki-laki, Imunisasi misalnya HPV dan TT, Panduan promotif mengenai SRH dan Pembangunan (Donna M, 2015)

C. Pentingnya Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi

Seksualitas yang sehat dipengaruhi oleh kepentingan etnis, ras, budaya, pribadi, agama, dan moral. Seksualitas yang sehat mencakup kapasitas untuk meningkatkan dan memelihara hubungan antar pribadi yang signifikan; menghargai

kesehatan tubuh dan pribadi seseorang; berinteraksi dengan kedua jenis kelamin dengan cara yang terhormat dan pantas dan mengungkapkan kasih sayang, cinta, dan keintiman dengan cara yang sesuai dengan nilai, preferensi seksual, dan kemampuan diri sendiri. Berbagai dimensi seksualitas yang sehat terdiri dari anatomi, fisiologi, dan biokimia sistem respon seksual; identitas, orientasi, peran, dan kepribadian; dan pikiran, perasaan, dan hubungan (Martino SC,2008).

D. Dampak Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Kesehatan Masyarakat

Adapun dampak positif dari pemberian edukasi Kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi Masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan generasi muda dan memperbaiki sikap mereka terkait kesehatan dan perilaku seksual dan reproduksi.
2. Meningkatkan penggunaan kondom dan alat kontrasepsi lainnya ketika mereka aktif secara seksual, meningkatkan pengetahuan mereka tentang tubuh dan hubungan yang sehat, mengurangi pengambilan risiko, dan mengurangi frekuensi hubungan seks tanpa kondom
3. Program yang mempromosikan terkait edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi sebagai satu-satunya pilihan terbukti efektif dalam menunda perilaku seksual, mengurangi frekuensi berhubungan seks, atau mengurangi jumlah pasangan seksual. Untuk mencapai perubahan positif dan mengurangi kehamilan dini atau tidak diinginkan, pendidikan tentang seksualitas, kesehatan reproduksi dan kontrasepsi harus diperluas.
4. Orang tua dan anggota keluarga merupakan sumber utama informasi, pembentukan nilai, perhatian dan dukungan bagi anak. Pendidikan seksualitas mempunyai dampak paling besar ketika program berbasis sekolah dilengkapi dengan keterlibatan orang tua dan guru, lembaga pelatihan dan layanan ramah remaja (UNESCO,2024).

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan menarik hubungan yang jelas antara kesehatan reproduksi, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ketika kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi tidak terpenuhi, setiap individu kehilangan hak untuk membuat pilihan penting mengenai tubuh dan masa depannya, yang berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Dan karena perempuan melahirkan anak, dan juga seringkali memikul tanggung jawab untuk mengasuh anak, permasalahan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari kesetaraan gender. Secara kumulatif, penolakan terhadap hak-hak ini memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan gender (UNFHA. 2022).

E. Manfaat Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi

Secara umum, manfaat dari diberikannya Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Mengenal Sistem reproduksi yang baik

Edukasi yang tepat akan membawa seseorang pada pengenalan terhadap sistem, proses serta fungsi reproduksinya. Informasi yang tepat terkait edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi akan membantu terhindar dari sumber atau masalah yang salah kaprah terkait tentang perilaku seksual menyimpang.

2. Terhindar dari penyakit menular seksual

Pengetahuan terkait kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang baik akan terhindar dari penyakit menular seksual. Berdasarkan data kesehatan dari Kementerian dan Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2020, disebutkan jika 2,5 persen remaja Indonesia terinfeksi penyakit menular seksual pranikah. Sebanyak 0,7 persen remaja perempuan telah melakukan hubungan seks pranikah, sedangkan untuk remaja laki-laki berada di angka 4,5 persen.

3. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab

Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab akan dirinya dalam menjaga kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

4. Memiliki hubungan yang sehat terhadap pasangan terkait kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi

F. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi

Perilaku seksual merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi seseorang. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, yaitu :

1. Faktor Sosial ekonomi, dan demografi. Faktor ini berhubungan dengan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan mengenai perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
2. Faktor budaya dan lingkungan, antara lain adalah praktik tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keyakinan banyak anak banyak rejeki, dan informasi yang membingungkan anak dan remaja mengenai fungsi dan proses reproduksi
3. Faktor psikologis yaitu keretakan hubungan orang tua akan memberikan dampak pada kehidupan sehingga akan terjadi depresi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal.

4. Faktor biologis, antara lain cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, dan sebagainya (Kemenkes, 2022)

G. Hambatan Dalam Penerapan Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi

Berikut yang merupakan hambatan dalam penerapan edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi masyarakat yaitu (Michaels Aibangbee, 2024) :

1. Pandangan sosial atau stigma terhadap kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi

Padangan sosial atau stigma seputar pengalaman seksual dapat memperburuk isolasi sosial, membatasi akses terhadap pendidikan sebaya dan dukungan seputar masalah kesehatan seksual, yang berarti lebih sedikit peluang bagi masyarakat untuk berbagi dan belajar dari pengalaman teman sebayanya.

2. Konflik keluarga

Konflik dalam keluarga sering kali muncul karena adanya interaksi yang kompleks antara perbedaan generasi dan transisi budaya dalam memahami kesehatan seksual.

3. Kesenjangan Gender

Hal ini mengacu pada kesenjangan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan seksual antar gender, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, yang berpotensi berkontribusi pada praktik tidak aman dan memperkuat ketidaksetaraan gender. Kesenjangan ini dapat diperlebar oleh pengaruh pornografi dan media, yang sering kali menampilkan pandangan yang tidak realistis dan berbahaya mengenai kesehatan dan hubungan seksual.

4. Kekerasan seksual

Pengalaman atau paparan terhadap kekerasan seksual dapat berdampak buruk pada kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, yang seringkali menimbulkan trauma dan mempengaruhi perilaku dan kesehatan seksual di masa depan.

5. Kurangnya kepercayaan dan kerahasiaan

Pada tingkat mesosistem, kurangnya kerahasiaan dan kepercayaan secara signifikan mempengaruhi pengalaman dan persepsi terhadap kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Kurangnya bimbingan yang dapat dipercaya dapat menumbuhkan perasaan terisolasi dan cemas.

6. Norma budaya dan masyarakat

Keyakinan budaya dan norma-norma masyarakat terkadang dapat menciptakan lingkungan di mana diskusi mengenai seks dan kesehatan

reproduksi mendapat stigma, sehingga membatasi akses generasi muda terhadap informasi dan sumber daya penting.

7. Keyakinan agama

Keyakinan agama seringkali terkait dengan keyakinan budaya dan juga dapat mempengaruhi sikap terhadap informasi terkait edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

8. Media dan budaya

Penggambaran seks, seksualitas, dan kesehatan reproduksi di media dan budaya populer membentuk sikap dan keyakinan terhadap edukasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Paparan terhadap pornografi dapat menyebabkan persepsi yang salah mengenai hubungan seksual, terutama jika pornografi merupakan sumber utama pendidikan seksual, seperti yang disoroti.

H. Strategi Dalam Pemberian Edukasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi

WHO bekerja sama dengan Negara-negara Anggota, masyarakat sipil dan komunitas di seluruh wilayah untuk mengoperasionalkan Strategi Global yang mencakup lima pilar utama untuk meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi (WHO,2022):

1. Meningkatkan pelayanan antenatal, perinatal, postpartum dan bayi baru lahir
2. Memberikan pelayanan keluarga berencana
3. Menghilangkan aborsi yang tidak aman
4. Memerangi infeksi menular seksual (IMS)
5. Mempromosikan kesehatan seksual.

Strategi Global muncul ketika dunia sedang terguncang akibat epidemi HIV dan AIDS. Saat ini, jumlah orang yang tertular HIV telah turun sebesar 38% sejak tahun 2010 saja, hal ini sebagian disebabkan oleh penekanan Strategi pada pemberantasan IMS termasuk HIV. Pada bulan Maret 2022, 60% Negara Anggota WHO telah memasukkan vaksin human papillomavirus (HPV) ke dalam jadwal imunisasi rutin mereka, sehingga sangat mempercepat upaya untuk menghilangkan kanker serviks sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Memprioritaskan layanan keluarga berencana dan akses kontrasepsi menghasilkan Keluarga Berencana. Oleh karena itu, proporsi perempuan yang menggunakan metode kontrasepsi modern meningkat dari 467 juta pada tahun 1990 menjadi 874 juta pada tahun 2022, sementara pilihan kontrasepsi kini lebih beragam (WHO,2022)

I. Langkah-Langkah Untuk Mewujudkan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Masyarakat

1. Pemimpin politik di semua tingkatan harus memperjuangkan kesehatan seksual sebagai bagian dari kesehatan seksual dan reproduksi untuk melawan oposisi konservatif. Kesehatan dan hak seksual dan reproduksi menegaskan nilai-nilai universal yang melintasi perbedaan agama, partisan, dan budaya. Para pemimpin harus membingkai isu-isu tersebut secara persuasif sebagai isu utama dalam bidang kesehatan, pembangunan dan hak asasi manusia, bukan sekedar isu-isu sosial.
2. Pembuat kebijakan harus memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang progresif untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Pemerintah harus mendanai program kesehatan masyarakat yang mengintegrasikan kesehatan seksual dan reproduksi ke dalam layanan kesehatan primer.
3. Para profesional kesehatan masyarakat memerlukan strategi berbasis bukti untuk menjangkau masyarakat dan komunitas yang paling terpinggirkan dengan layanan dan informasi berkualitas. Solusi yang kreatif dan adil, termasuk melalui perawatan diri dan intervensi digital, diperlukan untuk melayani daerah-daerah terpencil, komunitas yang terpinggirkan, kaum muda yang belum menikah, dan kelompok masyarakat yang kurang terlayani lainnya. Model-model sukses dari program-program yang menunjukkan peningkatan kesehatan dan hak-hak melalui layanan terpadu harus diterapkan secara lebih luas.
4. Masyarakat sipil dan komunitas yang terkena dampak harus bergerak untuk menuntut layanan, memperjuangkan hak-hak dan mengurangi stigma. Aktivis pemuda, aktivis feminis, kelompok HIV dan lainnya telah mendorong kemajuan melalui kampanye transnasional dan inisiatif kesehatan partisipatif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Namun, keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan tekanan publik masih diperlukan untuk mempengaruhi tindakan politik.
5. Institusi internasional harus memastikan kesehatan seksual diintegrasikan dalam kerangka kesehatan, pembangunan dan hak asasi manusia. Donor bantuan luar negeri harus mendedikasikan sumber dayanya agar sesuai dengan skala kebutuhan di negara-negara miskin. Filantropi juga mempunyai potensi untuk mendanai solusi inovatif (Tedros Adhanom, 2023).

J. Simpulan

Pendidikan kesehatan seksual yang masih dianggap tabu menjadikan minimnya pengetahuan dan rendahnya persepsi pengendalian perilaku pada masyarakat yang banyak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Edukasi

kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting karena merupakan komponen penting dari kesehatan dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Otonomi dalam pengambilan keputusan seksual dan reproduksi juga merupakan hak asasi manusia yang didasarkan pada hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari kekerasan seksual, dan hak untuk menentukan apakah akan hamil. Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi terkait tentang konseling dan tes HIV; perawatan, dukungan, dan pengobatan, Konseling IMS, tes, pengobatan, pengobatan pasangan, kondom, alat kontrasepsi, distribusi kontrasepsi darurat, dan konseling Tes kehamilan dan konseling serta dukungan pretest dan posttest, Perawatan ibu hamil, Layanan aborsi yang aman, Perawatan pasca-aborsi, Peduli terhadap korban kekerasan seksual, Sunat pada laki-laki, Imunisasi misalnya HPV dan TT, Panduan promotif mengenai SRH dan Pembangunan. Agar Pendidikan Kesehatan seksual (Edukasi Kesehatan seksual) ini komprehensif, maka harus mempromosikan hak asasi manusia, memajukan kesetaraan gender, dan meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi

K. Referensi

- Aggleton P, C. C. (2000). Working with young people—towards an agenda for sexual health. *Sex Rel Therapy*. 15:283–96.
- Centers for Disease Control, a. P. (2012). *Health Resources and Services Administration (US) CDC/HRSA Advisory Committee on HIV, Viral Hepatitis, and STD Prevention and Treatment*. Available from: URL: <http://www.cdc.gov/maso/facm/facmCHACHSPT.htm>.
- Department of Health, a. H. (2020). *Healthy people, leading health indicators*. Available from: URL: <http://www.healthypeople.gov/2020/LHI/default.aspx>.
- Donna M. Denno, M. M. (2015). Effective Strategies to Provide Adolescent Sexual and Reproductive Health Services and to Increase Demand and Community Support; *Journal of Adolescent Health*. 56.
- English, F. (2000). Deciding What to Teach and Test: Developing, Aligning, and Auditing the Curriculum (Millennium ed.). *Thousand Oaks, CA: Sage Publications*.
- García, V. J. (2021). La educación sexual: ¿en tutorías o curricular? *Magister*. doi: 10.17811/msg.33.1.2021.25-32, 33:25–32.
- García-Vázquez J., O. A.-M. (2014). Educación sexual: Opiniones y propuestas del alumnado y profesorado de los institutos de secundaria de Asturias, España. *Glob. Health Promot*. doi: 10.1177/1757975914528727, 21:74–82.

- Gray B.J, J. A. (2019). University students' behaviours towards accessing sexual health information and treatment. *Int. J. Std Aids*, 30:671–679. doi: 10.1177/0956462419828866.
- <https://www.msichoices.org/latest/what-is-sexual-and-reproductive-health/>. (2022).
- Hurtado F, P. M. (2011). Educación Para la Sexualidad Con Bases Científicas. *AES; Madrid, Spain*.
- KEMENKES RI. (2022). Infodatin Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja. In Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja (Issue Remaja).
- Martina, A. N. (2022). Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di SOS Children Village Banda Aceh Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
- Martina, D. S. (2021). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.
- Martino SC, E. M. (2008). Beyond the "big talk": the roles of breadth and repetition in parent-adolescent communication about sexual topics. *Pediatrics*, 121(3). Available at: www.pediatrics.org/cgi/content/full/121/3/e612.
- Michaels Aibangbee. (2024). Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights of Migrant and Refugee Youth: An Exploratory Socioecological Qualitative Analysis. 1538-1566; <https://doi.org/10.3390/youth4040099>.
- Nurya Kumalasari, A. K. (2020). The Influence of Reproductive Health Education to Knowledge and Percieved Behavior Sexual Adolescent Control, Public Health Perspectives. 16-24.
- Primadevi I, d. (2021). Kesehatan Reproduksi Wanita di Sepanjang Daur Kehidupan. Syiah Kuala Univrsity Press. *Banda aceh*.
- Rivas, E. (2021). Educación Sexual: Propuesta de introducción de los contenidos de se-xualidad en el currículo educativo del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. *Educ. Digit. Futuro*, 23:151–178.
- Rizkianti, S. I. (2020). the Effect of Family Living Arrangement on Delayed Sexual (Pengaruh Pengaturan Tempat Tinggal Keluarga Terhadap Penundaan Hubungan Seksual Pada Remaja Perempuan Di Indonesia). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 49–58.
- Sexual and Reproductive Health and Research (SRH) . (2023). Geneva: World Health Organization. Available from: <https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health>.
- Tedros Adhanom Ghebreyesus a, Pascale Allotey b, , M. (2023). NarasimhanAdvancing the "sexual" in sexual and reproductive health and

- rights: a global health, gender equality and human rights imperative. Dec 14;102(1):77–78. doi: 10.2471/BLT.23.291227.
- UNFPA. (2014). Sexual and reproductive health and rights in Benin: Policy and Program Analysis: Opportunities and Challenges for UNFPA.
- UNFPA and Hera. (2019). Research on what determines women's ability to decide on their SRHR and the relationship between this and other aspects of their lives. Volumes 1 and 2: Final report, October 2019.
- UNFPA, W. M. (2022). Adolescent and Youth Friendly Sexual and Reproductive Health Services. 100: 7-23. Available from: https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FR-UNFPA-WCARO-MUSKOKA-ECS-AYSRHR-Report-WEB_1.pdf.
- United Nations Educational, S. a. (2018). Orientaciones Técnicas Internacionales Sobre Educación en Sexualidad: Un Enfoque Con Base en la Evidencia. *UNESCO; Paris, France*.
- Vanwesenbeeck I, W. J. (2016). Lessons learned from a decade implementing Comprehensive Sexuality Education in resource poor settings: The World Starts with Me. *Sex Educ*, 16:471–486. doi: 10.1080/14681811.2015.1111203.
- Widman L, K. K. (2020). Feasibility, acceptability, and preliminary efficacy of a brief online sexual health program for adolescents. *J. Sex Res*, 57:145–154. doi: 10.1080/00224499.2019.1630800.
- World Health Organization. (2019). Global Health Estimates (GHE).
- Who.int.westernpacific.com (2020). Reproductive health in the Western Pacific. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/comprehensive-sexuality-education>
- Zimmerman G.M., F. C. (2017). Parents, Peers, Perceived Risk of Harm, and the Neighborhood: Contextualizing Key Influences on Adolescent Substance Use. *J. Youth Adolesc*, 46:228–247. doi: 10.1007/s10964-016-0475-5.

CHAPTER 3

KAMPANYE PEMBERANTASAN MALNUTRISI MELALUI PERAN BIDAN

Sherly Jeniawaty, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Siklus kehidupan manusia disetiap tahapannya merupakan periode yang sangat luar biasa, selain perubahan fisik yang terus tumbuh dan organ-organ tubuh yang terus berkembang keduanya dapat berlangsung baik karena pengaruh faktor internal dan external yang terkoordinasi secara optimal. Nutrisi merupakan salah satu factor eksternal yang berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Periode sejak pembuahan hingga awal kehidupan merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang unik dan menakjubkan yang menjadi fondasi bagi kesehatan di masa depan.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan bahwa angka *stunting* pada bayi di Indonesia sebesar 24,4 persen dan disusul *wasting* sebesar 7,1 persen. SSGI bahkan mencatat, satu dari empat anak Indonesia mengalami *stunting*, yang mana jumlah ini setara dengan sekitar lima juta anak Indonesia.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi (Malnutrisi) kronis. Pencegahan *stunting* dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan (HPK) meliputi masa kehamilan, menyusui, dan usia 2 tahun pertama. Bidan berperan dalam pencegahan *stunting* primer melalui intervensi sensitif dan spesifik pada 1000 HPK, sekunder melalui pendidikan remaja putri dan tersier melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada periode MPASI mulai usia 6 bulan kebutuhan akan nutrisi anak meningkat sangat signifikan baik makro nutrisi (karbohidrat, protein, lemak) maupun mikro nutrisi (vitamin dan mineral) sehingga tenaga kesehatan harus mampu memberikan edukasi dan informasi secara optimal kepada orang tua agar asupan harian anak dapat diberikan secara optimal baik dari segi bentuk, porsi maupun pemilihan bahan makanannya untuk mencegah timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti anemia dan *stunting*.

Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi kesehatan terutama transformasi layanan primer lewat penyediaan dan penguatan dan SDM. IBI mencatat bahwa sekitar 76,22 persen bidan bekerja di fasilitas pelayanan primer.

Upaya yang dapat dilakukan oleh bidan yang mempunyai TMPB untuk menurunkan *stunting* dan AKI-AKB di antaranya adalah melakukan upaya skrining kesehatan remaja dan calon pengantin, deteksi dini risiko komplikasi obstetri dan menolong persalinan normal. Kemudian memfasilitasi pemberian ASI eksklusif, asupan gizi yang baik bagi bayi dan balita, tata laksana BBLR di bawah 2.000 gram, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang.

B. Peran Bidan Menggugah Kesadaran Gizi melalui Kampanye

Gizi yang seimbang dan mencukupi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya gizi dalam menjaga tubuh mereka. Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan yang berada di tingkat primer, bidan dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi sejak dini untuk pencegahan malnutrisi.

Melakukan Kampanye yang Menggugah Kesadaran Gizi untuk cegah malnutrisi

Bidan dapat melakukan kampanye yang efektif untuk menggugah kesadaran gizi masyarakat dengan cara-cara berikut:

1. Menyelenggarakan Lokakarya Tentang Gizi Seimbang

Bidan desa dapat menyelenggarakan lokakarya tentang gizi seimbang untuk masyarakat desa. Dalam lokakarya ini, bidan desa dapat menjelaskan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi bagi kesehatan tubuh.

2. Membuat Buku Panduan Gizi untuk Masyarakat

Bidan dapat membuat buku panduan gizi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat desa. Buku ini dapat berisi informasi mengenai macronutrient dan micronutrient yang dibutuhkan oleh tubuh, serta contoh menu makanan sehat yang dapat dijadikan acuan masyarakat dalam mengatur pola makan mereka.

3. Mengadakan Sesi Tanya Jawab tentang Gizi

Bidan dapat mengadakan sesi tanya jawab tentang gizi secara rutin untuk masyarakat desa. Dalam sesi ini, masyarakat dapat bertanya langsung mengenai gizi kepada bidan desa, sehingga dapat tercipta interaksi yang lebih intens dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya gizi dalam menjaga kesehatan tubuh.

C. Langkah-langkah Menggelar Kampanye Gizi yang Efektif

Untuk menggelar kampanye gizi yang efektif, bidan desa dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan Riset dan Analisis

Bidan perlu melakukan riset dan analisis terlebih dahulu sebelum menggelar kampanye gizi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi gizi masyarakat desa, serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kesadaran gizi mereka.

2. Menentukan Tujuan Kampanye

Bidan perlu menentukan tujuan kampanye yang jelas. Tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi, mengubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi makanan, atau hal lain yang relevan dengan peningkatan kesadaran gizi.

3. Merencanakan Strategi Kampanye

Setelah menentukan tujuan, bidan perlu merencanakan strategi kampanye yang efektif. Hal ini dapat meliputi pemilihan media kampanye, cara penyampaian pesan yang menarik, serta penggunaan konten yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat desa.

4. Melaksanakan Kampanye

Setelah merencanakan strategi, bidan dapat melaksanakan kampanye dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti lokakarya, sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat membantu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kampanye selesai dilaksanakan, bidan perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kampanye. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran gizi masyarakat meningkat setelah mengikuti kampanye. Jika terdapat kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, bidan dapat melakukan tindak lanjut untuk memperbaikinya.

Menyusun Rencana Kampanye yang Efektif

Sebelum melaksanakan kampanye, bidan diupayakan melakukan riset dan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi gizi masyarakat desa. Mereka juga menentukan tujuan kampanye yang jelas, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi dan mengubah perilaku mereka dalam menjaga kesehatan tubuh.

Strategi dan Media Kampanye

Bidan menggunakan berbagai strategi dalam kampanye gizi cegah Malnutrisi. Bidan bisa melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi gizi, mengadakan lokakarya tentang gizi seimbang, serta membuat buku panduan gizi untuk masyarakat. Selain itu, bidan juga diharapkan aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye cegah Malnutrisi.

Hasil dan Dampak dari Kampanye

Dalam kampanye gizi cegah Malnutrisi yang dilakukan oleh bidan, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi. Masyarakat juga mulai mengubah perilaku mereka dalam memilih dan mengonsumsi makanan, sehingga terjadi peningkatan kualitas gizi.

D. FAQs (Frequently Asked Questions yang berarti Pertanyaan yang Sering Diajukan) dalam Kampanye Pemberantasan Malnutrisi melalui Peran Bidan

1. Apa itu kampanye Pemberantasan Malnutrisi oleh bidan?

Kampanye pemberantasan Malnutrisi oleh bidan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan mendorong perubahan perilaku dalam mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sehingga pemberantasan Malnutrisi sudah tidak ada lagi.

2. Mengapa bidan terlibat dalam kampanye gizi?

Bidan terlibat dalam kampanye gizi karena mereka berperan sebagai tenaga kesehatan yang berada di tingkat primer. Dengan posisinya yang strategis, bidan dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi.

3. Apa saja langkah-langkah dalam menggelar kampanye gizi yang efektif?

Langkah-langkah dalam menggelar kampanye gizi yang efektif meliputi riset dan analisis, menentukan tujuan kampanye, merencanakan strategi kampanye, melaksanakan kampanye, dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut.

4. Bagaimana bidan menggelar kampanye gizi?

Bidan menggelar kampanye gizi dengan melibatkan tokoh masyarakat, mengadakan lokakarya, membuat buku panduan gizi, dan menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian pesan kampanye.

5. Apa hasil dan dampak dari kampanye pemberantasan Malnutrisi?

Hasil dari kampanye pemberantasan Malnutrisi adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai gizi dan perubahan perilaku mereka dalam mengonsumsi makanan. Dampaknya adalah terjadi peningkatan kualitas gizi.

6. Apakah kampanye pemberantasan Malnutrisi oleh bidan dapat diadopsi di semua wilayah?

Kampanye Pemberantasan Malnutrisi oleh bidan dapat diadopsi di semua wilayah lain dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bidan memiliki peran yang penting dalam menggugah kesadaran gizi masyarakat melalui kampanye yang efektif. Dalam kampanye ini, bidan desa dapat melakukan berbagai langkah seperti menyelenggarakan lokakarya, membuat buku panduan, dan mengadakan sesi tanya jawab tentang gizi. Melalui kampanye yang tepat sasaran, bidan dapat meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku dalam mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

E. Kampanye Peran Bidan dalam berbagai Program

1. Program CSR Bidan Inspiratif

Peran bidan dalam memberikan edukasi akan pentingnya menjaga asupan gizi bagi anak dan termasuk ibu hamil menjadi ujung tombak dalam menekan angka penderita gizi buruk. Peran Bidan dalam berbagai kampanye program Inspiratif bertujuan untuk memaksimalkan peran bidan dalam meningkatkan kualitas informasi mengenai kehamilan dan balita terkait gizi dan pengentasan *stunting*. Program CSR Bidan Inspiratif, merupakan bentuk kampanye apresiasi terhadap peran para bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

2. Bidan Inspiratif

Bidan dapat melaksanakan Bersama *stakeholders*, kemudian melaksanakan pelatihan teori dan praktik berupa peningkatan kapasitas pengelolaan proyek sosial bagi para Bidan. Para Bidan mendapatkan pendampingan khusus dalam membuat *Logical Framework Analysis* (LFA), *timeline*, dan anggaran dana sebagai bagian dari desain proyek sosial. Harapannya, Bidan mampu meningkatkan pengetahuan dalam mengelola proyek sosialnya masing-masing. Bidan Inspiratif dalam beragam proyek sosial yang diusung, berhasil menjadi Bidan yang solutif di lingkungannya. Tak hanya layanan kesehatan berupa pemeriksaan secara rutin, namun pangan sehat juga diberikan dalam mendukung pemenuhan asupan gizi yang baik. Semua tujuan didukung dengan pelayanan kelas Ibu Hamil dan konsultasi *online* (via *whatsapp group*) bisa direncanakan.

Gizi buruk dan stunting dapat terjadi pada semua kelompok umur disebabkan pemberian ASI non eksklusif, sosial ekonomi yang rendah serta kelahiran premature. Pada usia 0 - 2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (golden period) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada

masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya stunting pertumbuhan pada anak balita (Achadi et al., 2020) (Beal et al., 2018).

Stunting merupakan suatu kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya dan biasanya pendek serta gangguan kecerdasan sehingga stunting ini menjadi prioritas utama Program pemerintah yang berintegrasi pada pelayanan kesehatan primer dengan menargetkan penurunan angka stunting sekitar 14% pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal di atas, untuk mencapai kesehatan optimal untuk kesehatan bayi dan balita dalam rangka menurunkan angka stunting, balita gizi kurang dan balita kurus maka diperlukan suatu upaya kerja yang berintegrasi berdasarkan pelayanan primer yaitu melakukan pelayanan kesehatan pada Posyandu, dengan menggunakan transformasi teknologi kesehatan dengan melibatkan kader kesehatan untuk menindak lanjuti permasalahan evaluasi capaian dan masalah yang ditemukan dari kegiatan Posyandu dengan melakukan kunjungan rumah (Drg.Widyawati, 2022).

Upaya kampanye untuk mengatasi masalah stunting, gizi kurang pada bayi dan balita, perlu dukungan berbagai pihak baik dari pusat pelayanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) maupun dari peran serta masyarakat dalam bentuk kampanye Kelompok Bina Balita sehat yang nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan oleh Nakes dan motivasi dalam bentuk penyuluhan oleh Kader kesehatan di Posyandu. Kader dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai garda utama dengan metode yang lebih menarik sehingga meningkatkan kepercayaan diri kader untuk bisa berbagi kepada masyarakat tentang Kesehatan (Azlina et al., 2022)

Kampanye pembentukan Kelompok Bina Balita sehat ini akan memberikan Pelayanan balita sehat yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi (a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan; (b) Pelayanan kesehatan balita 11-23 bulan; dan (c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan. Pada kelompok Bina Balita yang akan dibentuk ini pengabdian akan berfokus dalam melakukan pencegahan stunting dengan memberikan edukasi PMBA dan pendampingan pada keluarga bayi balita stunting. Edukasi PMBA ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu bayi dan balita di posyandu (Putri et al., 2022a)

Kampanye pemberantasan malnutrisi merupakan upaya peran bidan dalam mensukseskan pembangunan termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat sebagai ujung tombak peran serta bidan meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya masalah malnutrisi yang berakibat stunting. Tenaga kesehatan, Kader kesehatan setempat yang selama ini berada di bawah pembinaan puskesmas wilayah terkait merupakan kelompok yang terjun langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga segala bentuk informasi dapat diberikan kepada masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan kampanye dalam bentuk pengabdian masyarakat ini yakni Bidan, kader dan ibu bayi dan balita dapat menjadi motor penggerak dalam masyarakat sebagai penyambung komunikasi dan edukasi kesehatan bayi dan balita.

Proses pelaksanaan kampanye bidan bisa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan kegiatan kampanye Inovatif "AYO CETING" (Ayo Cegah Stunting) yaitu edukasi Pemberian makan Pada Bayi dan Anak sebagai penguatan program integrasi pelayanan kesehatan melalui serangkaian kegiatan pengutan peran bidan dan kader dalam kampanye upaya pencegahan stunting dengan langkah yaitu:

1. Tahap I Tahap Survey pendahuluan meliputi survey lokasi dan data dari sasaran yaitu data jumlah balita stunting tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya . Selanjutnya dilakukan pengurusan ijin lokasi di Puskesmas dan melakukan kontrak pertemuan dengan Bidan Koordinator, Bidan desa dan beberapa kader.
2. Tahap II Tahap pre test, pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengetahuan ibu balita dan kader mengenai cara pencegahan dan penatalaksanaan Stunting (Pemberian makan pada bayi dan balita) dan melakukan penimbangan sebelum dilakukan intervensi (edukasi PMBA dan pendampingan bayi dan balita stunting).
3. Tahap III Tahap pelaksanaan dimulai dengan melakukan Fokus Group Diskusi dengan Pihak Puskesmas sebagai mitra, pelatihan dengan metode ceramah, diskusi tanya jawab, simulasi, demonstrasi dan praktek sekaligus pendampingan dalam edukasi pemberian makan pada bayi dan balita. Memberikan penyuluhan melalui beberapa tahapan.
4. Tahap IV Tahap Evaluasi Tahap ini dilakukan setelah pemberian penyuluhan edukasi PMBA dan pendampingan ibu dan Kader. Evaluasi dilakukan melalui post test mengenai cara pencegahan dan penatalaksanaan Stunting (Pemberian makan pada bayi dan balita) dan melakukan penimbangan setelah dilakukan intervensi (edukasi PMBA dan pendampingan bayi dan balita stunting). Indikator penilaian post test adalah hasil peningkatan post test peserta. Tujuan dari evaluasi ini

adalah untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman ibu bayi dan balita terhadap cara pencegahan dan penatalaksanaan stunting setelah dilakukan penyuluhan edukasi kesehatan dan pendampingan. Kegiatan kampanye ini merupakan salah satu upaya peran bidan dalam pemberantasan Malnutrisi.

F. Simpulan

Bidan memiliki peran yang penting dalam menggugah kesadaran gizi masyarakat melalui kampanye yang efektif. Dalam kampanye ini, bidan dapat melakukan berbagai langkah seperti menyelenggarakan lokakarya, membuat buku panduan, dan mengadakan sesi tanya jawab tentang gizi. Melalui kampanye yang tepat sasaran, bidan dapat meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku dalam mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kampanye Pemberantasan Malnutrisi melalui peran bidan merupakan sebagai upaya penurunan angka kejadian Malnutrisi. Kampanye merupakan kegiatan promosi kesehatan dengan media yang beragam disertai pendampingan untuk mengobservasi keberhasilan program.

G. Referensi

- Drg.Widyawati, S. (2022). Kemenkes integrasikan dan Revitalisasikan Pelayanan Kesehatan Primer. Kementerian Kesehatan RI. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20220610/2440110/kemenkes-integrasikan-dan-revitalisasi-pelayanankesehatan-primer/>
- Kementrian Kesehatan RI, B. K. P. K. (2023). Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. <https://www.badankebijakan.k>
- Sudarmi, St.Halimatussyaadiah. (2023) Penguatan Peran Bidan dan Kader dalam Upaya Pencegahan Stunting: Edukasi Pemberian Makan Pada Bayi dan Balita. *Jurnal Masyarakat Mandiri* <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15325>
- Nurjazuli, N., Budiyo, B., Raharjo, M., & Wahyuningsih, N. E. (2023). Environmental factors related to children diagnosed with stunting 3 years ago in Salatiga City, Central Java, Indonesia. *Toxicologie Analytique et Clinique*.
- Putri, I., Zuleika, T., Murti, R. A. W., & Humayrah, W. (2022a). Edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Meningkatkan Pengetahuan Gizi Ibu Balita di Posyandu Anggrek, Bogor Selatan, Jawa Barat. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 48–55.
- Putri, I., Zuleika, T., Murti, R. A. W., & Humayrah, W. (2022b). Edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Meningkatkan Pengetahuan Gizi Ibu Balita di Posyandu Anggrek, Bogor Selatan, Jawa Barat. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2022.3.1.48-55>

- Quispe, J. (2023). Edukasi PMBA (pemberian makanan untuk bayi dan anak) berbasis Booklet sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting. *αJ-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88–1
- Queen KNM, Sherly J. Policy Study and Stunting Prevention in Surabaya. *Medico-Legal Update*. 2020;20(4). <http://dx.doi.org/10.37506/mlu.v20i4.1853>
- Menggugah Kesadaran Gizi melalui Kampanye oleh Bidan Desa <https://www.batumenyan.desa.id/menggugah-kesadaran-gizi-melalui-kampanye-oleh-bidan-des/>
- Savitri Kurnia (2022) Peran Bidan Pada 1000 Hpk Dalam Pencegahan Stunting <https://www.scribd.com/document/589835367/PERAN-BIDAN-pada-1000-HPK-DALAM-PENCEGAHAN-STUNTING>
- Kimia Farma Selenggarakan Program Bidan Inspiratif (2022) <https://www.topbrand-award.com/article/detail/kimia-farma-selenggarakan-program-bidan-inspiratif>
- Jeniawaty S, Mairo QKN. The Effect of Spiritual-Based Holistic Integrative Early Childhood Education on Stunting Prevention. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. 2022;10(E):1548–55. <http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2022.6999>
- Drummond, P. D., Mizan, A., Brocx, K., & Wright, B. (2011). Barriers to accessing health care services for West African refugee women living in Western Australia. *Health Care for Women International*, 32(3), 206–224. <https://doi.org/10.1080/07399332.2010.529216>
- Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosi, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. *World Health Organization*, 192. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1
- World Health Organisation. (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. *Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing*, 13(6), 1–44. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing.
- Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.22146/jkr.4913>

H. Glosarium

ANC	= Antenatal Care
ASI	= Air Susu Ibu
AKI-AKB	= Angka Kematian Ibu-Angka Kematian Bayi
BBLR	= Berat Badan Lahir Rendah
HPK	= Hari Pertama Kehidupan
FAQs	= Frequently Asked Questions /Pertanyaan yang Sering Diajukan
Stunting	= Gagal tumbuh pada anak balita
Malnutrisi	= Kekurangan Gizi
KIE	= Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KIA	= Kesehatan Ibu Anak
MPASI	= Makanan Pendamping ASI
PMBA	= Praktik Pemberian Makanan Bayi dan Anak
PUSKESMAS	= Pusat Kesehatan Masyarakat
SDM. IBI	= Sumber Daya Manusia. Ikatan Bidan Indonesia
TMPB	= Tempat Praktik Mandiri Bidan

CHAPTER 4

PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG KELUARGA BERENCANA

Ainun Ganisia, S.Keb., Bd., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

AKI (Angka Kematian Ibu) merupakan suatu masalah kesehatan yang utama di Indonesia yang belum mencapai target global SDGs. Berdasarkan hasil SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015 diketahui ada 305 kematian ibu per 100.000 KH (Kelahiran Hidup), dan belum mencapai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 yaitu sebesar 183 kematian ibu per 100.000 KH. AKN (Angka Kematian Neonatus) di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2017 diketahui jumlah AKN sebanyak 15 per 1000 KH dan target untuk tahun 2024 sebanyak 10 per 1000 KH, sedangkan jumlah AKB (Angka Kematian Bayi) ada 24 per 1000 KH dan target yang ditentukan untuk tahun 2024 sebanyak 16 per 1000 KH. Target Tahun 2030 untuk AKI secara global yaitu 70 per100.000 KH dan AKB 12 per1000 KH, serta AKN 7per1000 KH. Upaya dalam mengatasi hal ini yaitu menerapkan empat pilar *safe motherhood*, diantaranya menurunkan AKI, melalui KB, pelaksanaan ANC terstandar, persalinan yang aman, dan berjalannya PONEK & PONEK. Pelayanan KB atau kontrasepsi termasuk upaya yang strategis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Kementrian Kesehatan RI, 2018; SUPAS, 2015).

Pemanfaatan KB sebagai hak reproduksi masing-masing orang dalam menentukan kapan kehamilan, jarak dan jumlah anak yang diharapkan, serta mencegah *unwanted pregnancy*. Penggunaan KB yang sesuai mampu mengurangi resiko mortalitas ibu & bayi. Oleh sebab itu, kualitas program KB (Keluarga Berencana) dan kelengkapan aksesnya menjadi utama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan/KB. Diperlukan manajemen pelayanan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan KB. Hal tersebut juga sejalan dengan UU tentang Kesehatan Nomer 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaannya tenaga, alat dan fasilitas, serta obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat (Musakkar et al., 2023).

Ketercapaian penggunaan KB saat ini menunjukkan belum sepenuhnya berhasil, menurut SDKI tahun 2017 capaian peserta KB untuk semua jenis KB

sejumlah 63,6 %. Peserta pengguna KB modern mengalami penurunan, sedangkan pengguna KB tradisional mengalami peningkatan menurut hasil SDKI tahun 2017 dan SDKI tahun 2012. Upaya meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas bertujuan untuk mempertahankan penggunaan metode/alat KB yang juga sebagai indikator dalam mengukur tingkatan putus dan pakai. Berdasarkan SDKI tahun 2017 diketahui mayoritas pengguna KB menghentikan KB disebabkan oleh masalah kesehatan/*side effect* sejumlah 33,2%. Kejadian ini dapat diakibatkan oleh karena belum optimalnya konseling yang atau petugas kesehatan tidak melakukannya (Kementrian Kesehatan RI, 2018).

B. Macam-Macam KB

Perbedaan utama KB hormonal dan non hormonal terletak pada bahan aktif yang digunakan.

1. KB Hormonal

Kontrasepsi hormonal bekerja dengan mengubah kimia tubuh. Dengan proses yang bervariasi berdasarkan spesifik hormon yang digunakan, kontrasepsi hormonal bekerja secara berikut (Yulianti & Mirong, 2020) :

- a. Mencegah ovarium melepaskan sel telur
- b. Mengentalkan lendir serviks untuk mencegah sperma mencapai sel telur
- c. Mencegah implantasi dengan menipiskan lapisan Rahim

Berikut adalah macam-macam KB Hormonal (Abdul Madjid et al., 2022; Mruts et al., 2022; WHO, 2018)

a. Suntik Kombinasi

- 1) KB Suntik 1 bulan mengandung hormone estrogen dan progesteron
- 2) Setiap suntikan memiliki tingkat efektivitas lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan dan bertahan selama 12-14 minggu
- 3) Efektivitasnya akan berkurang jika suntikan ditunda
- 4) Saat pertama kali disuntikkan, atau setelah jeda, perlu waktu hingga 7 hari untuk mulai bekerja mencegah kehamilan

b. Suntik Progestin

- 1) KB Suntik 3 bulan mengandung hormone progesteron saja
- 2) Bisa digunakan selama menyusui
- 3) Efek samping dari KB suntikan dapat meliputi:
 - a) Pola perdarahan menstruasi akan berubah. Mungkin lebih sering atau tidak teratur. Sekitar 50-60% wanita tidak akan mengalami perdarahan sama sekali (ini tidak berbahaya bagi tubuh). Episode perdarahan yang berkepanjangan atau sering dapat membaik seiring berjalannya waktu (Kurniawati & Afifatul Latifah, 2022).

- b) Sekitar 20% pengguna akan mengalami kenaikan berat badan
 - c) Ada sedikit penurunan kepadatan tulang menjadi lebih tipis Hal ini tidak dianggap berbahaya, karena kepadatan tulang Anda kembali setelah Anda menghentikan suntikan.
- c. Pil Kombinasi
- 1) Pil tersebut mengandung hormon estrogen dan progestogen.
 - 2) Pil kombinasi sangat efektif mencegah kehamilan jika diminum dengan benar.
 - 3) Pil mungkin tidak bekerja apabila lupa minum pil atau terlambat minum lebih dari 24 jam, muntah dalam waktu 3 jam setelah minum pil, mengalami diare yang sangat parah. Hal ini berlaku juga pada pil progestin
 - 4) Cara penggunaannya dengan menelan satu pil pada waktu yang sama setiap hari. Tersedia dalam kemasan 28 hari (21 pil hormon dan 7 pil placebo). Biasanya akan mengalami menstruasi (pendarahan dari vagina) saat mengonsumsi pil placebo. Anda dapat melewati menstruasi dengan melewati pil placebo dan terus mengonsumsi pil hormon setiap hari.
 - 5) Pil KB dapat digunakan untuk melewati menstruasi, membuat menstruasi menjadi lebih ringan, lebih teratur, dan tidak terlalu menyakitkan, memperbaiki kondisi jerawat, mengurangi risiko terkena kanker rahim, ovarium, dan usus, membantu mengatasi gejala sindrom ovarium polikistik (PCOS) dan endometriosis.
 - 6) Jika lupa minum pil:
 - a) Minum pil yang terlewat segera setelah menyadarinya (ini mungkin berarti minum 2 pil pada hari yang sama).
 - b) Tetap minum pil seperti biasa
 - c) Gunakan kondom selama 7 hari ke depan
 - d) Jika telah berhubungan seks tanpa kondom dalam 7 hari sebelum lupa minum pil, Anda mungkin memerlukan kontrasepsi darurat atau mungkin perlu melewati pil placebo berikutnya dan mulai minum pil baru di bagian hormon
 - 7) Perlu diperhatikan bahwa setelah berhenti minum pil KB, kesuburan akan segera kembali normal (Sumiyati, 2022).
 - 8) Pil kombinasi mungkin bukan pilihan yang baik apabila:
 - a) mengalami kesulitan mengingat untuk minum tablet setiap hari
 - b) mengidap migrain atau sakit kepala jenis tertentu
 - c) sangat kelebihan berat badan
 - d) memiliki anggota keluarga dekat yang pernah mengalami trombotik vena dalam

- e) sedang mengonsumsi obat jenis tertentu yang dapat menghentikan kerja pil KB
- f) memiliki beberapa kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, trombosis vena dalam, penyakit jantung atau hati (konsultasikan dengan dokter/bidan)
- g) berusia di atas 35 tahun dan merokok
- h) telah menjalani perawatan kanker payudara
- i) tidak dapat bergerak dalam waktu lama (misalnya, karena operasi atau disabilitas)

d. Pil Progestin

- 1) Pil progestin hanya mengandung hormon progesteron. Pil progestin bekerja dengan mengentalkan cairan di sekitar serviks untuk membantu mencegah sperma masuk, selain itu juga menghentikan ovarium melepaskan sel telur.
- 2) Saat mulai mengonsumsi pil progestogen untuk pertama kalinya, atau setelah berhenti, perlu waktu hingga 7 hari untuk mulai bekerja.
- 3) Bisa digunakan untuk ibu menyusui
- 4) Efek samping yang mungkin terjadi pada sebagian kecil pengguna dapat meliputi: perdarahan vagina tidak teratur, sakit kepala, payudara nyeri atau nyeri tekan, perubahan pada kulit, perubahan suasana hati.
- 5) Tidak disarankan bagi orang yang merasa sulit minum tablet pada waktu yang sama setiap hari, penderita kanker payudara, penyakit hati (Abdul Madjid et al., 2022)

e. Implan

- 1) Implan (Implanon) adalah kontrasepsi batang plastik lunak dengan panjang sekitar 4 cm. Implan tersebut perlahan-lahan melepaskan hormon, progestogen, ke dalam tubuh pengguna seiring berjalannya waktu. Progestogen seperti hormon yang diproduksi oleh ovarium.
- 2) Implan > 99% efektif dalam mencegah kehamilan dan dapat bertahan hingga 3 tahun
- 3) Implan bekerja dengan mencegah ovarium melepaskan sel telur setiap bulan. Implan juga mengentalkan cairan di sekitar lubang Rahim (serviks) guna mencegah sperma mencapai sel telur.
- 4) Saat implan pertama kali dimasukkan ke lengan, diperlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai bekerja mencegah kehamilan.
- 5) Efek samping yang mungkin terjadi sama seperti penggunaan pil progestin (Laelah & Aprilina, 2020)

- 6) Kontraindikasi penggunaan implant yaitu orang yang sedang pengobatan kanker payudara, penyakit liver

2. KB Non Hormonal

Kontrasepsi non-hormonal berfungsi sebagai metode penghalang. Hal ini membuat penghalang fisik antara sperma dan sel telur untuk mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi lain, seperti metode alamiah dan kontrasepsi permanen juga diklasifikasikan sebagai pilihan non-hormonal. Berikut adalah macam-macam KB Non Hormonal (Howard & Benhabbour, 2023).

a. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

- 1) Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi kecil yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan
- 2) Ada dua jenis yaitu AKDR tembaga dan AKDR hormonal (dikenal dengan nama Mirena atau Kyleena)
- 3) Keduanya termasuk metode kontrasepsi yang paling efektif dan dapat bertahan selama 5-10 tahun, tergantung jenisnya
- 4) AKDR (baik yang mengandung tembaga maupun hormon) tidak memberikan perlindungan dari infeksi menular seksual. Cara terbaik untuk mengurangi risiko IMS adalah dengan menggunakan perlindungan seperti kondom

b. Kondom

Kondom merupakan metode kontrasepsi penghalang dengan lapisan sangat halus yang terbuat dari karet atau plastik yang mencegah tercampurnya cairan tubuh saat berhubungan seksual. Kondom 98% sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan IMS (Lubis et al., 2022).

c. KB Alami

KB alami atau dikenal dengan FAM (*Fertility Awareness Method*) didasarkan pada tanda-tanda tubuh yang berubah selama siklus menstruasi sebagai respons terhadap hormon. Dapat menggunakan kalender, menghitung hari dari periode menstruasi sebelumnya, atau mengamati gejala dan tanda ovulasi. FAM tidak direkomendasikan diantaranya apabila baru saja berhenti menggunakan alat kontrasepsi hormonal, memiliki periode menstruasi yang tidak teratur, dan menjelang masa menopause (Binturu & Larompong, 2022; WHO, 2018).

d. KB Permanen

1) Tubektomi

- a) Tubektomi atau dikenal sterilisasi tuba/ ligasi tuba merupakan metode kontrasepsi permanen dengan menggunakan *keyhole surgery*, klip

dipasang pada tuba falopi untuk menghalangi pertemuan sperma dan sel telur

- b) Dokter bedah mungkin menyarankan agar tuba falopi diangkat daripada dipotong, untuk mengurangi risiko kanker ovarium (Hayati, 2018).

2) Vasektomi

- a) Vasektomi adalah upaya sterilisasi dengan operasi yang mencegah sperma mengalir dari testis ke penis dengan memotong saluran yang memungkinkan sperma keluar dari testis.
- b) Vasektomi 99% efektif dalam mencegah kehamilan
- c) Jika Anda menjalani vasektomi, dorongan seks, produksi hormon seks, dan kemampuan mencapai orgasme tidak akan terpengaruh
- d) Vasektomi memerlukan waktu sekitar 3 bulan sejak prosedur dilakukan agar vasektomi mulai berhasil. Penting untuk melakukan tes sperma untuk memeriksa hal ini (Hayati, 2018)

C. Keluarga Berencana dan Masalah Kesehatan Reproduksi

Memilih diantara berbagai macam KB bergantung pada tiga faktor utama yaitu:

1. Preferensi personal

Manfaat KB berdasarkan (WHO, 2014) diantaranya yaitu:

- a. Ibu dan bayi lebih sehat jika kehamilan berisiko dihindari
- b. Keluarga yang lebih kecil berarti lebih banyak uang dan makanan untuk setiap anak
- c. Orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja dan bersama keluarga
- d. Menunda kehamilan pertama atau kedua memungkinkan kaum muda tetap bersekolah

Berikut ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan KB menurut (WHO, 2014)

- a. Banyak anak muda yang membutuhkan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Idealnya, wanita dan pria muda harus menunggu hingga usia minimal 18 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan, dan siap untuk memiliki anak
- b. Setelah memiliki anak, akan lebih sehat jika menunggu setidaknya 2 tahun untuk mencoba hamil lagi
- c. Memiliki lebih dari 4 anak membuat persalinan lebih berisiko

Waktu Paling Tepat Bagi Wanita Untuk Hamil Berdasarkan (WHO, 2014) antara lain:

- a. Berusia antara 18-34 tahun

- b. Setidaknya 24 bulan setelah kelahiran hidup
- c. Setidaknya 6 bulan setelah aborsi

2. Masalah kesehatan

Pemilihan dan penggunaan KB disesuaikan berdasarkan kondisi atau masalah kesehatan pengguna, diantaranya sebagai berikut (Abebaw et al., 2024):

a. KB dalam Perawatan Pascaaborsi

Bantu Wanita Memperoleh KB

Berikan Konseling dengan Kasih Sayang

Seorang wanita yang mengalami komplikasi pascaaborsi memerlukan dukungan. Seorang wanita yang menghadapi risiko ganda khususnya dari kehamilan dan *unsafe abortion* memerlukan bantuan dan dukungan. Konseling yang baik memberikan dukungan kepada wanita yang baru saja dirawat karena komplikasi pascaaborsi antara lain:

- 1) Cobalah untuk memahami apa yang telah dialaminya
- 2) Perlakukan dia dengan hormat dan hindari menghakimi dan mengkritik
- 3) Pastikan privasi dan kerahasiaan
- 4) Tanyakan apakah dia menginginkan seseorang yang dia percaya untuk hadir selama konseling

Berikan Informasi Penting

Seorang wanita memiliki pilihan penting untuk dibuat setelah menerima perawatan pascaaborsi. Untuk membuat keputusan tentang kesehatan dan kesuburannya, wanita perlu mengetahui (WHO, 2014):

- 1) Kesuburan kembali dengan cepat—dalam waktu 2 minggu setelah aborsi pada trimester pertama dan dalam waktu 4 minggu setelah aborsi atau aborsi pada trimester kedua. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan dari kehamilan segera.
- 2) Wanita dapat memilih di antara berbagai metode KB yang dapat ia mulai sekaligus (lihat halaman berikutnya). Metode yang tidak boleh digunakan wanita segera setelah melahirkan tidak menimbulkan risiko khusus setelah perawatan untuk komplikasi aborsi.
- 3) Wanita dapat menunggu sebelum memilih alat kontrasepsi untuk penggunaan berkelanjutan, tetapi ia harus mempertimbangkan untuk menggunakan metode alternatif* untuk sementara waktu jika ia berhubungan seks. Jika seorang wanita memutuskan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi saat ini, penyedia layanan kesehatan dapat memberikan informasi tentang metode yang tersedia dan tempat untuk mendapatkannya. Selain itu, penyedia layanan kesehatan dapat

memberikan kondom, alat kontrasepsi oral, atau pil kontrasepsi darurat bagi wanita untuk dibawa pulang dan digunakan nanti.

- 4) Untuk menghindari infeksi, tidak diperbolehkan berhubungan seks sampai pendarahan berhenti—sekitar 5 hingga 7 hari. Jika sedang dirawat karena infeksi atau luka vagina atau serviks, harus menunggu untuk berhubungan seks lagi sampai benar-benar pulih.
- 5) Jika ingin segera hamil lagi, anjurkan untuk menunggu. Menunggu setidaknya 6 bulan dapat mengurangi kemungkinan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan anemia ibu. Seorang wanita yang menerima perawatan aborsi mungkin memerlukan layanan kesehatan reproduksi lainnya. Secara khusus, penyedia layanan kesehatan dapat membantunya mempertimbangkan apakah ia mungkin telah terpapar infeksi menular seksual.

*Metode alternatif meliputi pantang, kondom pria atau wanita, spermisida, dan *withdrawal*. Dapat menggunakan spermisida jika tidak mengalami luka vagina atau serviks. Diketahui bahwa spermisida dan *withdrawal* adalah metode kontrasepsi yang paling tidak efektif. Jika memungkinkan, berikan kondom

Kapan Harus Memulai Metode Kontrasepsi

- 1) Kontrasepsi oral kombinasi, pil progestin saja, suntikan bulanan, patch gabungan, implan, kondom pria, kondom wanita, dan penghentian penggunaan kontrasepsi dapat dimulai segera dalam setiap kasus, bahkan jika wanita tersebut mengalami luka pada saluran genital atau memiliki kemungkinan atau telah terkonfirmasi infeksi.
- 2) IUD, sterilisasi pada wanita, dan metode kesadaran kesuburan dapat dimulai setelah infeksi hilang atau teratasi.
- 3) IUD, cincin vagina *combined*, spermisida, diafragma, serviks *caps*, sterilisasi wanita, dan metode alamiah dapat dimulai setelah luka pada saluran genital telah pulih (Palinggi et al., 2021; WHO, 2014).

Pertimbangan khusus (WHO, 2018):

- 1) Pemasangan IUD segera setelah aborsi trimester kedua.
- 2) Sterilisasi pada wanita harus diputuskan terlebih dahulu, dan tidak saat wanita tersebut sedang dibius, dalam keadaan stres, atau kesakitan. Berikan konseling dengan saksama dan pastikan untuk menyebutkan metode reversibel yang tersedia
- 3) cincin vagina *combined*, spermisida, diafragma, dan serviks *caps* bisa digunakan segera bahkan pada kasus perforasi uterus tanpa komplikasi.

- 4) Diafragma harus dipasang kembali setelah keguguran atau aborsi pada trimester pertama. Setelah aborsi pada trimester kedua tanpa komplikasi, penggunaan alat ini harus ditunda selama 6 minggu agar rahim kembali ke ukuran normal, dan kemudian diafragma harus dipasang kembali.
- 5) Metode alamiah: seorang wanita dapat memulai metode alamiah setelah tidak ada lagi sekresi yang berhubungan dengan infeksi atau pendarahan akibat luka pada saluran genital. Dapat memulai metode berbasis kalender pada pendarahan bulanan berikutnya, jika ia tidak mengalami pendarahan akibat luka pada saluran genital.

b. Kekerasan terhadap Perempuan

Setiap penyedia layanan KB mungkin melihat banyak wanita yang mengalami kekerasan. Kekerasan terhadap wanita umum terjadi di mana-mana. Dalam sebuah studi terkini di 10 negara, lebih dari 1 dari setiap 10 wanita dan hingga sekitar 7 dari setiap 10 wanita dilaporkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Kekerasan fisik mencakup berbagai macam perilaku, termasuk memukul, menampar, menendang, dan memukul. Kekerasan seksual mencakup kontak atau perhatian seksual yang tidak diinginkan, hubungan seks yang memaksa, dan hubungan seks yang dipaksakan (pemeriksaan). Kekerasan terhadap wanita juga dapat bersifat psikologis, seperti perilaku yang mengendalikan, intimidasi, penghinaan, mengisolasi wanita dari keluarga dan teman, dan membatasi aksesnya terhadap sumber daya (WHO, 2018).

Perempuan yang mengalami kekerasan memiliki kebutuhan kesehatan khusus, di antaranya terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Kekerasan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk cedera, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV, penurunan hasrat seksual, nyeri saat berhubungan seks, dan nyeri panggul kronis. Bagi sebagian perempuan, kekerasan dapat dimulai atau menjadi lebih buruk selama kehamilan, yang juga membahayakan janinnya. Lebih jauh lagi, kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seorang pria dapat merampas hak perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri tentang apakah akan menggunakan KB atau metode apa yang akan digunakan. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan reproduksi mungkin lebih cenderung melihat perempuan yang dilecehkan di antara klien tetap mereka dibandingkan penyedia layanan kesehatan lainnya (Abebaw et al., 2024; WHO, 2014).

Apa yang Dapat Dilakukan Penyedia Layanan? (Mruts et al., 2022; WHO, 2014)

1) Bantu wanita merasa diterima, aman, dan bebas berbicara

Bantu wanita merasa nyaman berbicara bebas tentang masalah pribadi apa pun, termasuk kekerasan. Pastikan setiap wanita bahwa kunjungannya akan dirahasiakan. Berikan kesempatan kepada perempuan untuk mengemukakan masalah kekerasan, seperti menanyakan kepada perempuan tentang sikap pasangannya terhadap dirinya yang menggunakan alat kontrasepsi, menanyakan apakah ia memperkirakan adanya masalah dengan penggunaan alat kontrasepsi, dan menanyakan apakah ada hal lain yang ingin ia diskusikan.

2) Tanyakan kepada wanita tentang pelecehan setiap kali ada dugaan kekerasan Meskipun sebagian besar wanita tidak akan mengemukakan bahwa mereka mengalami kekerasan, banyak yang akan berbicara jika ditanya tentang kekerasan. Menanyakan kepada semua klien apakah mereka mengalami kekerasan hanya disarankan jika penyedia layanan terlatih dengan baik dalam konseling tentang kekerasan, privasi dan kerahasiaan dapat dipastikan, dan ada cukup sumber daya yang tersedia untuk menanggapi kasus kekerasan yang teridentifikasi secara memadai. Hingga saat itu, penyedia layanan dapat bertanya kapan pun ada dugaan kekerasan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada mereka yang membutuhkan perawatan segera.

Waspadalah terhadap gejala, cedera, atau tanda yang menunjukkan adanya tindak kekerasan. Penyedia layanan kesehatan mungkin mencurigai adanya tindak kekerasan jika depresi, kecemasan, sakit kepala kronis, nyeri panggul, atau nyeri perut samar-samar tidak membaik seiring berjalannya waktu dengan pengobatan. Tanda tindak kekerasan lainnya mungkin terjadi jika cerita klien tentang bagaimana terjadinya cedera tidak sesuai dengan jenis cedera yang dialaminya. Curigai adanya tindak kekerasan pada cedera apa pun selama kehamilan, terutama pada perut atau payudara.

Beberapa tips untuk mengangkat topik kekerasan (WHO, 2014):

- a) Untuk meningkatkan kepercayaan, jelaskan mengapa Anda bertanya—karena Anda ingin untuk membantu.
- b) Gunakan bahasa yang nyaman bagi Anda dan paling sesuai dengan gaya Anda sendiri.
- c) Jangan menanyakan pertanyaan seperti itu ketika pasangan wanita atau orang lain ada di dekat Anda hadir atau saat privasi tidak dapat dijamin.
- d) Anda dapat mengatakan, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah umum di masyarakat kita, jadi kami telah bertanya kepada klien kami tentang kekerasan.”

- e) Anda dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti:
- (1) "Gejala yang Anda alami mungkin disebabkan oleh stres. Apakah Anda dan pasangan sering bertengkar? Pernahkah Anda terluka?"
 - (2) "Apakah pasangan Anda pernah menginginkan seks sementara Anda tidak menginginkannya? Apa yang terjadi dalam situasi seperti itu?"
 - (3) "Apakah kamu takut dengan pasanganmu?"
- 3) Memberikan nasihat dengan cara yang tidak menghakimi, sensitif, dan mendukung
- Pelayanan penting bagi perempuan yang mengalami hubungan yang penuh kekerasan yaitu konseling. Konseling tentang kekerasan harus disesuaikan dengan keadaan khusus perempuan. Perempuan mungkin berada pada tahap yang berbeda dalam keinginan untuk mencari perubahan. Hal ini akan memengaruhi apakah Beberapa wanita tidak siap untuk mendiskusikan situasi mereka dengan penyedia layanan kesehatan. Inti dari konseling bukanlah untuk mengetahui secara pasti apakah klien mengalami kekerasan, tetapi untuk mengatasi masalah tersebut dengan penuh kasih sayang dan menunjukkan bahwa Anda peduli.
- a) Jika dia tidak ingin bicara tentang kekerasan, yakinkan dia bahwa Anda tersedia kapan pun dia membutuhkan Anda. Beri tahu dia pilihan dan sumber daya apa saja yang tersedia jika dia membutuhkannya.
 - b) Jika dia ingin berbicara tentang pengalamannya, Anda dapat:
 - (1) Pastikan kerahasiaan, dan jaga kerahasiaan situasi wanita tersebut. Beri tahu hanya mereka yang perlu tahu (seperti staf keamanan), dan lakukan itu hanya dengan izin klien.
 - (2) Akui pengalamannya. Dengarkan, tawarkan dukungan, dan hindari menghakimi. Hargai kemampuannya dan haknya untuk membuat pilihan sendiri tentang hidupnya.
 - (3) Cobalah untuk meredakan perasaan malu dan menyalahkan diri sendiri yang mungkin muncul pada wanita: "Tidak ada seorang pun yang pantas dipukul." "Kamu tidak pantas menerima kekerasan, dan itu bukan salahmu."
 - (4) Jelaskan bahwa kekerasan merupakan masalah yang umum: "Hal ini terjadi pada banyak wanita." "Anda tidak sendirian, dan bantuan tersedia."
 - (5) Jelaskan bahwa kekerasan tidak mungkin berhenti dengan sendirinya: "Kekerasan cenderung berlanjut, dan seringkali menjadi lebih buruk dan terjadi lebih sering."

- 4) Menilai bahaya yang mengancam jiwa seorang wanita, membantu dia menyusun rencana keselamatan, dan merujuk dia ke sumber daya masyarakat. Jika wanita tersebut menghadapi bahaya langsung, bantu dia mempertimbangkan berbagai tindakan. Jika tidak dalam bahaya langsung, bantu dia mengembangkan rencana jangka panjang.
- a) Bantu dia menilai situasi saat ini:
- (1) "Apakah dia ada di fasilitas kesehatan sekarang?"
 - (2) "Apakah Anda atau anak-anak Anda dalam bahaya sekarang?"
 - (3) "Apakah kamu merasa aman untuk pulang?"
 - (4) "Apakah ada teman atau saudara yang dapat membantu Anda mengatasi situasi di rumah?"
- b) Bantu dia melindungi dirinya dan anak-anaknya jika kekerasan itu terjadi lagi. Sarankan agar ia menyimpan tas berisi dokumen penting dan pakaian ganti agar ia dapat segera pergi jika perlu. Sarankan agar ia memberikan tanda agar anak-anak tahu kapan harus meminta bantuan tetangga.
- c) Buatlah dan perbarui daftar sumber daya yang tersedia untuk membantu para korban pelecehan, termasuk polisi, layanan konseling, dan organisasi wanita yang dapat memberikan dukungan emosional, hukum, dan bahkan finansial. Berikan salinan daftar tersebut kepada klien.
- 5) Berikan perawatan yang tepat
- Sesuaikan perawatan dan konseling Anda dengan keadaan wanita.
- a) Rawat luka-lukanya atau pastikan dia mendapat perawatan.
- b) Mengevaluasi risiko kehamilan dan memberikan kontrasepsi darurat jika sesuai dan diinginkan.
- c) Tawarkan pil kontrasepsi darurat untuk penggunaan di masa mendatang
- d) Jika dia mau, berikan dia metode kontrasepsi yang bisa digunakan tanpa sepengetahuan pasangan, seperti suntikan.
- e) Bantu perempuan untuk berpikir tentang apakah mereka dapat menggunakan kondom dengan aman digunakan, tanpa risiko kekerasan lebih lanjut.
- f) Dalam kasus pemerkosaan:
- (1) Pertama-tama kumpulkan sampel apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti (seperti pakaian yang robek atau ternoda, rambut, dan noda darah atau air mani).
 - (2) Menyediakan atau merujuk pasien untuk menjalani tes dan pengobatan HIV dan IMS. Beberapa wanita mungkin memerlukan layanan tersebut secara berulang.

- (3) Pertimbangkan profilaksis pasca pajanan untuk HIV, jika tersedia, dan pengobatan dugaan untuk gonore, klamidia, sifilis, dan IMS umum lainnya di daerah setempat.
 - 6) Dokumentasikan kondisi wanita tersebut. Dokumentasikan dengan saksama gejala atau cedera yang dialami wanita tersebut, penyebab cedera, dan riwayat kekerasan yang dialaminya. Catat dengan jelas identitas pelaku kekerasan, hubungannya dengan korban, dan detail lainnya tentang dirinya. Catatan ini dapat berguna untuk tindak lanjut medis dan tindakan hukum di masa mendatang, jika dilakukan (WHO, 2014).
- c. Infertilitas

Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan anak. Meskipun sering kali pihak wanita yang disalahkan, kemandulan dapat terjadi pada pria dan wanita. Rata-rata, kemandulan memengaruhi 1 dari 10 pasangan. Pasangan dianggap mandul yaitu setelah melakukan hubungan seksual tanpa kondom selama 12 bulan tanpa kehamilan. Pasangan dapat mandul terlepas dari apakah wanita tersebut pernah hamil di masa lalu atau tidak. Di antara pasangan yang tidak memiliki masalah kesuburan, 85% wanita akan hamil dalam waktu satu tahun. Rata-rata, kehamilan terjadi setelah 3 hingga 6 bulan berhubungan seksual tanpa kondom. Namun, terdapat variasi yang besar di sekitar rata-rata ini. Pemborosan kehamilan merupakan bentuk lain dari infertilitas: Seorang wanita dapat hamil, tetapi keguguran atau *stillbirth* mencegah kelahiran hidup (WHO, 2018).

Penyebab Infertilitas

Berbagai faktor atau kondisi dapat mengurangi kesuburan, antara lain (Li et al., 2023).

- 1) Penyakit menular (IMS, termasuk HIV, infeksi saluran reproduksi lainnya; *mumps* yang berkembang setelah pubertas pada pria)
- 2) Masalah anatomi, endokrin, genetik, atau sistem kekebalan tubuh
- 3) Penuaan
- 4) Prosedur medis yang menyebabkan infeksi ke saluran reproduksi bagian atas wanita

IMS merupakan penyebab utama kemandulan. Jika tidak diobati, gonore dan klamidia dapat menginfeksi tuba falopi, rahim, dan ovarium. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit radang panggul (PID). PID klinis memang menyakitkan, tetapi terkadang PID tidak memiliki gejala dan tidak disadari. Gonore dan klamidia dapat melukai tuba falopi wanita, sehingga menghalangi sel telur untuk berjalan melalui tuba dan bertemu sperma. Pria dapat

mengalami jaringan parut dan penyumbatan di saluran sperma (epididimis) dan uretra akibat gonore dan klamidia yang tidak diobati (WHO, 2014).

Alasan lain untuk infertilitas pria meliputi ketidakmampuan alami untuk memproduksi sperma sama sekali atau cukup sperma untuk menyebabkan kehamilan. Yang lebih jarang terjadi, sperma mengalami cacat dan mati sebelum mencapai sel telur. Di antara wanita, ketidakmampuan alami untuk hamil sering kali disebabkan oleh penyumbatan tuba falopi atau ketidakmampuan untuk berovulasi. Kesuburan juga berkaitan dengan usia. Seiring bertambahnya usia wanita, kemampuannya untuk hamil secara alami akan menurun seiring berjalannya waktu. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa, sama halnya, pria, seiring bertambahnya usia, menghasilkan sperma yang kurang mampu membuahi sel telur (WHO, 2018).

Infeksi pascapersalinan dan pascaaborsi juga dapat menyebabkan PID, yang dapat menyebabkan kemandulan. Hal ini terjadi ketika instrumen bedah yang digunakan untuk prosedur medis tidak didisinfeksi atau disterilkan dengan benar. Seorang wanita juga dapat mengalami PID jika infeksi yang ada di saluran reproduksi bagian bawah terbawa ke saluran reproduksi bagian atas selama prosedur medis (WHO, 2018).

D. Simpulan

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka kematian ibu dan bagian dari pelaksanaan *safe motherhood*. Kematian ibu ataupun bayi salah satunya disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Manfaat penggunaan KB yaitu untuk mengontrol kelahiran dengan mencegah atau menjarangkan kehamilan. Macam-macam KB terdiri dari KB hormonal dan non hormonal. Contoh KB hormonal yaitu pil progestin, pil kombinasi, suntik progestin, suntik kombinasi, sedangkan contoh KB non hormonal yaitu AKDR/IUD, implan, kondom, KB alami, dan KB permanen. Penentuan dalam penggunaan KB harus memperhatikan indikasi dan kontraindikasinya. Penggunaan KB tidak hanya dilakukan pada wanita sehat saja, namun juga pada wanita dengan masalah kesehatan reproduksi misalnya pascaaborsi, pemerkosaan, dll. Dengan adanya KB dan panduannya diharapkan pertumbuhan penduduk suatu negara terkontrol dan kualitas hidup atau kesejahteraan penduduk lebih terjamin dengan jumlah anak yang cukup. Terlaksananya pelayanan KB yang berkualitas tentu memerlukan bantuan pemerintah, lembaga, penyedia layanan yang berkompeten dan terlatih, serta koordinasi dengan masyarakat yang terjaga.

E. Referensi

- Abdul Madjid, O., Surya, R., Prawiro Tantry, H., & Ocviyanti, D. (2022). Kontrasepsi Hormonal Berbasis Progesterin pada Perempuan dengan Riwayat Tumor Jinak Payudara. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 10(2), 162–167. <https://doi.org/10.23886/ejki.10.96.162-7>
- Abebaw, N., Haile, B., Workie, A., Mebratu, W., & Getie, M. (2024). Quality of family planning counseling and associated factors among reproductive age women who are current contraceptive users at Dessie town health facilities east Amhara, 2023. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1345. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11833-z>
- Binturu, D., & Larompong, K. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PUS Memilih KB Alamiah Factors Affecting PUS Choosing Natural Birth Control in Binturu Village, Larompong District*. 6(2), 280–285.
- Hayati, Y. (2018). Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan. *Journal Equitable*, 3(1), 83–97.
- Howard, S. A., & Benhabbour, S. R. (2023). *Non-Hormonal Contraception*.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017*.
- Kurniawati, H., & Afifatul Latifah. (2022). Relationship between Hormonal Contraception and Menstrual Cycle. *Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research*, 6(8), 2069–2073. <https://doi.org/10.37275/bsm.v6i8.546>
- Laelah, N., & Aprilina, H. D. (2020). Hubungan Durasi Pemakaian Alat Kontrasepsi Implan Dengan Perubahan Berat Badan Dan Gangguan Siklus Menstruasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Padamara. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 8(September), 171–176.
- Li, W., Lin, A., Qi, L., Lv, X., Yan, S., Xue, J., & Mu, N. (2023). Immunotherapy: A promising novel endometriosis therapy. *Frontiers in Immunology*, 14(April), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1128301>
- Lubis, Y., H., & Susilawati, S. (2022). Sebuah Tinjauan Sistematis: Pengaruh Penggunaan Kondom Terhadap Program “Dua Anak Cukup” Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Undip*, 10(4), 475–484. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Mruts, K. B., Tessema, G. A., Dunne, J., Gebremedhin, A. T., Scott, J., & Pereira, G. F. (2022). Does family planning counselling during health service contact improve postpartum modern contraceptive uptake in Ethiopia? A nationwide cross-sectional study. *BMJ Open*, 12(5), e060308. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060308>
- Musakkar, M. E. P., Erniati, E., Adam, A., & Alim, A. (2023). Qualitative Study of

- Community Participation Behavior in the Family Planning Program at the Kajuara Community Health Center, Bone District, South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 8(4), 278–289. <https://doi.org/10.26911/thejhpb.2023.08.04.05>
- Palinggi, R. S., Moedjiono, A. I., Suarayasa, K., Masni, Seweng, A., Amqam, H., Nur, R., & Syam, A. (2021). The effect of balanced counseling strategy family planning against attitude, subjective norm, and intentions on the use of modern contraception behavior in the Singgani Public Health Center work area of Palu city. *Gaceta Sanitaria*, 35, S140–S144. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.013>
- Sumiyati. (2022). Meta-Analysis the Effect of Hormonal Contraception on Sexual Disfunction in Injection and Oral Contraceptive Acceptors. *Journal of Maternal and Child Health*, 7(6), 729–741. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2022.07.06.11>
- SUPAS. (2015). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*.
- WHO. (2014). A guide to family planning. *Why Use Family Planning*, 1. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44882/1/9789241503754_eng.pdf
- WHO. (2018). Collaborating and Supporting Organizations. *Family Planning*, 59–81.
- Yulianti, H., & Mirong, I. D. (2020). The Influence Of Family Planning Counseling During Third Postpartum Visit Towards The Stability Became Family Planning Acceptors. *Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak*, 14(2), 151–157. <http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/kia/>

F. Glosarium

AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKN	: Angka Kematian Neonatal
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
FAM	: <i>Fertility Awareness Method</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IUD	: <i>Intrauterine Device</i>
KB	: Keluarga Berencana
KH	: Kelahiran Hidup
PCOS	: <i>Polycystic Ovarian Syndrome</i>
PID	: <i>Pelvic Inflammatory Disease</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDKI	: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

SUPAS : Survei Penduduk Antar Sensus
WHO : *World Health Organization*

CHAPTER 5

BIDAN DALAM PENANGANAN KESEHATAN MENTAL IBU DAN ANAK DI MASYARAKAT

Bdn. Yuni Surya Putri, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan di berbagai negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan khusus dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama di tingkat primer. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, hingga perawatan bayi baru lahir, serta memberikan edukasi dan konseling kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi (Saharoy et al., 2023).

Dalam beberapa dekade terakhir, pelayanan kesehatan masyarakat telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidan kini tidak hanya berperan dalam pelayanan klinis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di komunitas. Peran bidan di tingkat komunitas sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan reproduksi (Kemenkes RI, 2020).

Di samping itu, bidan juga memegang peran penting dalam penanganan kesehatan mental ibu dan anak. Kesehatan mental merupakan aspek yang sering kali terabaikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, padahal masalah kesehatan mental, seperti depresi pascapersalinan dan kecemasan, dapat berdampak negatif pada kesejahteraan ibu dan perkembangan anak. Bidan yang memiliki pemahaman tentang kesehatan mental dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada ibu serta keluarga (Syahputra et al., 2022).

Penanganan kesehatan mental ibu dan anak di masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas. Intervensi kesehatan mental yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berbasis komunitas, termasuk bidan, dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengurangi stigma terhadap

masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi bidan untuk mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penanganan kesehatan mental, termasuk keterampilan komunikasi, identifikasi masalah, dan rujukan yang tepat (J. Henshaw et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, pelayanan kesehatan mental masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, stigma sosial, dan keterbatasan akses layanan. Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat, memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan ini. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis budaya lokal, bidan dapat memberikan dukungan yang efektif kepada ibu dan anak yang menghadapi masalah kesehatan mental (Jeličić et al., 2022).

Selain itu, peran bidan dalam penanganan kesehatan mental ibu dan anak juga mencakup edukasi dan promosi kesehatan mental di komunitas. Edukasi ini meliputi pentingnya mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental, cara mengatasi stres, serta pentingnya dukungan sosial bagi ibu dan anak. Pendekatan edukatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma yang terkait dengan masalah ini (Coles & Cage, 2022).

Dalam menjalankan perannya, bidan juga perlu memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh , faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan norma budaya dapat memengaruhi kesehatan mental ibu dan anak. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di komunitas tempat mereka bekerja.

Selain faktor sosial dan budaya, bidan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan mental ibu dan anak, seperti faktor biologis dan psikologis. Faktor-faktor seperti riwayat kesehatan mental, kehamilan yang tidak direncanakan, dan kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada ibu dan anak. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki keterampilan dalam melakukan penilaian risiko dan memberikan intervensi yang sesuai (J. Henshaw et al., 2023).

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan masyarakat juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental ibu dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan mental pada perempuan dan anak. Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang sering kali menjadi tempat pertama bagi ibu untuk mencari bantuan, memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menangani kasus KDRT (Vieira-Meyer et al., 2022).

Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan dukungan kepada ibu yang menghadapi situasi sulit, seperti kehilangan bayi atau mengalami komplikasi persalinan. Dukungan emosional yang diberikan oleh bidan dapat membantu ibu mengatasi trauma dan mempercepat pemulihan kesehatan mental mereka. Dalam pelayanan kesehatan masyarakat, bidan juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun jaringan dukungan sosial bagi ibu dan anak. Jaringan dukungan sosial yang kuat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental ibu dan anak serta mengurangi risiko masalah kesehatan mental (Ault et al., 2024)

Untuk mendukung peran bidan dalam penanganan kesehatan mental ibu dan anak, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat. Menurut laporan dari World Health Organization (2021), kerjasama lintas sektor sangat penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental di komunitas.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung peran bidan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam penanganan kesehatan mental. Salah satu kebijakan yang relevan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Kehamilan yang menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan mental selama masa kehamilan.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ada. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi bidan mengenai kesehatan mental merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas bidan dalam penanganan kesehatan mental ibu dan anak .

Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan dan pelatihan bidan memainkan peran yang sangat penting. Menurut laporan dari International Confederation of Midwives (ICM, 2021), pelatihan yang berfokus pada kesehatan mental dan keterampilan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan bidan dalam memberikan layanan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan mental ibu dan anak.

B. Kesehatan Mental Ibu dan Anak

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah kondisi di mana individu dapat mengenali potensinya sendiri, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental mencakup keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermakna (World Health Organization, 2022).

Dalam konteks ibu dan anak, kesehatan mental mencakup kemampuan ibu untuk mengelola stres, membangun hubungan yang positif dengan anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental anak. Sementara itu, kesehatan mental anak merujuk pada kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup.

1. Definisi Kesehatan Mental Ibu dan Anak

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah kondisi di mana individu dapat mengenali potensinya sendiri, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya (WHO, 2020). Kesehatan mental ibu merujuk pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi kemampuan seorang ibu untuk mengasuh anak dan menjalani perannya dalam keluarga serta masyarakat. Kesehatan mental ibu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormonal pascapersalinan, dukungan sosial, dan kondisi ekonomi ("APA Council Reports," 2021).

Kesehatan mental ibu berperan penting dalam perkembangan emosional dan kognitif anak. Gangguan kesehatan mental seperti depresi postpartum dapat memengaruhi kualitas interaksi antara ibu dan anak, yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan anak dalam jangka panjang.

Dalam konteks ibu dan anak, kesehatan mental mencakup kemampuan ibu untuk mengelola stres, membangun hubungan yang positif dengan anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental anak. Sementara itu, kesehatan mental anak merujuk pada kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup.

2. Pentingnya Kesehatan Mental Ibu

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang, termasuk bagi para ibu. Seorang ibu tidak hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Dalam menjalankan peran ini, kesehatan mental ibu sering kali diabaikan, padahal kondisi mental yang baik sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Edmond, 2017).

Banyak ibu mengalami tantangan emosional, terutama setelah melahirkan. Perasaan lelah, cemas, bahkan depresi bisa muncul akibat perubahan hormonal, tekanan sosial, dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa itu kesehatan mental ibu dan bagaimana menjaganya agar ibu dapat menjalankan perannya dengan baik (Santos et al., 2011).

3. Pentingnya Kesehatan Mental Anak

Kesehatan mental anak mencakup bagaimana anak berpikir, merasakan, dan berperilaku di berbagai situasi. Kesehatan mental yang baik pada anak akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif. Kesehatan mental anak dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lingkungan keluarga, hubungan dengan orang tua, serta pengalaman hidup (Kwon et al., 2023).

Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan anak yang menghadapi stres, kekerasan, atau penelantaran. Beberapa tanda kesehatan mental yang baik pada anak meliputi kemampuan untuk mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang positif, serta memiliki rasa percaya diri yang sehat. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental pada anak dapat berupa kecemasan, depresi, atau masalah perilaku yang dapat memengaruhi proses belajar dan interaksi sosial mereka (KNBS, 2023).

4. Gangguan Kesehatan Mental Umum pada Ibu dan Anak

Gangguan kesehatan mental pada ibu sering kali terjadi selama masa kehamilan dan pascapersalinan. Beberapa gangguan umum yang sering dialami oleh ibu antara lain:

a. Depresi Pascapersalinan (Postpartum Depression)

Depresi pascapersalinan adalah gangguan mental yang terjadi setelah melahirkan. Gejala yang muncul meliputi perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat, kelelahan, dan kesulitan mengurus bayi. Faktor risiko termasuk riwayat depresi sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, dan komplikasi selama kehamilan (Saharoy et al., 2023).

b. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan pada ibu dapat terjadi selama masa kehamilan atau setelah melahirkan. Ibu dengan gangguan kecemasan sering merasa khawatir berlebihan tentang kesehatan bayi, proses persalinan, dan peran mereka sebagai orang tua.

c. Psikosis Pascapersalinan

Psikosis pascapersalinan adalah gangguan mental yang lebih serius dan jarang terjadi. Gejala termasuk halusinasi, delusi, dan perilaku yang tidak wajar. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera karena dapat membahayakan ibu dan bayinya (Adeponle et al., 2023).

Gangguan kesehatan mental pada ibu dapat memengaruhi hubungan ibu dan anak serta perkembangan emosional dan kognitif anak. Ibu yang mengalami

depresi atau kecemasan mungkin kesulitan memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang.

Gangguan kesehatan mental pada anak juga menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Beberapa gangguan umum yang dialami anak meliputi:

a. Gangguan Perilaku

Gangguan perilaku pada anak dapat berupa ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), gangguan oposisi menentang, dan gangguan perilaku disruptif lainnya. Anak dengan gangguan ini sering mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku mereka (Papotot et al., 2021).

b. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan pada anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan panik. Anak dengan gangguan kecemasan sering merasa khawatir berlebihan tentang berbagai situasi sehari-hari.

c. Depresi pada Anak

Depresi pada anak dapat sulit dideteksi karena gejalanya sering kali berbeda dari orang dewasa. Anak yang mengalami depresi mungkin menunjukkan perubahan perilaku, kehilangan minat bermain, dan menurunnya prestasi akademik.

5. Hubungan Kesehatan Mental Ibu dan Anak

Kesehatan mental ibu dan anak saling berkaitan erat. Ibu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mampu memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental pada ibu dapat memengaruhi anak dalam berbagai cara, termasuk mengganggu perkembangan emosional dan perilaku anak (Baker et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental ibu, terutama selama masa kehamilan dan periode awal pengasuhan anak (Syahputra et al., 2022). Dukungan dari keluarga, teman, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu ibu menjaga kesehatan mentalnya. Dengan memberikan perhatian pada kesehatan mental ibu dan anak, kita dapat memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bahagia, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal (Coles & Cage, 2022).

C. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Ibu dan Anak

1. Faktor Biologis

a. Faktor genetik

Faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap gangguan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia memiliki komponen genetik yang kuat. Anak-anak yang lahir dari ibu dengan riwayat gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah serupa (Chandra et al., 2024).

Anak-anak dengan riwayat keluarga yang mengalami gangguan bipolar memiliki risiko 60% lebih tinggi untuk mengalami gangguan mood dibandingkan dengan anak-anak tanpa riwayat keluarga yang sama. Faktor genetik ini dapat diperparah oleh faktor lingkungan yang buruk, seperti stres kronis dan kurangnya dukungan social (Saur et al., 2020).

b. Faktor Neurologis dan Perkembangan Otak Anak

Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh faktor biologis sejak dalam kandungan. Gangguan neurologis seperti autisme dan ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) memiliki dasar biologis yang kuat. Faktor-faktor seperti kekurangan nutrisi selama kehamilan, infeksi, dan paparan zat berbahaya dapat memengaruhi perkembangan otak anak (Siddique et al., 2022).

Kekurangan asam folat selama trimester pertama kehamilan meningkatkan risiko gangguan perkembangan neurologis pada anak hingga 30%. Penting bagi ibu hamil untuk menjaga pola makan dan menghindari paparan zat berbahaya guna mendukung perkembangan otak anak yang optimal (Dey et al., 2024).

c. Faktor Fisik dan Kesehatan Mental

Kesehatan fisik ibu dan anak juga memengaruhi kondisi mental mereka. Penyakit kronis, malnutrisi, dan kurangnya aktivitas fisik dapat memicu gangguan mental. Ibu dengan kondisi kesehatan yang buruk cenderung mengalami kecemasan dan depresi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan mental anak.

Ibu yang mengalami obesitas selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi pasca-persalinan. Sehingga permasalahan ini harus ditangani agar tidak mengganggu kesehatan mental ibu. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu dengan kondisi kesehatan yang buruk lebih rentan mengalami masalah perkembangan kognitif dan emosional (Lee et al., 2023).

2. Faktor Psikologi

a. Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Ibu :

1) Stres dan Beban Mental

Ibu sering mengalami stres akibat beban pekerjaan rumah tangga, pekerjaan (R.C.W. et al., 2016).

2) Depresi Pasca Melahirkan

Depresi pasca melahirkan adalah kondisi yang umum terjadi pada ibu baru. Faktor hormonal, perubahan fisik, serta tekanan sosial dapat memicu kondisi ini. Depresi yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada hubungan ibu dan anak (Savolainen et al., 2021).

3) Kecemasan

Kecemasan pada ibu dapat disebabkan oleh kekhawatiran tentang kemampuan mereka dalam merawat anak. Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mental ibu dan memengaruhi perkembangan anak.

4) Dukungan Sosial

Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat memperburuk kesehatan mental ibu. Dukungan yang cukup dari pasangan, keluarga, dan teman dapat membantu ibu mengatasi tekanan psikologis.

b. Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Anak

1) Hubungan Ibu-Anak

Kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan ibu. Interaksi yang positif dan penuh kasih sayang dapat membantu anak merasa aman dan dicintai, yang penting untuk perkembangan mental yang sehat (Koire et al., 2021).

2) Trauma Masa Kecil

Anak-anak yang mengalami trauma masa kecil, seperti kekerasan atau kehilangan orang tua, cenderung mengalami masalah kesehatan mental di kemudian hari. Peran ibu dalam memberikan rasa aman sangat penting dalam mencegah dampak buruk trauma (Uy et al., 2023).

3) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang dapat memengaruhi perkembangan mental anak. Sebaliknya, konflik dalam keluarga dapat memicu stres dan kecemasan pada anak.

4) Pendidikan Emosional

Pendidikan emosional dari orang tua, terutama ibu, dapat membantu anak mengelola emosi mereka dengan baik. Kemampuan untuk mengelola emosi adalah kunci untuk kesehatan mental yang baik.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial memainkan peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Lingkungan sosial yang sehat dan mendukung dapat membantu ibu melewati berbagai tantangan selama kehamilan, persalinan, dan masa pascapersalinan. Berikut adalah beberapa faktor sosial yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak:

a. Dukungan Sosial

Dukungan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat penting bagi kesejahteraan fisik dan mental ibu. Dukungan yang baik dapat membantu ibu:

- 1) Mengurangi risiko depresi pascapersalinan
- 2) Mengelola stres yang muncul selama masa kehamilan dan setelah melahirkan
- 3) Memiliki pengalaman persalinan yang positif

Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kondisi mental ibu dan meningkatkan risiko gangguan mental, seperti kecemasan dan depresi.

b. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ibu memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan ibu dan anak. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang:

- 1) Pentingnya perawatan prenatal dan postnatal
- 2) Pola makan sehat selama kehamilan
- 3) Imunisasi dan perawatan anak

Kondisi ekonomi yang stabil juga memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas (Saur et al., 2020).

c. Norma dan Budaya

Norma sosial dan budaya setempat dapat memengaruhi praktik kesehatan ibu dan anak. Beberapa contoh pengaruh budaya meliputi:

- 1) Tradisi persalinan dan perawatan bayi
- 2) Peran gender dalam keluarga

Di beberapa masyarakat, norma yang mengharuskan ibu menanggung beban pekerjaan rumah tangga tanpa dukungan dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu (Gheyoh Ndzi & Holmes, 2023).

d. Akses ke Layanan Kesehatan

Faktor sosial juga memengaruhi akses ibu ke layanan kesehatan. Dukungan komunitas dan informasi yang tepat dapat mendorong ibu untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan selama kehamilan dan setelah melahirkan.

4. Faktor Budaya

a. Peran Tradisi dan Nilai Keluarga

Tradisi dan nilai keluarga memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku terkait kesehatan mental ibu dan anak. Dalam banyak budaya, keluarga merupakan pusat dukungan emosional. Namun, nilai-nilai seperti patriarki yang kuat dapat membatasi peran ibu dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait kesehatan mentalnya (Modak et al., 2023).

Sebagai contoh, dalam budaya yang sangat patriarkal, perempuan mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan masalah kesehatan mental karena stigma atau kurangnya dukungan. Penelitian oleh William et al. (2018) menunjukkan bahwa perempuan di budaya Asia Timur sering kali menahan diri untuk berbicara tentang depresi postpartum karena takut dianggap lemah atau gagal menjalankan peran sebagai ibu (Williams et al., 2018).

b. Stigma terhadap Kesehatan Mental

Stigma adalah salah satu penghalang utama dalam mengakses perawatan kesehatan mental. Dalam banyak budaya, gangguan kesehatan mental masih dianggap tabu. Stigma ini sering kali diperparah oleh kepercayaan tradisional yang mengaitkan masalah kesehatan mental dengan kutukan, dosa, atau karma buruk (Javed et al., 2021).

Di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa stigma kesehatan mental berdampak langsung pada ibu yang mengalami depresi postpartum. Mereka sering kali tidak mencari bantuan karena takut dikucilkan oleh komunitas (Jones, 2022).

c. Kepercayaan Tradisional tentang Penyebab Penyakit

Di beberapa budaya, masalah kesehatan mental dianggap sebagai akibat dari gangguan spiritual atau ketidakseimbangan energi tubuh. Kepercayaan ini dapat memengaruhi cara keluarga dan individu menangani masalah tersebut. Contohnya, dalam budaya Afrika Sub-Sahara, kesehatan mental sering kali dikaitkan dengan sihir atau roh jahat. Penelitian oleh Brooke (2020) menemukan bahwa banyak ibu yang lebih memilih pengobatan tradisional daripada terapi psikologis untuk mengatasi gangguan mental (Brooke & Ojo, 2020).

d. Peran Gender dalam Kesehatan Mental

Norma gender dalam budaya tertentu dapat memengaruhi bagaimana ibu dan anak menangani masalah kesehatan mental. Dalam budaya yang menempatkan beban besar pada peran ibu sebagai pengasuh, tekanan untuk

memenuhi ekspektasi sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan (Delgado-Herrera et al., 2024).

Menurut penelitian oleh Aguirre et al., (2024), ibu yang tinggal di masyarakat dengan ekspektasi gender yang tinggi cenderung mengalami tekanan emosional yang lebih besar, terutama ketika mereka merasa tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan (Aguirre et al., 2024).

e. Dukungan Sosial dari Komunitas

Komunitas budaya dapat memberikan dukungan sosial yang signifikan atau, sebaliknya, memperburuk stres. Dalam budaya kolektivistis, dukungan dari keluarga besar sering kali menjadi sumber kekuatan bagi ibu dan anak. Namun, jika hubungan sosial ini diwarnai konflik atau tekanan, dampaknya bisa berlawanan.

Misalnya, penelitian oleh Kumar et al. (2019) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang positif dari komunitas dapat mengurangi risiko depresi postpartum, tetapi tekanan untuk mematuhi norma budaya tertentu justru dapat memperburuk kondisi kesehatan mental.

f. Budaya dan Pola Asuh Anak

Budaya memengaruhi cara orang tua mendidik anak, termasuk pola asuh yang diterapkan. Pola asuh otoriter yang sering ditemukan dalam budaya tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan pada anak. Sebaliknya, pola asuh yang mendukung dan penuh kasih sayang cenderung meningkatkan kesehatan mental anak.

Menurut penelitian oleh Xie et al., anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh tekanan budaya cenderung menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih fleksibel (Xie et al., 2024).

g. Pengaruh Agama dan Spiritualitas

Agama dan spiritualitas dapat menjadi sumber dukungan emosional yang signifikan bagi ibu dan anak. Dalam banyak budaya, praktik spiritual memberikan harapan dan rasa keterhubungan dengan komunitas. Namun, pemahaman agama yang kaku dapat menimbulkan rasa bersalah atau stigma tambahan. Praktik spiritual yang positif dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada ibu, terutama selama masa kehamilan dan setelah melahirkan (Martínez de Pisón, 2023).

h. Akses terhadap Layanan Kesehatan Mental

Faktor budaya juga memengaruhi sejauh mana individu dapat mengakses layanan kesehatan mental. Dalam beberapa budaya, ada anggapan bahwa mencari bantuan profesional adalah tanda kelemahan atau sesuatu yang tidak

perlu. Misalnya, studi oleh Tripathi et al. (20223) menemukan bahwa ibu di komunitas pedesaan India lebih cenderung mencari bantuan dari dukun atau tabib tradisional daripada profesional medis (Tripathi et al., 2023).

D. Peran Bidan dalam Penanganan Kesehatan Mental Ibu dan Anak

Peran bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup deteksi dini dan pencegahan serta penangana masalah kesehatan mental ibu dan anak (ICM, 2021) .

1. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Mental Ibu dan Anak

a. Edukasi dan Promosi Kesehatan Mental

Bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya kesehatan mental. Edukasi dapat dilakukan melalui konseling individu, kelas kehamilan, atau kegiatan komunitas. Dalam edukasi ini, bidan harus menjelaskan tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental seperti depresi pasca melahirkan (postpartum depression) atau kecemasan prenatal (Torti et al., 2023).

b. Skrining Kesehatan Mental

Skrining merupakan langkah awal dalam mendeteksi gangguan kesehatan mental. Bidan dapat menggunakan alat skrining yang terstandarisasi seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk mengidentifikasi risiko depresi atau gangguan mental lainnya pada ibu. Skrining ini sebaiknya dilakukan pada kunjungan antenatal dan postnatal secara berkala (Grisbrook & Letourneau, 2021).

c. Pemberdayaan Ibu dan Keluarga

Bidan juga bertugas untuk memberdayakan ibu dan keluarga agar mampu mengenali serta mengatasi tekanan psikologis. Dengan mendukung penguatan hubungan ibu-anak, bidan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental.

2. Pencegahan Masalah Kesehatan Mental Ibu dan Anak

Bidan berperan dalam:

a. Pendidikan dan Konseling

Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya kesehatan mental dan cara menjaga keseimbangan emosional selama kehamilan dan setelah melahirkan.

b. Deteksi Dini

Deteksi dini gangguan kesehatan mental sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih serius di masa depan. Bidan berada di garis depan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga memiliki kesempatan untuk

melakukan deteksi dini pada ibu dan anak yang berisiko mengalami gangguan kesehatan mental.

Dalam melaksanakan deteksi dini, bidan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan terkait kesehatan mental ibu dan anak harus menjadi bagian dari pendidikan dan pengembangan profesional bidan agar mereka dapat menjalankan peran ini dengan baik. Menggunakan alat skrining untuk mendeteksi tanda-tanda gangguan mental seperti depresi dan kecemasan (Sumarni et al., 2020).

c. Rujukan

Mengarahkan ibu ke tenaga profesional lain, seperti psikolog atau psikiater, jika ditemukan masalah kesehatan mental yang memerlukan penanganan khusus.

d. Pendampingan

Menyediakan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga selama masa kehamilan dan postpartum.

Strategi Pencegahan oleh Bidan meliputi:

a. Pemberdayaan Ibu:

Menedukasi ibu tentang teknik relaksasi, manajemen stres, dan pentingnya dukungan social (Koumarianou et al., 2021).

b. Kunjungan Rumah:

Memantau kondisi ibu dan anak secara langsung untuk mengidentifikasi faktor risiko di lingkungan rumah.

c. Pelibatan Keluarga:

Mendorong anggota keluarga untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu.

d. Kerja Sama Lintas Profesi:

Bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dan tenaga kesehatan lain untuk pendekatan holistik.

3. Penanganan Masalah Kesehatan Mental Ibu dan Anak

a. Rujukan ke Tenaga Profesional

Bidan memiliki tanggung jawab untuk merujuk ibu yang mengalami masalah kesehatan mental ke psikolog atau psikiater jika diperlukan (Sumarni et al., 2020).

b. Dukungan Psikologis

Memberikan dukungan emosional kepada ibu selama proses perawatan dapat membantu meringankan beban mental yang mereka rasakan (Vassilopoulos et al., 2022).

c. Intervensi Psikososial

Bidan dapat memimpin kelompok dukungan atau melakukan konseling berbasis empati untuk membantu ibu mengatasi stres dan kecemasan. Intervensi psikososial yang dipimpin oleh bidan mampu mengurangi gejala depresi pasca melahirkan hingga 40% dalam enam bulan pertama (J. Henshaw et al., 2023).

E. Simpulan

Bidan memegang peran strategis dalam pencegahan masalah kesehatan mental ibu dan anak melalui edukasi, deteksi dini, dan intervensi. Dengan pelatihan yang memadai dan dukungan sistem, bidan dapat membantu mengurangi dampak negatif gangguan mental pada ibu dan anak. Untuk itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat agar kesehatan mental menjadi bagian integral dari kesehatan ibu dan anak.

Peran penting bidan dalam mendukung kesehatan mental ibu dan anak sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan masyarakat. Bidan tidak hanya bertanggung jawab pada aspek fisik selama kehamilan, persalinan, dan nifas, tetapi juga memegang peran strategis dalam menjaga kesehatan mental ibu dan anak, yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bidan sangat berperan penting dalam deteksi dini, pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental ibu dan anak.

F. Referensi

- Adeponle, A., Groleau, D., Gureje, O., & Kirmayer, L. J. (2023). Help-seeking for moderate to severe perinatal depression in Nigeria: Implications for a cultural-ecosocial approach to global mental health. *SSM - Mental Health*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2023.100217>
- Aguirre, E., Benzeval, M., & Murray, A. (2024). Parental gender attitudes and children's mental health: Evidence from the UK household longitudinal study. *Social Science and Medicine*, 344. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116632>
- APA Council Reports. (2021). In *The American journal of psychiatry* (Vol. 178, Issue 10). <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.1781001>
- Ault, S., Helsabeck, N., Breitenstein, S. M., Tucker, S., Havercamp, S. M., & Ford, J. L. (2024). A secondary analysis examining the influence of emotional support on the mental health of caregivers of children with autism spectrum disorder. *Journal of Pediatric Nursing*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.01.005>
- Baker, E. K., Giallo, R., Seymour, M., Hearps, S. J. C., & Wood, C. E. (2023). A

- longitudinal study of the relationships between sleep problems in autistic children and maternal mental health. *Autism*, 27(7). <https://doi.org/10.1177/13623613221147397>
- Brooke, J., & Ojo, O. (2020). Contemporary views on dementia as witchcraft in sub-Saharan Africa: A systematic literature review. In *Journal of Clinical Nursing* (Vol. 29, Issues 1–2). <https://doi.org/10.1111/jocn.15066>
- Chandra, J. H., Kurniawan, C., & Puspitasari, I. M. (2024). Genetic Markers Associated with Postpartum Depression: A Review. In *Neuropsychiatric Disease and Treatment* (Vol. 20). <https://doi.org/10.2147/NDT.S434165>
- Coles, D. C., & Cage, J. (2022). Mothers and Their Children: An Exploration of the Relationship Between Maternal Mental Health and Child Well-Being. *Maternal and Child Health Journal*, 26(5). <https://doi.org/10.1007/s10995-022-03400-x>
- Delgado-Herrera, M., Aceves-Gómez, A. C., & Reyes-Aguilar, A. (2024). Relationship between gender roles, motherhood beliefs and mental health. *PLoS ONE*, 19(3 March). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298750>
- Dey, M., Dhume, P., Sharma, S. K., Goel, S., Chawla, S., Shah, A., Madhumidha, G., & Rawal, R. (2024). Folic acid: The key to a healthy pregnancy – A prospective study on fetomaternal outcome. *Tzu Chi Medical Journal*, 36(1). https://doi.org/10.4103/tcmj.tcmj_110_23
- Edmond, K. M. (2017). The importance of interventions to improve maternal mental health. In *Journal of Tropical Pediatrics* (Vol. 63, Issue 1). <https://doi.org/10.1093/tropej/fmw073>
- Gheyoh Ndzi, E., & Holmes, A. (2023). Paternal Leave Entitlement and Workplace Culture: A Key Challenge to Paternal Mental Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8). <https://doi.org/10.3390/ijerph20085454>
- Grisbrook, M. A., & Letourneau, N. (2021). Improving maternal postpartum mental health screening guidelines requires assessment of post-traumatic stress disorder. In *Canadian Journal of Public Health* (Vol. 112, Issue 2). <https://doi.org/10.17269/s41997-020-00373-8>
- ICM. (2021). ICM Global Standards for Midwifery Education. *Icm, Revised*.
- J. Henshaw, E., Cooper, M., Wood, T., N. Doan, S., Krishna, S., & Lockhart, M. (2023). Psychosocial predictors of early postpartum depressive and anxious symptoms in primiparous women and their partners. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05506-8>
- Javed, A., Lee, C., Zakaria, H., Buenaventura, R. D., Cetkovich-Bakmas, M., Duailibi, K., Ng, B., Ramy, H., Saha, G., Arifeen, S., Elorza, P. M., Ratnasingham, P., & Azeem, M. W. (2021). Reducing the stigma of mental health disorders with

- a focus on low- and middle-income countries. In *Asian Journal of Psychiatry* (Vol. 58). <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102601>
- Jeličić, L., Veselinović, A., Ćirović, M., Jakovljević, V., Raičević, S., & Subotić, M. (2022). Maternal Distress during Pregnancy and the Postpartum Period: Underlying Mechanisms and Child's Developmental Outcomes—A Narrative Review. In *International Journal of Molecular Sciences* (Vol. 23, Issue 22). <https://doi.org/10.3390/ijms232213932>
- Jones, A. (2022). Postpartum Help-Seeking: The Role of Stigma and Mental Health Literacy. *Maternal and Child Health Journal*, 26(5). <https://doi.org/10.1007/s10995-022-03399-1>
- Kemenkes RI. (2020). *Permenkes Nomor 21 Tahun 2020*.
- KNBS. (2023). Demographic and Health Survey 2022. *Demographic and Health Survey 2022*.
- Koire, A., Mittal, L., Erdei, C., & Liu, C. H. (2021). Maternal-fetal bonding during the COVID-19 pandemic. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04272-9>
- Koumarianou, A., Symeonidi, A. E., Kattamis, A., Linardatou, K., Chrousos, G. P., & Darviri, C. (2021). A review of psychosocial interventions targeting families of children with cancer. In *Palliative and Supportive Care* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/S1478951520000449>
- Kwon, B., Lee, I. H., & Lee, G. (2023). Maternal predictors of children's mental health in low-income families: A structural equation model. *International Journal of Mental Health Nursing*, 32(1). <https://doi.org/10.1111/inm.13071>
- Lee, M. F., Bolton, K., Madsen, J., & Burke, K. J. (2023). A systematic review of influences and outcomes of body image in postpartum via a socioecological framework. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*. <https://doi.org/10.1080/02646838.2023.2252453>
- Martínez de Pisón, R. (2023). Religion, spirituality and mental health: the role of guilt and shame. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 25(4). <https://doi.org/10.1080/19349637.2022.2109241>
- Modak, A., Ronghe, V., Gomase, K. P., Mahakalkar, M. G., & Taksande, V. (2023). A Comprehensive Review of Motherhood and Mental Health: Postpartum Mood Disorders in Focus. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.46209>
- Papotot, G. S., Rompies, R., & Salendu, P. M. (2021). Pengaruh Kekurangan Nutrisi Terhadap Perkembangan Sistem Saraf Anak. *Jurnal Biomedik:JBM*, 13(3). <https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31830>
- R.C.W., M., M.I., S., W.H., T., H.D., M., & P.M., C. (2016). Clinical management of pregnancy in the obese mother: before conception, during pregnancy, and post partum. In *The Lancet Diabetes and Endocrinology* (Vol. 4, Issue 12).

- Saharoy, R., Potdukhe, A., Wanjari, M., & Taksande, A. B. (2023). Postpartum Depression and Maternal Care: Exploring the Complex Effects on Mothers and Infants. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.41381>
- Santos, D. S., Santos, D. N., De Cássia Ribeiro Silva, R., Hasselmann, M. H., & Barreto, M. L. (2011). Maternal common mental disorders and alnutrition in children: A case-control study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 46(7). <https://doi.org/10.1007/s00127-010-0220-4>
- Saur, A. M., Santos, M. A. D., Carvalho, L. A., & Bettiol, H. (2020). The influence of environmental and genetic factors on maternal mental health. *Pediatric Research*, 87.
- Savolainen, O., Sormunen, M., & Turunen, H. (2021). Public health nurses' perceptions on promotive and risk factors for children's mental health: A qualitative interview study. *Journal of Advanced Nursing*, 77(12). <https://doi.org/10.1111/jan.14987>
- Siddique, R., Khan, S., Shabana, Li, M., Xue, M., Ghanim, K. Al, Kaimkhani, Z. A., & Mahboob, S. (2022). Neurological complications of COVID-19 in children and the associated immunological responses. In *Journal of King Saud University - Science* (Vol. 34, Issue 3). <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2022.101884>
- Sumarni, S., Prawitasari, S., & Putri, I. (2020). The effect of midwife training in strengthening the mental health of postpartum mother. *Journal of Community Empowerment for Health*, 3(1). <https://doi.org/10.22146/jcoemph.41269>
- Syahputra, T. A., Syahrizal, & Farizca, A. (2022). Hubungan Antara Kesehatan Mental Ibu dengan Pola Asuh Terhadap Anak. *Jurnal Kedokteran Naggroe Medika*, 5(1).
- Torti, J., Klein, C., Foster, M., & Shields, L. E. (2023). A Systemwide Postpartum Inpatient Maternal Mental Health Education and Screening Program. *Nursing for Women's Health*, 27(3). <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2022.12.005>
- Tripathi, P., Dwivedi, P. S., & Sharma, S. (2023). Psychological impact of domestic violence on women in India due to COVID-19. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 16(2). <https://doi.org/10.1108/IJHRH-12-2021-0208>
- Uy, J. P., Tan, A. P., Broeckman, B. B. F. P., Gluckman, P. D., Chong, Y. S., Chen, H., Fortier, M. V., Meaney, M. J., & Callaghan, B. L. (2023). Effects of maternal childhood trauma on child emotional health: maternal mental health and frontoamygdala pathways. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 64(3). <https://doi.org/10.1111/jcpp.13721>
- Vassilopoulos, A., Mohammad, S., Dure, L., Kozłowska, K., & Fobian, A. D. (2022).

Treatment Approaches for Functional Neurological Disorders in Children. In *Current Treatment Options in Neurology* (Vol. 24, Issue 2). <https://doi.org/10.1007/s11940-022-00708-5>

Vieira-Meyer, A. P. G. F., Morais, A. P. P., dos Santos, H. P. G., Yousafzai, A. K., Campelo, I. L. B., & Guimarães, J. M. X. (2022). Violence in the neighborhood and mental health of community health workers in a Brazilian metropolis. *Cadernos de Saude Publica*, 38(12). <https://doi.org/10.1590/0102-311XEN022122>

Williams, A., Sarker, M., & Ferdous, S. T. (2018). Cultural Attitudes toward Postpartum Depression in Dhaka, Bangladesh. *Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness*, 37(3). <https://doi.org/10.1080/01459740.2017.1318875>

World Health Organization. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. In *WHO Publication*.

Xie, R., Wu, W., Jiang, M., Sun, Z., Li, W., & Ding, W. (2024). The reciprocal relationship between child maltreatment and children's bullying victimization in China. *Aggressive Behavior*, 50(2). <https://doi.org/10.1002/ab.22140>

G. Glosarium

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

EPDS = Edinburgh Postnatal Depression Scale

KDRT = Kekerasan Dalam Rumah Tangga

CHAPTER 6

BIDAN DALAM PROGRAM IMUNISASI: PENINGKATAN KETERCAPAIAN DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT

Merry Margaritha Verawaty Seu, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Agenda Imunisasi 2030 (WHO,IA 2030,2020) menetapkan visi dan strategi global yang ambisius dan menyeluruh untuk vaksin dan imunisasi dalam dekade 2021–2030. Program ini diambil dari pembelajaran berdasarkan tantangan yang berlanjut dan baru akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular serta memanfaatkan peluang untuk mengatasi tantangan tersebut.

Imunisasi merupakan kisah sukses bagi kesehatan dan pembangunan global, yang menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Antara tahun 2010 dan 2018, 23 juta kematian dapat dicegah hanya dengan vaksin campak (Patel MK., et al., 2019) Jumlah bayi yang divaksinasi setiap tahunnya – lebih dari 116 juta, atau 86% dari seluruh bayi yang lahir – telah mencapai tingkat tertinggi yang pernah dilaporkan. Lebih dari 20 penyakit yang mengancam jiwa sekarang dapat dicegah dengan imunisasi (WHO.,2019)

Vaksin sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit menular dan karenanya menjadi dasar keamanan kesehatan global. Vaksin secara luas dianggap penting untuk mengatasi penyakit menular yang baru muncul, misalnya dengan membendung atau membatasi wabah penyakit menular atau memerangi penyebaran resistensi antimikroba.

Sejak Mei 2012, World Health Assembly (WHA) telah memprakarsai Pekan Imunisasi Dunia yang diperingati pada tiap minggu ke-4 bulan April (24 – 30 April). Hingga saat ini, Pekan Imunisasi Dunia telah dilaksanakan oleh lebih dari 180 negara melalui pelaksanaan berbagai kegiatan. Kegiatan Imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 kegiatan Imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B. Beberapa penyakit yang saat ini menjadi perhatian dunia dan merupakan komitmen global yang wajib diikuti oleh semua negara adalah eradikasi polio (ERAPO), eliminasi campak dan rubella dan Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN)(Kemenkes. 2024)

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia mempunyai beban ganda (*double burden*), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat *cost effective*. (PMK 12,2017)

Tantangan penting saat ini adalah manfaat imunisasi yang tidak merata: cakupannya sangat bervariasi di antara dan di dalam negara. Beberapa populasi – sering kali yang termiskin, paling terpinggirkan, dan paling rentan, di lingkungan yang rapuh dan dilanda konflik – memiliki akses yang buruk terhadap layanan imunisasi.

Di Indonesia, rendahnya akses terhadap pelayanan imunisasi dan pelayanan kesehatan lainnya di masa pandemi memberikan “PR” tersendiri dalam pelaksanaan program imunisasi. Pada tahun 2024 dilaporkan, sebanyak 2,8 juta anak yang tidak atau belum mendapatkan imunisasi lengkap di tahun 2021-2023. Anak-anak tersebut tersebar di 309 kabupaten/kota yang terdapat di 38 provinsi. Kondisi ini mendorong Indonesia mengejar ketertinggalan untuk menutup gap imunitas melalui advokasi dan sosialisasi guna meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah beserta lintas sektor/lintas program, penyebarluasan informasi dan edukasi, peningkatan kapasitas dan *on the job training* bagi tenaga kesehatan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi capaian imunisasi serta penggerakan kader. (Kemenkes, Panduan PIN. 2024)

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan imunisasi di tingkat primer, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, tenaga pengelola Imunisasi Program terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik. Kedua tenaga pengelola tersebut harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. (Permenkes, 2017). Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang seorang bidan, sehingga bidan pun berperan dalam pelaksanaan imunisasi sampai kepada pelaporan dan evaluasi.

B. Kebijakan Program Imunisasi

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia pada 6 pilar transformasi sebagai penopang sistem kesehatan

Indonesia. Penguatan peran dan perluasan cakupan merupakan transformasi layanan primer termaksud didalamnya peningkatan cakupan imunisasi. (Kemenkes. 2023) salah satu program utama dalam penguatan upaya preventif dilayanan primer adalah imunisasi rutin.

Imunisasi adalah suatu upaya menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.(Kemenkes.2017). Adapun manfaat imunisasi antara lain :

1. Memberikan proteksi spesifik kepada individu, orang atau anak yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu.
2. Membentuk kekebalan kelompok, apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata dapat membentuk kekebalan kelompok dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
3. Memberikan proteksi lintas kelompok, pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu (anak) dapat membatasi penularan kepada kelompok usia dewasa/orang tua.

Kementrian Kesehatan melalui Permenkes No 12 Tahun 2017, membagi imunisasi berdasarkan penyelenggaraan menjadi 2 yaitu :

1. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian ditetapkan pedoman penyelenggaraan imunisasi
2. Imunisasi Mandiri adalah imunisasi diluar imunisasi program yang diperoleh seseorang secara mandiri sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.

Imunisasi program terdiri dari :

1. Imunisasi Rutin, adalah imunisasi rutin yang dilaksanakan secara lengkap dan terus menerus serta berkesinambungan sesuai dengan siklus hidup. Imunisasi Rutin diberikan kepada:
 - a. Bayi
Anak usia 0-11 bulan; 1 dosis Hepatitis B usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis bOPV, 2 dosis IPV, 3 dosis DPT-HB-Hib, 2 dosis PCV, 3 dosis Rotavirus, serta 1 dosis Campak Rubela (MR)
 - b. Anak usai bawah dua tahun (Baduta)
Anak usia 12-23 bulan; 1 dosis PCV, 1 dosis DPT-HB-HiB, serta 1 dosis Campak Rubela
 - c. Anak usai Sekolah
Peserta didik SD/MI dan usia setara : 1 dosis DT, 1 dosis Campak Rubela, 2 dosis Td dan 2 dosis HPV (khusus untuk anak perempuan)

d. Dewasa

Wanita Usia Subur (termasuk ibu hamil); imunisasi Tetanus (sampai status T5), Imunisasi COVID-19 program pada populasi rentan yaitu lansia ≥ 60 th, lansia ≥ 60 th dengan komorbid, penyandang *immunocompromised* sedang berat (12-59 tahun), tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil*, dewasa usia 18 - 59 tahun dengan komorbid

2. Imunisasi Tambahan, pemberian dosis tambahan tanpa memandang status imunisasi untuk pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah. Yang termaksud kegiatan imunisasi tambahan antara lain *backlog fighting* yaitu upaya untuk melengkapi imunisasi pada anak dibawah 3 tahun yang diprioritaskan pada anak di desa yang dua tahun berturut turut tidak mencapai target UCI, *crash program* yaitu kegiatan yang intervensinya secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu kegiatan yang diselenggarakan secara cepat disuatu negara dengan tujuan memutuskan mata rantai suatu penyakit, dan *Catch Up Campaign* (Kampanye) yaitu kegiatan imunisasi tambahan massal yang dilakukan serentak pada kelompok sasaran tertentu dan wilayah tertentu untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit tertentu.
3. Imunisasi Pelaku Perjalanan, imunisasi yang diberikan kepada pelaku perjalanan untuk melindungi terhadap Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) pada wilayah atau situasi tertentu

Sasaran Imunisasi adalah bayi berusia 0-11 bulan, anak bawah usia dua tahun (Baduta), anak usia sekolah, wanita usia subur termaksud didalamnya calon pengantin dan usia lanjut.(Kemenkes, Pedoman Praktis. 2021)

Selain imunisasi rutin adapula imunisasi kejar. Apabila imunisasi anak terlewatkan, maka imunisasi kejar merupakan solusi untuk mengejar imunisasi yang terlewatkan.

Contoh imunisasi yang bisa di kejar seperti imunisasi hepatitis B dapat diberikan kapan saja, pada usia lebih dari 1 tahun dapat diberikan 3 dosis dengan interval 0 – 1 - 6 bulan. Polio dapat diberikan kapan saja diberikan 3 dosis OVP dan 2 dosis IPV, pada usia lebih dari 1 tahun IPV diberikan bersamaan dengan OPV 1 dan OPV 3. Pada imunisasi BCG, anak usia >3 bulan perlu dilakukan uji tuberculin terlebih dahulu, vaksin dapat diberikan apabila hasil negatif. Untuk vaksin yang mengandung DTP diberikan 3 dosis dengan interval 1 bulan antara setiap dosis, pada usia ≥ 1 tahun: 3 dosis DTP dengan interval: 0 – 1 – 6 bulan. Pada rota virus perhatikan umur maksimal dosis terakhir vaksin rotavirus (6 bulan 29 hari). Pada PCV, usia 7-12 bulan: imunisasi PCV diberikan 2 dosis dengan interval 1 bulan, Booster PCV: boleh >1 tahun dengan jarak 2 bulan dari dosis terakhir, usia 1-2 tahun:

berikan PCV 2 dosis dengan interval 2 bulan, usia 2-5 tahun: PCV 1 dosis. Pada MR dengan usia > 1 tahun dapat diberikan MR.(Kemenkes, Panduan. 2021)

Perubahan Paradigma

Imunisasi lengkap saja belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap PD3I karena beberapa antigen memerlukan booster / pemberian dosis lanjutan pada usia 18 bulan, usia anak sekolah (BIAS) dan usia dewasa (WUS), sehingga terjadi perubahan paradigma dari imunisasi bayi lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap artinya sasaran imunisasi sejak ibu hamil, melahirkan dan nifas, lalu dilanjutkan pada bayi dan baduta, lalu anak usia sekolah dan remaja diteruskan pada usia dewasa (WUS) dan terakhir pada lanjut usia.

Berdasarkan laporan Statistik Kesehatan Indonesia tahun 2023, presentasi imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (Survei BPS) sebesar 63,58% dari target 75%. Sedangkan pencapaian tahun 2022 sebesar 63,17%.

C. Tantangan dan Masalah dalam Pelayanan Imunisasi

Berdasarkan data WHO pada tahun 2022, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau disebut dengan zero dose di tingkat global yaitu 14.3 juta anak. Data ini menunjukkan penurunan dari tahun 2021 yaitu 18,1 juta anak, kondisi ini sudah hampir menyamai situasi saat sebelum pandemi di tahun 2019 (12.9 juta anak). Sementara di Indonesia, jumlah anak yang belum di imunisasi lengkap sejak 2018 sampai tahun 2023 adalah 1,879,820 anak. (Kemenkes. 2024)

Indonesia memiliki tantangan terhadap pelaksanaan pelayanan imunisasi antara lain (Kemenkes. 2024) :

1. Persepsi negatif terhadap imunisasi rutin (banyaknya rumor terkait imunisasi, imunisasi tidak aman, vaksin tidak berkualitas, menyebabkan kemandulan dan autisme, dan lain-lain)
2. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya imunisasi.
3. Manajemen pengelolaan vaksin yang kurang optimal menyebabkan kualitas vaksin yang tidak baik dan kekosongan vaksin yang mengakibatkan anak terlambat (*missed opportunity*) untuk diimunisasi
4. Keterbatasan sumber daya penganggaran dan sumber daya manusia.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target imunisasi antara lain :

1. Pembiayaan

Komitmen Pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran operasional yang masih kurang maksimal.

2. Vaccine Hesitancy

Adanya isu-isu negatif , hoax, KIPI, masih kurangnya demand dari masyarakat untuk imunisasi rutin lengkap, belum adanya pengingat jadwal imunisasi, dan terjadi kekhawatiran terhadap pemberian imunisasi ganda masih adanya penolakan

3. Sumber Daya Manusia

Sering terjadi pergantian petugas, *double job* dan petugas baru belum terlatih

4. Kolaborasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program terkait

Belum optimalnya peran lintas sektor dlm menggerakkan masy/sasaran (seperti desa/kelurahan/kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dll)

5. Pencatatan dan Pelaporan

Sejak Januari 2024, sistim RR berbasis elektronik (ASIK), sehingga kepatuhan petugas dalam menginput data belum maksimal, petugas belum familiar terhadap ASIK, masalah signal,

6. Antigen Baru

Masyarakat belum semua mengetahui dan terbiasa dengan adanya vaksin dan jadwal baru, kekhawatiran terhadap pemberian imunisasi ganda dan keterbatasan kapasitas *cold chain*

D. Peran Bidan dalam Peningkatan Ketercapaian dan Edukasi Kepada Masyarakat

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan yang berperan aktif dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak. Pemantauan kesehatan ibu dan anak ini dimulai sejak pra konsepsi bahkan sampai sepanjang siklus kehidupan. Kualitas manusia sangat ditentukan oleh kesehatan perempuan yang mengandung, melahirkan dan mengasuhnya. Bidan dalam mengawal kesehatan reproduksi wanita tidak terlepas dari transformasi sistim kesehatan Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Dalam menjalankan praktik kebidanannya, bidan berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelolah pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan serta sebagai peneliti.(Kemenkes, 2019). Dalam menjalankan peran ini, berbagai pendekatan dilakukan baik secara holistik maupun secara inovatif.

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan imunisasi bagi masyarakat.

1. Penguatan Promosi Kesehatan

Salah satu bentuk upaya promotif adalah dengan edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun mitra baik dalam lintas program maupun lintas sektor. Berbagai media sosial telah dipakai sebagai sarana promosi, mulai dari *website*, sosial media, dan *chat box* ayosehat dari kementerian. Dalam membangun promosi kesehatan diperlukan strategi KIE kesehatan. Strategi KIE kesehatan dalam melakukan promosi yang sesuai dengan *evidence based* adalah promosi berbasis data. Promosi ini efektif sampai ke hasil, *cost effective* dan *time effective*.

Bidan mempunyai peran sebagai edukator atau narasumber dalam memberikan edukasi tentang kesehatan khususnya imunisasi, dapat pula sebagai pemberi informasi terkait data capaian berdasarkan pelaporan kegiatan yang dilakukan. Peran bidan juga memantau atau sebagai penginput dalam aplikasi ASIK.

2. Strategi Komunikasi Imunisasi

Strategi komunikasi informasi ini diharapkan sampai pada skala Kabupaten/Kota.

Melalui *assessment* dan analisa diharapkan mendapatkan permasalahan kunci dari pada target sasaran. Setelah didapatkan permasalahan kunci maka dapat ditetapkan tujuan yang relevan sesuai dengan daerah masing-masing. Mulai memilih pesan kunci dan pendukung serta menadaptasikan kedalam konteks lokal. Selanjutnya melakukan pendekatan dan saluran komunikasi yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan di daerah. Kemudian menurunkan strategi dengan rencana aksi/implementasi beserta perencanaan pembiayaan. Strategi komunikasi nasional akan berkontribusi pada pencapaian target nasional imunisasi sejumlah 90% dari anak usia 12-23 bulan dan 80% dari anak berusia 0-11 bulan pada 514 Kab/Kota diimunisasi lengkap oleh 2024 (RPJMN 2020 – 2024).

Pesan kunci/pemicu dalam skala nasional adalah ""#TujuhKunjungan dalam #DuaTahun untuk Perlindungan #SepanjangHayat"; dan "Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Lengkap". Selain pesan kunci juga dilakukan pendekatan komunikasi yang dapat dilakukan melalui posyandu, kunjungan rumah, tele konsultasi, kelas ibu hamil, Kelas BKB, pengajian/acara keagamaan, kegiatan komunitas, media sosial dan daring. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Tenaga kesehatan dan kader, Dinas Kab/Kota, Tokoh Agama dan Masyarakat, Tokoh Komunitas, Mitra non pemerintah, *Influencers*

Peningkatan kapasitas merupakan salah satu strategi dalam komunikasi yang dapat dilakukan Pelatihan tatap muka/daring, lokakarya, studi kasus, simulasi. Kegiatan ini dapat dilakukan Kemenkes, Dinkes Provinsi, Kab/Kota, Organisasi Keagamaan, Tenaga Kesehatan, dan Mitra non pemerintah.

Advokasi juga dapat mendukung peningkatan strategi komunikasi yang dapat dilakukan melalui sesi Posyandu, kunjungan rumah, tele konsultasi, kelas ibu hamil, Kelas BKB, pengajian/acara keagamaan, kegiatan komunitas, media sosial dan daring dilakukan tidak terbatas oleh Tenaga kesehatan dan kader, Dinas Kab/Kota, Tokoh Agama dan Masyarakat, Tokoh Komunitas, Mitra non pemerintah, *Influencers*. Tujuan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi rutin lengkap ditatanan pemangku kebijakan, serta masyarakat. Selain itu ada pula hubungan masyarakat yang sangat membantu proses komunikasi.

3. Penguatan Posyandu Dan Peningkatan Kapasitas Kader

Jumlah tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan. Misalnya bidan diharapkan satu desa terdapat minimal satu orang bidan. Untuk itu peranan kades kesehatan sangatlah penting dalam meningkatkan layanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Untuk megintervensi masalah kesehatan dan berbagai kolaboari perlu dibangun mulai dari tingkat RT dan RW.(Ragil,2024)

Kementrian kesehatan telah menyusun 25 ketrampilan dasar kader posyandu sebagai bentuk implementasi transformasi kesehatan layanan primer. Peran bidan dalam penguatan posyandu dan peningkatan kapasitas kader antar lain sebagai pengelola, pelaksana, dan fasilitator disamping melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan posyandu dan peningkatan kapasitas kader juga pengawasan terhadap ketrampilan dasar kader posyandu.

4. Membangun Literasi Kesehatan Disekolah

Dari beban kesehatan, teridentifikasi 22 topik kesehatan yang diharapkan dapat masuk ke dalam peningkatan literasi sehat di sekolah, melalui 7 bahan ajar antara lain: pendidikan gizi, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan jiwa, pendidikan kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, pendidikan perilaku sehat, pendidikan penyakit menular dan pendidikan kesiapsiagaan bencana.

5. Mendorong Tumbuhnya Gerakan Sehat

Membangun gerakan dalam meningkatkan promosi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, cakupan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Ada 5 gerakan sehat dalam strategi untuk meningkatkan cakupan melalui gerakan mencegah shunting antara lain: aksi bergizi, bumil sehat, posyandu aktif, jambore kader dan cegah shunting.

Dalam aksi bergizi, kegiatan yang dilakukan antara lain *screening* anemia, sarapan bersama dan konsumsi tablet tambah darah. Fokus kegiatan pada peningkatan asupan zat besi melalui makanan, tetapi juga melalui edukasi

mengenai pentingnya deteksi dini dan suplementasi zat besi terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. Bidan berperan selain sebagai pengelolah pelayanan, sebagai penyuluh dan konselor dalam mengedukasi pentingnya zat besi yang didapat dari nutrisi zat gizi juga dari tablet tambah darah. Selain itu juga memonitoring kesehatan ibu hamil dengan *screening* anemia dan mengedukasi pemberian suplemen zat besi karena rendahnya kepatuhan minum obat akibat kurangnya pemahaman akan bahaya anemia.(MMV.Seu., et al. 2019)

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Kemitraan

Indonesia dengan modal sosial yang maju dan tinggi, memiliki banyak organisasi kesehatan. Ada 364 mitra kesehatan yang terdaftar di kementerian kesehatan. Kemitraan ini berasal dari akademi, bisnis, komunitas, Government dan media sosial.(Kemenkes, 2024). Bidan berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kemitraan dengan bekerja sama mengembangkan kegiatan yang mendukung peningkatan cakupan antara lain seperti dengan media sosial menyebarkan informasi terkait imunisasi melalui media sosial, buku, podcast. Walaupun menurut Rina Bastian, salah satu hambatan dalam meningkatkan partisipasi mitra adalah komunikasi (Rina bastian.,et.all.2020) namun media sosial menjadi saluran yang paling diminati, yang dapat dilakukan melalui tatap muka, lokakarya, studi kasus, simulasi dan dapat dilakukan oleh Kementerian, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Organisasi Agama, Organisasi Profesi maupun mitra kesehatan.

Dalam mendukung program imunisasi, seorang bidan harus memahami peran dan tugasnya dalam meningkatkan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya. Peran tersebut antara lain :

- a. Mengoptimalkan upaya advokasi dan koordinasi untuk menggalang komitmen dan dukungan dari Pimpinan Daerah setempat dan lintas sektor terkait
- b. Memastikan upaya pergerakan masyarakat dilaksanakan seoptimal mungkin dengan melibatkan LP/LS terkait
- c. Memastikan pelayanan imunisasi dilaksanakan sesuai prosedur dan vaksin yang diberikan terjaga kualitasnya
- d. Memastikan anak-anak di wilayah kerja puskesmas mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia
- e. Memastikan akurasi pencatatan dan pelaporan

Selain itu, jika bidan diberikan tanggungjawab sebagai pemegang program imunisasi, maka harus menjalankan tugasnya dengan baik antara lain (Kemenkes, pedoman praktis. 2021) :

- a. Menyusun mikroplaning
- b. Menyusun SOP penyelenggaraan pelayanan imunisasi
- c. Menyediakan pelayanan imunisasi berkualitas
- d. Melaksanakan pengelolaan vaksin dan rantai vaksin yang efektif
- e. Melaksanakan kegiatan pelacakan bayi dan baduta yang belum/tidak lengkap status imunisasinya
- f. Melaksanakan pencatatan pelaporan sesuai prosedur
- g. Melakukan analisa dan monitoring data secara rutin
- h. Menyusun dan menyampaikan umpan balik kepada Kepala Puskesmas, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat daerah lainnya, serta lintas sektor terkait di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
- i. Melakukan investigasi KIPI
- j. Melaksanakan upaya supervisi dan evaluasi
- k. Program imunisasi
- l. Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada petugas pelaksana layanan imunisasi di puskesmas dan desa
- m. Disamping itu menjalankan tugas melakukan pemberian imunisasi.

E. Simpulan

Permasalahan cakupan imunisasi sangat kompleks. Semua pihak diharapkan dapat terlibat mempromosikan pentingnya imunisasi rutin lengkap dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyehatkan bangsa dalam upaya mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Oleh karena setia anak berhak mendapatkan imunisasi yang rutin dan lengkap maka tidak ada kate terlambat untuk imunisasi.

F. Referensi

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Panduan Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2024, Jakarta
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Permenkes RI No 12 tahun 2017 Tentang Imunisasi. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111977/permenkes-no-12-tahun-2017>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). UU No 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. Jakarta. <file:///C:/Users/USER/Downloads/UU%20Nomor%204%20Tahun%202019-3.pdf>

- Kementrian Kesehatan. 2024. Kemitraan. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kemitraan>
- Kementrian kesehatan, <https://kemkes.go.id/id/media/all>
- MMV.S., JC.Mose., R.Panigoro., E. Sahiratmaja. (2019). [Anemia prevalence after iron supplementation among pregnant women in midwives practice of primary health care facilities in Eastern Indonesia](https://doi.org/10.1155/2019/1413906). Anemia Journal, <https://doi.org/10.1155/2019/1413906>
- Patel MK., Dumolard L., Nedelec Y., Sodha S., Steulet C., Kretsinger K., dkk. (2019). Kemajuan Menuju Eliminasi Campak Regional – Di Seluruh Dunia, 2000–2018. Wkly Epidemiol Rec. 2019;49: 581–600.
- Rina bastian., Ishak abdulak., Yanti Shantini. 2020. Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 2 (4)112
- Ragil Romli. 2024. Kader Posyandu Menjadi Ujung Tombak Dalam Pencegahan Dan Promosi Kesehatan Di Tingkat Desa Dan Dusun. Kerja Sama Lintas Sektor Diperlukan Dalam Integrasi Layanan Primer. Memperkuat Layanan primer, 171. Mediakom. <https://link.kemkes.go.id/mediakom>.
- World health Organization. (2020). Immunization Agenda 2030 A global strategy to leave no one behind. IA 2030. Retrieved from <https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030>
- World Health Organization. (2019). Vaccines and diseases. (<https://www.who.int/immunization/diseases/en>, accessed March 2020). https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1

CHAPTER 7

PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA OLEH BIDAN

Yulianik, AMd.Keb., S.KM., M.Biomed.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan fisik dan emosional remaja yang mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Pada usia remaja, individu mengalami berbagai perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi sistem reproduksi mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan untuk menghindari masalah kesehatan yang bisa muncul, seperti penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, dan gangguan hormonal. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan membekali mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab terkait tubuh mereka. Dengan pendekatan yang tepat, remaja dapat lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi pada tubuh mereka dan menjaga kesehatan reproduksi mereka sepanjang hidup. Kesehatan reproduksi bagi remaja sangat penting karena periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana banyak perubahan fisik, hormon, dan psikologis terjadi. Pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, menghindari risiko kesehatan, dan membuat keputusan yang bijak terkait dengan kehidupan seksual dan reproduksi. Berikut beberapa alasan mengapa kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja:

1. Menghindari Risiko Kesehatan: Remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi lebih rentan terhadap risiko kesehatan seperti infeksi menular seksual (IMS), kehamilan yang tidak direncanakan, dan gangguan hormonal. Dengan pemahaman yang tepat, remaja dapat mengurangi risiko-risiko tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih sehat.
2. Pendidikan Seksual yang Benar: Menyediakan informasi yang akurat tentang seksualitas, kontrasepsi, dan dampak hubungan seksual di usia muda membantu remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Pendidikan seksual yang tepat dapat mencegah perilaku berisiko, seperti hubungan seksual yang tidak aman.

3. Meningkatkan Kesadaran tentang Tubuh: Pada masa remaja, tubuh mengalami perubahan besar, seperti menstruasi pada perempuan dan peningkatan produksi hormon pada laki-laki. Dengan memahami perubahan ini, remaja bisa lebih siap dalam menghadapinya dan menjaga kesehatan reproduksi mereka.
4. Mendukung Kesehatan Mental: Perubahan hormonal yang terjadi selama masa remaja bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental. Pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dapat membantu remaja mengatasi kecemasan atau kebingungan terkait tubuh mereka, serta memperkuat kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka.
5. Mencegah Kehamilan Remaja: Salah satu alasan pentingnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada usia muda. Kehamilan di usia remaja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan pribadi remaja.

Dengan demikian, pendidikan dan perhatian yang tepat terhadap kesehatan reproduksi sangat penting untuk membantu remaja berkembang menjadi individu yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang tepat terkait dengan tubuh dan kehidupan mereka.

B. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Remaja

Remaja adalah masa transisi antara anak-anak dan dewasa, yang biasanya berlangsung antara usia 10 hingga 19 tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan fisik, emosional, dan sosial, di mana individu mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi tubuh, pemikiran, serta hubungan mereka dengan orang lain. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai remaja, yang mencakup berbagai aspek dari kehidupan mereka:

a. Perubahan Fisik

Pada masa remaja, tubuh mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang disebabkan oleh perkembangan hormon. Perubahan ini mencakup:

- 1) Pubertas: Proses fisik yang menandai transisi dari anak-anak ke dewasa. Pada perempuan, pubertas ditandai dengan pertumbuhan payudara, menstruasi pertama, dan perubahan bentuk tubuh, sedangkan pada laki-laki, ditandai dengan pembesaran testis, suara menjadi lebih berat, serta tumbuhnya rambut di wajah dan tubuh.

- 2) Pertumbuhan Tinggi dan Berat: Remaja mengalami lonjakan pertumbuhan tinggi badan dan penambahan berat badan yang cepat. Hal ini biasanya terjadi pada awal masa pubertas.
- 3) Perubahan Reproduksi: Remaja mulai mengembangkan kemampuan reproduksi, yang menjadi dasar dari kemampuan untuk melahirkan anak di masa depan.

b. Perubahan Emosional dan Psikologis

Masa remaja juga merupakan periode di mana individu mulai mengalami perubahan besar dalam hal perasaan dan pemikiran. Beberapa aspek penting dalam perubahan emosional dan psikologis remaja antara lain:

- 1) Pencarian Identitas: Remaja sering kali mengalami kebingungan dalam mencari identitas diri. Mereka mulai mencari tahu siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka inginkan dalam hidup, serta nilai dan keyakinan mereka.
- 2) Pengaruh Teman Sebaya: Pada usia ini, pengaruh teman sebaya menjadi sangat kuat. Remaja sering kali lebih mendengarkan pendapat dan perilaku teman mereka dibandingkan dengan orang dewasa.
- 3) Perubahan Perasaan: Remaja sering kali mengalami fluktuasi emosional yang tajam, seperti perasaan cemas, marah, bahagia, atau stres. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi pada tubuh mereka.
- 4) Pencapaian Kematangan Sosial dan Emosional: Remaja mulai belajar bagaimana mengelola hubungan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, maupun dengan lawan jenis. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan dalam menghadapi tantangan hidup dan membuat keputusan.

c. Perkembangan Kognitif

Dalam hal perkembangan kognitif, remaja mengalami peningkatan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Mereka mulai dapat berpikir lebih kritis, menganalisis berbagai situasi, dan merencanakan masa depan. Beberapa aspek perkembangan kognitif yang signifikan pada masa remaja antara lain:

- 1) Pemikiran Abstrak: Remaja mulai berpikir lebih jauh dari sekadar hal-hal yang konkret. Mereka dapat memahami konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti moralitas, hak asasi manusia, dan kebebasan.
- 2) Peningkatan Kemampuan Mengambil Keputusan: Remaja mulai belajar bagaimana membuat keputusan yang lebih baik dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan mereka.

- 3) Peningkatan Kemampuan Belajar: Remaja memiliki kemampuan untuk belajar lebih cepat dan memahami informasi yang lebih rumit, serta mereka mulai merencanakan dan mengejar tujuan pendidikan dan karier di masa depan.

d. Perubahan sosial

Masa remaja adalah waktu di mana individu mulai mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks. Mereka belajar tentang hubungan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, maupun dengan lawan jenis. Beberapa hal penting terkait perubahan sosial pada remaja adalah:

- 1) Hubungan dengan Keluarga: Pada masa remaja, hubungan dengan keluarga bisa mengalami ketegangan. Remaja sering kali ingin mencari kebebasan lebih, sementara orang tua masih memberikan batasan dan kontrol. Namun, komunikasi yang baik antara remaja dan keluarga tetap penting untuk mendukung perkembangan mereka.
- 2) Pengaruh Teman Sebaya: Teman sebaya memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial remaja. Remaja cenderung mencari identitas sosial melalui kelompok teman-teman mereka, yang bisa mempengaruhi perilaku, nilai, dan keputusan mereka.
- 3) Eksplorasi Hubungan Romantis: Remaja mulai tertarik pada hubungan romantis dan cinta pertama. Ini adalah bagian dari perkembangan emosional dan sosial mereka dalam memahami perasaan terhadap orang lain.

e. Masalah yang Dihadapi Remaja

Meskipun masa remaja merupakan periode yang penuh dengan peluang dan potensi, remaja juga menghadapi berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mereka. Beberapa masalah umum yang dihadapi remaja antara lain:

- 1) Tekanan Sosial: Remaja sering kali merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok teman mereka atau mengikuti tren yang ada, yang kadang mengarah pada perilaku berisiko, seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau hubungan seksual yang tidak aman.
- 2) Kesehatan Mental: Remaja rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. Perubahan hormonal dan tekanan sosial dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka.
- 3) Pendidikan dan Karier: Remaja juga harus menghadapi tekanan untuk memilih jalur pendidikan dan karier yang akan membentuk masa depan mereka. Ini bisa menjadi sumber kecemasan dan kebingungan bagi banyak remaja.

- 4) Kehamilan Remaja dan Penyakit Menular Seksual: Remaja yang terlibat dalam hubungan seksual tanpa pemahaman yang cukup tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi berisiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular seksual.

f. Pendidikan dan Dukungan untuk Remaja

Agar remaja dapat melewati masa transisi ini dengan baik, mereka membutuhkan pendidikan dan dukungan yang tepat. Pendidikan tentang kesehatan fisik, mental, dan reproduksi sangat penting untuk membantu remaja membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan remaja.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah aspek penting dalam tumbuh kembang remaja yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, kesehatan seksual, serta perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang terjadi selama masa transisi ini. Kesehatan reproduksi yang baik pada masa remaja tidak hanya berhubungan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup pemahaman, pengetahuan, dan sikap yang benar mengenai tubuh, hubungan, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan seksual.

Masa remaja ditandai dengan perubahan besar pada tubuh yang terjadi akibat pubertas. Pubertas adalah periode ketika tubuh remaja berkembang menjadi tubuh dewasa yang mampu melakukan fungsi reproduksi. Proses pubertas dimulai karena rangsangan hormon-hormon tertentu dari otak yang mempengaruhi organ tubuh lainnya. Perubahan fisik yang terjadi mencakup:

a. Pada perempuan:

- 1) Menstruasi: Proses menstruasi pertama, yang dikenal dengan istilah menarche, terjadi di awal pubertas, biasanya antara usia 9 hingga 16 tahun. Menstruasi menandakan bahwa tubuh perempuan sudah mulai matang secara reproduksi dan dapat hamil.
- 2) Pertumbuhan Payudara: Pembesaran payudara adalah salah satu tanda pertama pubertas pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen yang mempengaruhi perkembangan jaringan payudara.
- 3) Perubahan Bentuk Tubuh: Tubuh perempuan akan lebih berbentuk dengan perkembangan pinggul yang lebih lebar, penambahan lemak tubuh di sekitar dada dan pinggul, serta perawakan yang lebih tinggi.

b. Pada laki-laki:

- 1) P pembesaran Testis dan Penis: Pada laki-laki, perubahan pubertas ditandai dengan pembesaran testis dan penis yang terjadi pada awal pubertas, biasanya sekitar usia 10 hingga 14 tahun.
- 2) Perubahan Suara: Suara laki-laki menjadi lebih berat atau lebih dalam seiring dengan perkembangan laring (kotak suara) yang lebih besar.
- 3) Pertumbuhan Rambut Tubuh: Remaja laki-laki akan mulai tumbuh rambut di wajah, dada, dan daerah kemaluan.
- 4) Peningkatan Massa Otot: Laki-laki akan mengalami peningkatan massa otot yang signifikan sebagai respons terhadap peningkatan hormon testosteron.

3. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi kepada remaja. Penyuluhan ini bertujuan untuk membantu remaja memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama masa pubertas, serta memberi mereka pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait tubuh mereka, kehidupan seksual, dan kesehatan reproduksi secara keseluruhan.

Penyuluhan kesehatan reproduksi sangat penting karena pada masa remaja, individu mulai mengalami perubahan besar dalam tubuh mereka, dan seringkali mereka memiliki sedikit pengetahuan atau pemahaman yang cukup mengenai hal tersebut. Tanpa pendidikan yang memadai, remaja dapat terjebak dalam keputusan yang berisiko, seperti hubungan seksual yang tidak aman, kehamilan yang tidak direncanakan, atau penyalahgunaan obat-obatan yang memengaruhi kesehatan reproduksi mereka.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi remaja:

- a. Tujuan utama dari penyuluhan kesehatan reproduksi adalah untuk memberikan informasi yang tepat dan menyeluruh mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi.
- b. Meningkatkan Pemahaman: Memberikan informasi yang jelas tentang perubahan tubuh selama pubertas, serta tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- c. Mencegah Kehamilan Tidak Direncanakan: Mengajarkan remaja mengenai cara-cara mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, seperti penggunaan kontrasepsi dan pemahaman tentang siklus menstruasi.

- d. Mencegah Penyakit Menular Seksual (PMS): Memberikan pengetahuan tentang penyakit menular seksual, cara penularannya, serta pencegahannya, termasuk penggunaan kondom dan praktik hubungan seksual yang aman.
- e. Mendorong Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab: Membantu remaja untuk membuat keputusan yang bijak tentang hubungan seksual, dengan menekankan pentingnya persetujuan, komunikasi yang jelas, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangan.
- f. Meningkatkan Kesehatan Mental dan Emosional: Mengajarkan remaja untuk menjaga kesehatan mental mereka dalam menghadapi perubahan fisik dan sosial yang cepat. Ini mencakup cara mengatasi tekanan teman sebaya, stres, kecemasan, atau perasaan tidak aman mengenai tubuh mereka.
- g. Mengurangi Stigma dan Kesalahpahaman: Mengurangi stigma dan kesalahpahaman yang mungkin dimiliki remaja mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi, dengan memberikan fakta yang tepat dan membuka ruang bagi diskusi terbuka.

4. Materi yang Disampaikan dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Materi penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja mencakup berbagai topik yang sangat relevan dengan perkembangan fisik dan sosial mereka. Beberapa materi yang penting untuk disampaikan antara lain:

- a. Perubahan Fisik Selama Pubertas: Menjelaskan tentang perubahan fisik yang terjadi pada tubuh remaja, seperti pertumbuhan payudara pada perempuan, perubahan suara pada laki-laki, serta perubahan pada organ reproduksi. Hal ini penting agar remaja memahami dan menghargai proses perkembangan tubuh mereka.
- b. Sistem Reproduksi Manusia: Memberikan informasi mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini termasuk penjelasan tentang ovarium, rahim, vagina, serta testis dan penis, serta bagaimana sistem reproduksi ini berfungsi.
- c. Menstruasi dan Siklus Reproduksi: Mengajarkan tentang siklus menstruasi pada perempuan, termasuk fase-fase dalam siklus menstruasi, serta pentingnya kebersihan menstruasi dan perawatan diri selama periode tersebut.
- d. Kontrasepsi dan Metode Pengendalian Kehamilan: Memberikan informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia, seperti kondom, pil KB, IUD, dan lainnya, serta bagaimana cara menggunakan kontrasepsi dengan benar untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
- e. Penyakit Menular Seksual (PMS): Menjelaskan tentang berbagai jenis PMS yang dapat menular melalui hubungan seksual, seperti HIV/AIDS, gonore, klamidia, herpes, dan sifilis, serta cara-cara pencegahannya. Penyuluhan juga

mencakup penekanan pada pentingnya tes kesehatan secara rutin dan pengujian untuk PMS.

- f. Hubungan Seksual yang Sehat dan Bertanggung Jawab: Menyampaikan informasi mengenai pentingnya komunikasi yang terbuka dengan pasangan, pengertian tentang persetujuan bersama, serta mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menunda hubungan seksual hingga merasa siap secara fisik dan emosional.
- g. Kesehatan Mental dan Emosional: Memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan hormon dan perasaan selama masa remaja dapat mempengaruhi kesehatan mental. Penyuluhan ini juga mencakup cara mengelola stres, kecemasan, serta pentingnya berbicara dengan orang dewasa atau profesional jika merasa tertekan atau kebingungan.
- h. Pencegahan Kekerasan Seksual: Memberikan informasi mengenai kekerasan seksual dan pentingnya menjaga diri agar terhindar dari situasi berisiko. Ini termasuk informasi tentang pelecehan seksual, eksploitasi, serta cara melindungi diri dari kekerasan dalam hubungan.

5. Metode Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja harus dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman mereka. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan antara lain:

- a. Diskusi Kelompok: Mengadakan diskusi terbuka dengan remaja untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanya tanpa merasa dihakimi.
- b. Presentasi Audiovisual: Menggunakan alat bantu visual, seperti video, poster, dan presentasi slide, untuk membantu remaja memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat.
- c. Konseling Individu: Memberikan layanan konseling pribadi bagi remaja yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut mengenai masalah kesehatan reproduksi atau perasaan pribadi yang mereka alami.
- d. Pembelajaran Berdasarkan Kasus: Menggunakan studi kasus atau skenario untuk membantu remaja memahami situasi kehidupan nyata yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam hubungan.
- e. Pelatihan Peer Educator: Melibatkan remaja sebagai pendidik sebaya (peer educator) yang dilatih untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman mereka. Metode ini dapat lebih efektif karena remaja cenderung lebih terbuka mendengarkan teman sebaya mereka.

C. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Penyuluhan kesehatan reproduksi tidak hanya melibatkan sekolah atau lembaga kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Beberapa cara keluarga dan masyarakat dapat terlibat antara lain:

1. Peran Keluarga: Orang tua harus aktif terlibat dalam memberi informasi yang benar dan terbuka kepada anak-anak mereka mengenai perubahan tubuh dan kesehatan reproduksi. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah kunci dalam menyampaikan informasi ini.
2. Pendidikan Seksualitas di Sekolah: Sekolah memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi secara formal kepada siswa, baik melalui pelajaran di kelas atau melalui program konseling.
3. Kampanye Sosial: Masyarakat dapat terlibat dalam kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, seperti melalui media massa, poster, atau kegiatan komunitas.

D. Tantangan dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Meskipun penyuluhan kesehatan reproduksi remaja sangat penting, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti:

1. Stigma Sosial dan Budaya: Di beberapa budaya, membicarakan masalah seksual dan reproduksi sering dianggap tabu, sehingga dapat menghambat penyuluhan yang efektif.
2. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan tenaga pendidik, bahan ajar, dan fasilitas yang memadai dapat membatasi kualitas dan jangkauan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja.
3. Pemahaman yang Terbatas: Remaja seringkali masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kesehatan reproduksi, yang menyebabkan mereka rentan terhadap informasi yang salah atau mitos.

E. Pendidikan kesehatan reproduksi

Pendidikan Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan remaja dalam menghadapi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi selama masa pubertas. Pendidikan ini penting agar remaja memiliki pemahaman yang benar mengenai tubuh mereka, serta tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka. Beberapa alasan mengapa pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja:

1. Menghindari Kehamilan Tidak Direncanakan: Pendidikan yang baik tentang kesehatan reproduksi memberikan informasi mengenai kontrasepsi dan

pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan di usia remaja dapat memiliki dampak sosial, emosional, dan ekonomi yang sangat besar, serta berisiko bagi kesehatan fisik remaja perempuan.

2. Mencegah Penyakit Menular Seksual (PMS): Remaja yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara melindungi diri mereka dari PMS dapat lebih rentan terhadap infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Pendidikan kesehatan reproduksi yang baik akan memberikan informasi tentang cara melindungi diri dari PMS, termasuk penggunaan kondom dan pemahaman tentang infeksi menular seksual yang umum.
3. Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi: Dengan memahami perubahan tubuh yang terjadi selama pubertas, remaja dapat lebih menghargai tubuh mereka dan tahu kapan harus mencari bantuan medis jika mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti gangguan menstruasi, nyeri hebat, atau masalah hormonal lainnya.
4. Menumbuhkan Sikap Bertanggung Jawab: Pendidikan tentang kesehatan reproduksi juga mengajarkan remaja untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap tubuh mereka dan hubungan seksual. Mereka akan belajar untuk menghargai diri sendiri, menghindari hubungan seksual yang tidak aman, dan mengerti pentingnya kesepakatan dan persetujuan dalam hubungan.

Meskipun masa remaja adalah periode perkembangan, ada berbagai masalah kesehatan reproduksi yang dapat memengaruhi remaja, baik pada remaja perempuan maupun laki-laki.

1. Gangguan Menstruasi: Banyak remaja perempuan yang mengalami gangguan menstruasi di awal periode menstruasi mereka. Beberapa masalah yang umum terjadi adalah siklus menstruasi yang tidak teratur, nyeri menstruasi (dismenore), atau menstruasi yang sangat berat.
2. Kehamilan Remaja: Salah satu masalah terbesar yang dihadapi remaja adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Remaja yang hamil di luar rencana mungkin tidak siap secara fisik, emosional, dan finansial untuk menjadi orangtua. Kehamilan remaja juga dapat berisiko terhadap kesehatan fisik ibu dan bayi.
3. Penyakit Menular Seksual (PMS): Remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual berisiko terkena penyakit menular seksual. Beberapa PMS yang sering terjadi pada remaja termasuk klamidia, gonore, herpes genital, dan HIV/AIDS. Banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mencegah PMS, sehingga mereka rentan terhadap infeksi.
4. Masalah Kesehatan Mental: Perubahan hormonal selama pubertas dapat menyebabkan fluktuasi emosi yang signifikan. Remaja bisa mengalami kecemasan, depresi, atau stres terkait dengan perubahan tubuh mereka atau

tekanan sosial yang mereka hadapi. Kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.

5. Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol: Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan alkohol atau narkoba lebih berisiko terlibat dalam perilaku seksual berisiko, seperti hubungan seksual tanpa perlindungan atau kehamilan yang tidak direncanakan.

Pendidikan dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mendukung kesehatan reproduksi remaja antara lain:

1. Komunikasi Terbuka: Orang tua perlu membuka saluran komunikasi yang terbuka dengan remaja mereka tentang perubahan tubuh, hubungan seksual, dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Ini membantu remaja merasa didukung dan lebih percaya diri untuk mencari informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi mereka.
2. Pendidikan Seksualitas yang Holistik: Pendidikan seksualitas yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai kesehatan, keselamatan, dan martabat manusia penting untuk diajarkan di sekolah dan oleh orang tua. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang tubuh, hubungan, kontrasepsi, dan penyakit menular seksual.
3. Dukungan Kesehatan: Layanan kesehatan yang dapat diakses oleh remaja, seperti klinik kesehatan reproduksi dan konseling, sangat penting untuk mendukung mereka. Layanan ini dapat memberikan informasi, pemeriksaan kesehatan, dan konseling bagi remaja yang membutuhkan bantuan terkait masalah kesehatan reproduksi atau emosional.

Untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja, perlu adanya upaya pencegahan yang melibatkan edukasi, kebijakan yang mendukung, dan layanan kesehatan yang memadai. Beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1. Penyuluhan tentang Kontrasepsi: Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang berbagai metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual.
2. Penggunaan Kondom: Penggunaan kondom adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan.

3. Mendorong Remaja untuk Menunda Hubungan Seksual: Mengajarkan remaja untuk menunda hubungan seksual hingga mereka merasa siap secara emosional, fisik, dan sosial.

F. Kesimpulan

Masa remaja adalah periode yang penuh dengan perubahan besar, baik fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Meskipun masa ini dapat menjadi waktu yang penuh tantangan, juga merupakan masa yang sangat penting untuk membangun dasar kehidupan yang sehat dan produktif di masa depan. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan dari orang-orang terdekat, serta kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kesehatan reproduksi remaja adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat masa remaja adalah periode perkembangan yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pendidikan yang baik mengenai kesehatan reproduksi dapat membantu remaja menjaga kesehatannya, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mencegah masalah kesehatan yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Dengan adanya dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, remaja dapat melewati masa ini dengan lebih sehat dan siap menghadapi kehidupan dewasa. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja merupakan langkah penting untuk memberikan informasi yang tepat, menyeluruh, dan berbasis pada bukti kepada remaja. Dengan penyuluhan yang efektif, remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai tubuh mereka, menjaga kesehatan reproduksi mereka, serta menghindari risiko kesehatan seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan penyakit menular seksual. Penyuluhan yang baik akan membekali remaja dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjalani masa remaja dengan sehat, bertanggung jawab, dan aman.

G. Referensi

- BKKBN. (2013). *Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI. (2014). *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja: Pedoman bagi Tenaga Pendidik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewi, D., & Sari, A. (2020). *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Meningkatkan Kesadaran Seksual*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

- Guttmacher Institute. (2019). *Adolescents and Sexual and Reproductive Health: Key Facts and Figures*. New York: Guttmacher Institute.
- Mulianta, I. A., & Rina, M. (2015). *Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Seksual untuk Remaja*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Rohmah, U. (2018). *Peran Pendidikan Seksual dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja*. Surabaya: Penerbit UMM Press.
- Suharyadi, A., & Hidayati, N. (2016). *Kesehatan Reproduksi Remaja: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suharyadi, A., & Hidayati, N. (2016). *Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syamsudin, M., & Rina, M. (2018). *Strategi Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Surabaya: Penerbit UMM Press.
- Taufik, M., & Hasanah, R. (2017). *Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja: Perspektif Pendidikan Seksual*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Taufik, M., & Hasanah, R. (2017). *Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan Seksual bagi Remaja*. Bandung: Alfabeta.
- UNFPA. (2019). *Reproductive Health Education for Adolescents: A Handbook for Teachers and Trainers*. New York: United Nations Population Fund.
- UNICEF. (2020). *The State of the World's Children 2020: Reimagining a Better Future for Every Child*. New York: United Nations Children's Fund.
- WHO. (2018). *Adolescent Health: A Handbook for Health Professionals*. Geneva: World Health Organization.
- Wulandari, T., & Hapsari, A. (2015). *Model Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zulkarnain, A., & Rasyid, R. (2012). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.

PROFIL PENULIS



Stella Maris Bakara, S.Tr.Keb., M.K.M., lahir di Tanjung Karang, 24 Oktober 1993. Jenjang pendidikan Diploma 3 ditempuh di STIKES Panca Bhakti Bandar Lampung Prodi Kebidanan dan lulus tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan Diploma 4 Bidan Pendidik di Universitas Nasional Jakarta tahun 2017, dan melanjutkan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2019. Saat ini bekerja sebagai dosen di Institut Nalanda Jakarta pada prodi Kesehatan Tradisional/ Dharma Usada dan pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Nutrisi, Statistik, dan Metodologi Penelitian. Penulis juga aktif sebagai tim penyusun modul dan kurikulum bersama Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan UNICEF dan WHO mengenai WASH FIT di fasilitas kesehatan yang ramah GEDSI. Selain itu penulis juga ikut berperan aktif mengabdikan kepada masyarakat yaitu sebagai ketua Yayasan Bidan Membantu yang merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Penulis dapat dihubungi melalui surel stellabakara33@gmail.com



Bdn.Gustien Siahaan, SST., S.Keb., M.Kes., Lahir di Jambi, 22 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D IV Bidan Pendidik pada tahun 2013 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan S1 Kebidanan pada tahun 2018 dan Pendidikan Profesi Bidan pada tahun 2020 di Universitas Prima Medan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 sebagai Dosen Kebidanan sampai dengan saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Adiwangsa Jambi mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir, Manajemen Pelayanan Kebidanan, Profesionalisme Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui [email : Gustiensihaan89@unaja.ac.id](mailto:Gustiensiahaan89@unaja.ac.id)

PROFIL PENULIS



Sherly Jeniawaty, SST., M.Kes., Lahir di Surabaya, 20 Januari 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik, Universitas Padjajaran tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 di pelayanan RS Marinir Surabaya sebagai tenaga Honorer Bidan kemudian di RS Darmo Surabaya serta terakhir di RSI Jemursari Surabaya, dan pada Tahun 2002 diangkat menjadi tenaga pendidik CPNS di Akademi kebidanan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saat ini penulis bekerja di Prodi Kebidanan Sutomo Poltekkes Kemenkes Surabaya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui, Promosi Kesehatan, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan aktif dalam menulis dalam tema Pencegahan *Stunting*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [jeniatwatysherly@gmail.com](mailto:jeniawatysherly@gmail.com)



Ainun Ganisia, S.Keb., Bd., M.Keb., Lahir di Semarang, 20 Desember 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali penulis bekerja di S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Soetomo hingga saat ini mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja & Perimenopause, Promosi Kesehatan, dan Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ainunganisia@unitomo.ac.id



Bdn. Yuni Surya Putri, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Padang, 09 Juni 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D IV Kebidanan Poltekkes Padang, Pendidikan Profesi Bidan Universitas Fort De Kock Bukittinggi, dan melanjutkan S-2 Magister Kebidanan Universitas Andalas yang lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada bulan September tahun 2024 .Saat ini penulis bekerja di STIKes Ranah Minang Padang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yunisuryaputri@gmail.com. Motto: "Jangan pernah berhenti berusaha dan berjuang. Karena ada usaha pasti ada hasil"

PROFIL PENULIS



Merry Margaritha Verawaty Seu, SST., M.Keb., Lahir di Kupang, 02 Mei 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang Diploma IV Kebidanan pada Poltekkes Kemenkes Kupang, tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjajaran Bandung dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Bidan PTT di Kabupaten Rote Ndao, NTT selama 9 tahun. Setelah menamatkan pendidikan Diploma III Kebidanan tahun 2001, bekerja sebagai PNS di RSUD Prof Dr W.Z Johannes Kupang, hingga saat ini. Selain sebagai PNS juga bekerja di Stikes Nusantara Kupang sebagai dosen tidak tetap. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail merrymargaritha@yahoo.com.



Yuliyani, AMd.Keb., S.KM., M.Biomed., Lahir di Nganjuk, 24 Juli 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Kedokteran Ilmu Biomedik, Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002. Saat ini penulis bekerja di Stikes Widyagama Husada Malang Prodi D3 Kebidanan, mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan KB, Anatomi Fisiologi, Parasitologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, narasumber. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yuliyani67@widyagamahusada.ac.id. Motto: *"Great woman is simple in talk but strong in action."*

Buku *Bunga Rampai: Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat* menyajikan beragam tulisan yang menyoroti kontribusi penting bidan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perannya yang tidak hanya terbatas pada layanan klinis, bidan hadir sebagai pendidik, penyuluh, dan agen perubahan di tengah masyarakat.

Melalui tujuh topik utama, buku ini mengulas peran bidan dalam berbagai bidang, seperti edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, kampanye pemberantasan malnutrisi, penyuluhan keluarga berencana, penanganan kesehatan mental ibu dan anak, hingga pelaksanaan dan edukasi program imunisasi serta penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.

Ditulis oleh para akademisi dan praktisi, buku ini bertujuan menjadi referensi ilmiah sekaligus praktis bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta para pemangku kebijakan yang peduli terhadap penguatan peran bidan dalam sistem kesehatan masyarakat. Buku ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai betapa strategisnya posisi bidan dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Buku Bunga Rampai: Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat menyajikan beragam tulisan yang menyoroti kontribusi penting bidan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perannya yang tidak hanya terbatas pada layanan klinis, bidan hadir sebagai pendidik, penyuluh, dan agen perubahan di tengah masyarakat.

Melalui tujuh topik utama, buku ini mengulas peran bidan dalam berbagai bidang, seperti edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, kampanye pemberantasan malnutrisi, penyuluhan keluarga berencana, penanganan kesehatan mental ibu dan anak, hingga pelaksanaan dan edukasi program imunisasi serta penyuluhan kesehatan reproduksi remaja.

Ditulis oleh para akademisi dan praktisi, buku ini bertujuan menjadi referensi ilmiah sekaligus praktis bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta para pemangku kebijakan yang peduli terhadap penguatan peran bidan dalam sistem kesehatan masyarakat. Buku ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai betapa strategisnya posisi bidan dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

